



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN MARET
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI	
Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	5
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	6
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	19
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik	19
3.3.2 Rawat Inap	21
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	29
3.3.4 High Care Unit (HCU)	30
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)	31
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)	33
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	34
3.4.1 Instalasi Farmasi	34
3.4.2 Laboratorium	55
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	56
3.4.4 Radiologi	63
3.4.5 Gizi	68
3.4.6 CSSD - Laundry	80
3.5 Kinerja Bidang Umum	83
3.5.1 SDM	83
3.5.2 IPSRS	94
3.5.3 Security	103
3.5.4 Parkir	106
3.5.5 Humas Marketing	107
3.5.6 Penjaminan	136
3.5.7 PIPP – MOD – MPP	137
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	145
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	146
3.5.10 IT - SIMRS	147
3.5.11 Driver	158
3.5.12 PRIMANTARA	159
3.6 Komite dan Tim	160
3.6.1 Komite Mutu	160
3.6.2 Komite PPI	190
3.6.3 Tim PKRS	206
3.6.4 Tim Prognas	207
3.6.5 Tim PPRA	248
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	255
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	257
3.8 Profil SDM	260
Bab IV Kesimpulan dan Saran	264
Bab V Penutup	265

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Maret Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



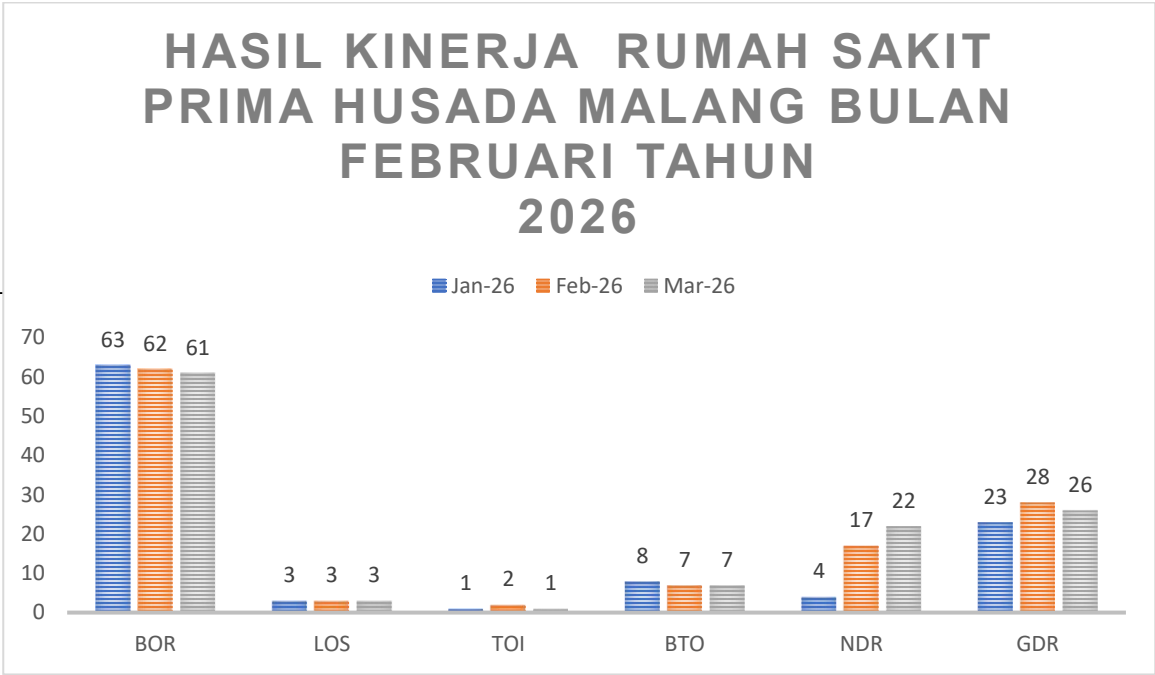
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	Jan 2026	Feb 2026	Maret 2026
BOR	63	62	61
LOS	3 hari	3 hari	3 hari
TOI	1 hari	2 hari	1 hari
BTO	8 kali	7 hari	7 hari

Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.1 Analisa

a. BOR (Bed Occupancy Rate)

Terjadi penurunan dari Januari (63%) → Februari (62%) → Maret (61%).
Nilai BOR masih dalam kategori **belum optimal** (ideal umumnya 60–85%, namun cenderung di batas bawah). Hal ini menunjukkan pemanfaatan tempat tidur belum maksimal.

b. LOS (Length of Stay)

Stabil di angka **3 hari** selama 3 bulan.
Ini menunjukkan lama rawat pasien relatif **efisien dan konsisten**, tidak ada indikasi overstay.

c. TOI (Turn Over Interval)

Fluktuatif: 1 hari → 2 hari → 1 hari.
Pada Februari terjadi peningkatan TOI, artinya tempat tidur sempat lebih lama kosong sebelum terisi kembali → indikasi penurunan efisiensi.

d. BTO (Bed Turn Over)

Menurun dari 8 kali → 7 kali → 7 kali.
Menunjukkan frekuensi penggunaan tempat tidur per periode sedikit menurun, sejalan dengan tren BOR.

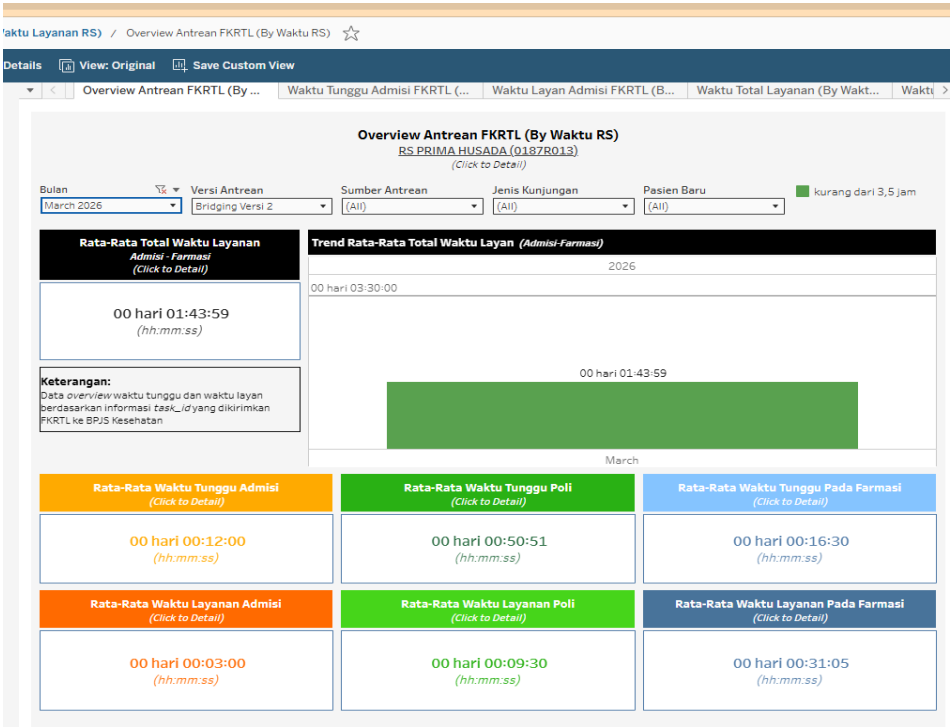
3.1.2 Masalah

1. Penurunan BOR secara bertahap
- Indikasi penurunan jumlah pasien rawat inap atau utilisasi TT kurang optimal.
2. Penurunan BTO
- Frekuensi penggunaan tempat tidur berkurang → potensi underutilization.
3. Fluktuasi TOI
- Adanya periode tempat tidur kosong lebih lama (terutama Februari).
4. Ketidakseimbangan efisiensi layanan
- LOS sudah baik, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pasien.

3.1.3 Tindak Lanjut

No	Masalah	RTL	PIC	Waktu
1	BOR menurun	Meningkatkan promosi layanan unggulan RS dan jejaring rujukan (FKTP, klinik)	Manajemen RS / Humas	Triwulan berikutnya
2	BTO rendah	Optimalisasi pemanfaatan TT dengan koordinasi antar unit (IGD, poli, rawat inap)	Kepala Ruangan	1 bulan
3	TOI fluktuatif	Mempercepat proses admisi dan discharge planning	DPJP & Perawat	Berkelanjutan
4	Jumlah pasien rawat inap menurun	Evaluasi pola kunjungan pasien dan analisis tren penyakit	Komite Mutu	Triwulan berikutnya
5	Efisiensi belum optimal	Monitoring indikator BOR, LOS, TOI, BTO secara rutin (bulanan)	Komite Mutu	Setiap bulan

3.2 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2026)						
			Rata - rata Tahun 2025	1	2	3	4	5	6
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024							

1	Total Waktu Layanan	2:12:37	01:46:32	1:46:40	1:41:56	1:43:59			
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	0:08:14	0:12:00	00:12:00	0:12:00			
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	0:06:01	0:03:00	0:03:00	0:03:00			
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	0:58:16	00:56:31	00:53:52	00:50:51			
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	0:09:55	0:10:13	0:10:01	0:09:30			
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	0:09:02	0:09:57	0:14:48	0:16:30			
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	0:36:47	0:32:48	0:36:36	0:31:05			

Analisis :
Pada bulan ini masih Lebih rendah dari rata-rata tahun 2024 dan tahun 2025. Namun ada peningkatan pada waktu tunggu farmasi yang disebabkan data waktu pelayanan resep error. Konfirmasi dari programmer.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

3.3 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.3.3 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRJA-IRNA	Peningkatan kompetensi dan skill perawat yang belum mandiri	1. Untuk perawat yang belum mandiri terkait skill phlebotomi, infus, pasang kateter dan NGT, dari komite keperawatan memfasilitasi untuk tindakan tersebut 2. Setiap perawat ada target dalam satu bulan untuk menyelesaikan prasad nya	1. Untuk saat ini, masih ada 1 pasien yang komplain karena gagal infus oleh perawat poli 2. Perawat supervisor wajib mendampingi saat tindakan 3. Pastikan pasien yang akan dilakukan tindakan bukan pasien yang potensi komplain

2	IRJA	Review Alur Peresepan Vaksin	1. Perawat input resep 2. Resep masuk dgn tagihan BPJS 3. Farmasi ubah cara bayar jadi umum 4. Simpan resep 5. Pasien pembayaran ke kasir	Selama proses perubahan alur peresepan vaksin menjadi lebih baik, sehingga monitoring stok vaksin berjalan lancar dan tidak selisih
4	IGD	Morning report	Morning report seminggu sekali dengan melihat jumlah pasien rawat jalan dan mengidentifikasi apakah ada case yang bisa di MRS kan untuk meningkatkan kunjungan	Untuk morning report saat ini dilakukan dengan telaah dokumen pasien rawat inap yang kurang dari 5 pasien/shift. telp grup dir RS, yanmed, dokter IGD dan casemix untuk mengetahui apakah ada pasien yang potensi pasien yang rawat inap
5	IKO	Rencana permintaan alat EEG	1. Mengidentifikasi diagnosa yang dirujuk dengan alasan EEG 2. Koordinasi dengan KMKB untuk perhitungan tarif EEG terutama BPJS kesehatan 3. Membuat FS (<i>feseability study</i>) alat EEG koordinasi dengan IPSRS untuk penggunaan alat dan bagian umum untuk perhitungan keuangan	Proses pengajuan FS

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien.	Dalam antrian programmer

			c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 155 e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .

			b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	
		5. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	a. Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara. b. Belum ada penanda resep obat siap dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap di SIMRS. c. Perubahan alur pendaftaran primantara oleh farmasi. a. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.
		6. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.

			kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	
		8. Pelayanan retriksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		9. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor,	Pengajuan fitur ke progamer.

			nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		10. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat"	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat" untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
		11. Ruang handrub	a. Penambahan ruang handrub pada tanggal 28 mei 2025 untuk pengisian botol cairan handrub yang habis di ruangan agar meminimalkan mikroorganisme. b. Pengisian handrub dilakukan oleh apoteker. c. Sudah dilakukan sosialisasi pengisian botol handrub oleh komite.	Monitoring dan Evaluasi.
		12. Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik	Alur pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik : a. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasien) b. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. c. Order vaksin ke gudang farmasi. d. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. e. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan	Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik

			berdasarkan kwitansi manual sebelumnya. d. Pasien melakukan suntik di poli vaksin.	
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok. 2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer. a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Rencana trial menunggu Programmer PT Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaikan sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok.	Monitoring dan Evaluasi.

			- Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi	
--	--	--	--	--

			oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstock IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstock IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstock ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstock iko. - Jumlah stok di sistem Floorstock IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan	
--	--	--	--	--

			operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi”	
--	--	--	---	--

			bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih di sistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada di depo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep	
--	--	--	--	--

			manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar	
--	--	--	--	--

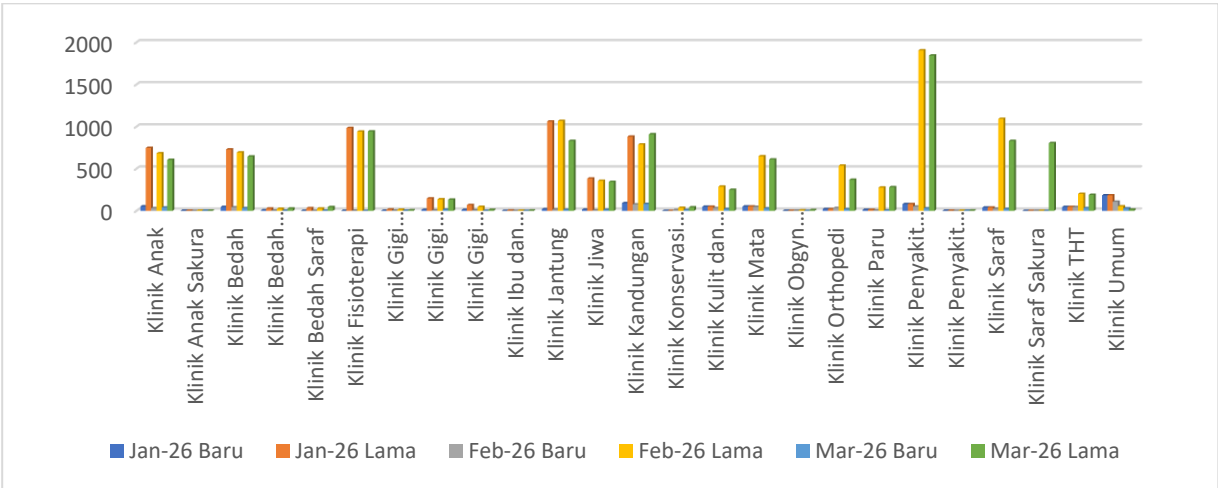
			Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Poli gizi dan kia belum menjalankan ERM	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM. 2. Beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM dalam penggunaan sistem.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Formulir rekapitulasi kegiatan pelayanan laboratorium pada SIMRS	Rekapitulasi jumlah pemeriksaan lab dengan kriteria jenis kelamin dan hasil nilai rata-rata pemeriksaan lab	Keterlambatan pengisian pada web SIRS online → Follow up ke Programmer untuk update fitur di SIMRS

3.4 Kinerja Bidang Pelayanan

3.4.3 Rawat Jalan Poliklinik

3.4.3.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

No	Nama Unit	Jan-26			Feb-26			Mar-26		
		Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
1	Klinik Anak	53	747	800	32	683	715	40	606	715
2	Klinik Anak Sakura	2	2	4	0	3	3	2	2	3
3	Klinik Bedah	47	729	776	43	693	736	32	645	736
4	Klinik Bedah Plastik	7	28	35	4	25	29	2	28	29
5	Klinik Bedah Saraf	1	33	34	0	28	28	3	45	28
6	Klinik Fisioterapi	1	984	985	2	941	943	0	943	943
7	Klinik Gigi Ortodonti	3	16	19	4	14	18	2	7	18
8	Klinik Gigi Pedodontis	13	147	160	7	137	144	14	133	144
9	Klinik Gigi Periodonti	12	70	82	8	48	56	1	12	56
11	Klinik Ibu dan Anak	0	4	4	0	3	3	0	4	3
12	Klinik Jantung	20	1061	1081	16	1067	1083	13	830	1083
13	Klinik Jiwa	15	384	399	7	357	364	12	344	364
14	Klinik Kandungan	92	881	973	77	788	865	82	909	865
15	Klinik Konservasi Gigi	0	0	0	10	37	47	10	42	47
16	Klinik Kulit dan Kelamin	50	50	100	33	288	321	21	250	321
17	Klinik Mata	52	52	104	48	648	696	29	610	696
18	Klinik Obgyn Sakura	1	1	2	2	6	8	0	9	8
19	Klinik Orthopedi	21	21	42	34	537	571	20	369	571
20	Klinik Paru	12	12	24	6	277	283	6	281	283
21	Klinik Penyakit Dalam	80	80	160	51	1905	1956	30	1844	1956
22	Klinik Penyakit Dalam Sakura	2	2	4	0	2	2	3	4	2
23	Klinik Saraf	40	40	80	26	1092	1118	22	830	1118
24	Klinik Saraf Sakura	0	0	0	1	1	2	0	804	2
25	Klinik THT	47	47	94	45	202	247	33	190	247
26	Klinik Umum	184	184	368	108	54	162	29	15	162



Analisis :

- 1. Kunjungan tertinggi : dr. Humaira Rahma Sp. OG sebesar 750 pasien
- 2. Penurunan tertinggi : drg Ega Lucida Chandra Kumala Sp.Perio sebesar 77%
- 3. Kenaikan tertinggi : dr. Aida Musyarrofah Sp. OG 216%

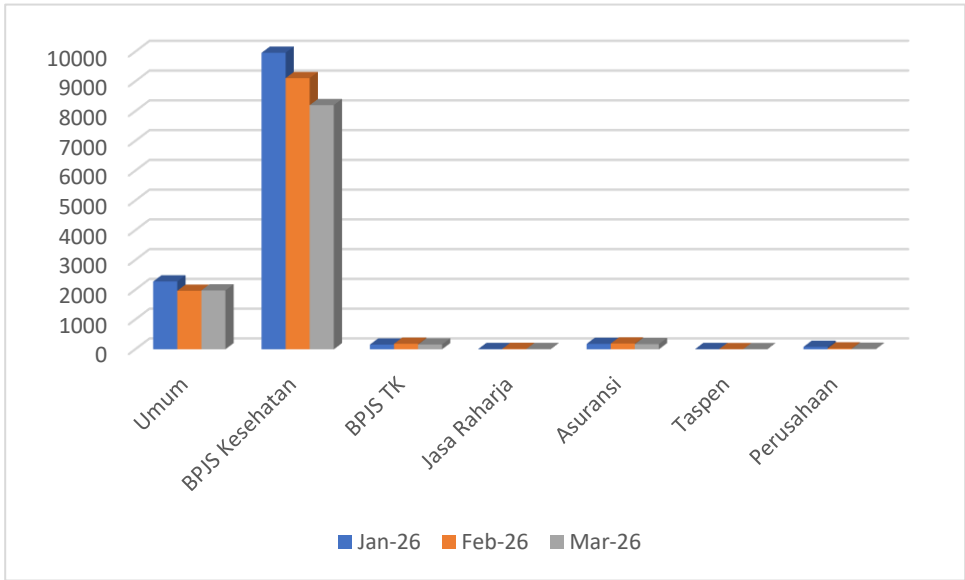
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli Sakura
- 3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

No	Jenis Pembayaran	Jan-26	%	Feb-26	%	Mei-26	%
1	Umum	2279	18%	1966	17%	1978	19%
2	BPJS Kesehatan	9966	79%	9112	79%	8204	78%
3	BPJS TK	158	1%	185	2%	161	2%
4	Jasa Raharja	9	0%	15	0%	11	0%
5	Asuransi	181	1%	194	2%	175	2%
6	Taspen	7	0%	5	0%	5	0%
7	Perusahaan	80	1%	29	0%	17	0%
TOTAL		12680	100%	11506	100%	10551	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

Kunjungan pasien baru tertinggi yaitu di instalasi gawat darurat 306 pasien diikuti dari klinik kandungan dengan jumlah pasien baru sebesar 82 pasien, untuk persentase pasien baru sebesar (7,00%), pasien lama sebesar (100,61%)

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

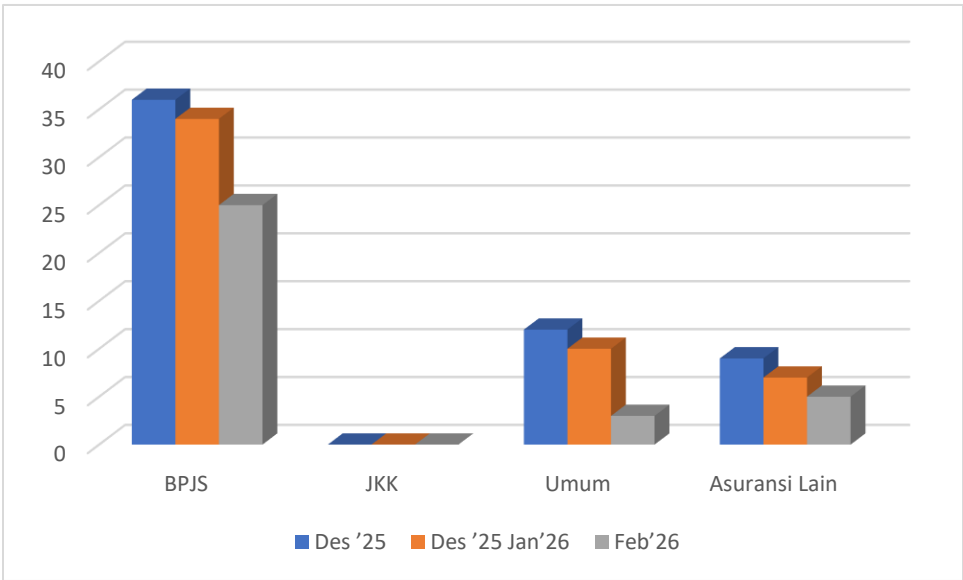
3.4.4 Rawat Inap

3.4.4.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	Hal	Jan'26	Feb'26	Mar'26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	36	34	25	↓26,47%
2	JKK	0	0	0	100%
3	Umum	12	10	3	↓70%
4	Asuransi Lain	9	7	5	↓28,57%
Total Pasien		60	57	51	↓10,52%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Jan. 2026	36	12	0	9	57
	Analisa	Bulan Januari pasien BPJS mengalami penurunan dari 49 menjadi 36	Bulan Januari pasien Umum naik dari 7 menjadi 12	Pasien JKK bulan Januari kosong. Karena tidak ada pasien JKK yg naik kelas	Untuk pasien asuransi di bulan Januari men galami penurunan karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB	Total bulan Januari jumlah pasien mengalami penurunan dari 60 menjadi 57

	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Feb. 2026	34	10	0	7	51
	Analisa	Bulan Februari pasien BPJS mengalami penurunan lagi dari 36 menjadi 34	Bulan Februari pasien Umum turun dari 12 menjadi 10	Pasien JKK bulan Februari kosong. Karena tidak ada pasien JKK yg naik kelas	Untuk pasien asuransi di bulan Februari mengalami penurunan juga karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB	Total bulan Februari jumlah pasien mengalami penurunan dari 57 menjadi 51
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	Maret 2026	25	3	0	5	33
	Analisa	Bulan Maret pasien BPJS mengalami penurunan drastis dari 34 menjadi 25	Bulan Maret pasien Umum turun drastic dari 10 menjadi 3	Pasien JKK bulan Februari kosong	Untuk pasien asuransi di bulan Maret mengalami penurunan juga karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB	Total bulan Maret jumlah pasien mengalami penurunan drastic dari 51 menjadi 33
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(Januari 2026 – Maret 2026)

NO	Hal	Januari'26	Februari'26	Maret'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	204	217	203	↓7%
2	JR	1	3	1	↓200%
3	Umum	12	4	12	↑66%
4	Asuransi Lain	4	0	0	0
Total Pasien		221	225	216	↓4%

3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

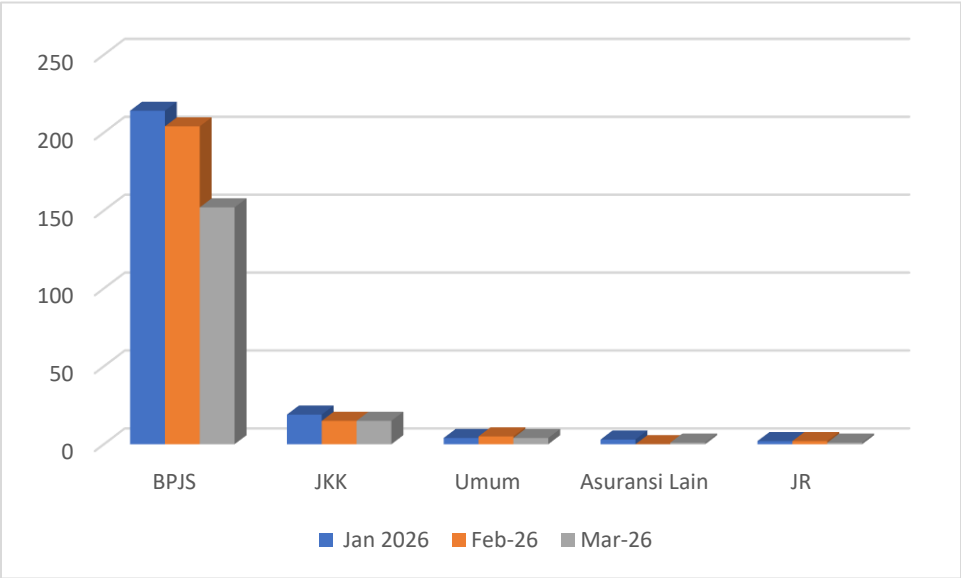
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan di bulan maret mengalami penurunan sebesar 7%	Pasien umum mengalami peningkatan sebesar 66% pada Maret	Pasien JR mengalami penurunan 200% pada bulan maret	Pasien Asuransi sama dengan bulan sebelumnya	Jumlah pasien di aBPJS di bulan Februari mengalami peningkatan sebanyak 6% dan mengalami penurunan di bulan maret sebesar 7% dan penurunan 200% pada pasien umum pada bulan february dan mengalami peningkatan 66% di bulan maret dan kenaikan 66% pasien JR pada bulan february serta mengalami penurunan sebesar 200% di bulan maret
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Persentase 2026
1	BPJS	214	204	152	25,45 %
2	JKK	19	15	15	0 %
3	Umum	4	5	4	20 %
4	Asuransi Lain	3	0	1	↑ 100 %
5	JR	2	2	1	50 %
Total Pasien		242	226	173	↓ 23,4%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.1.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

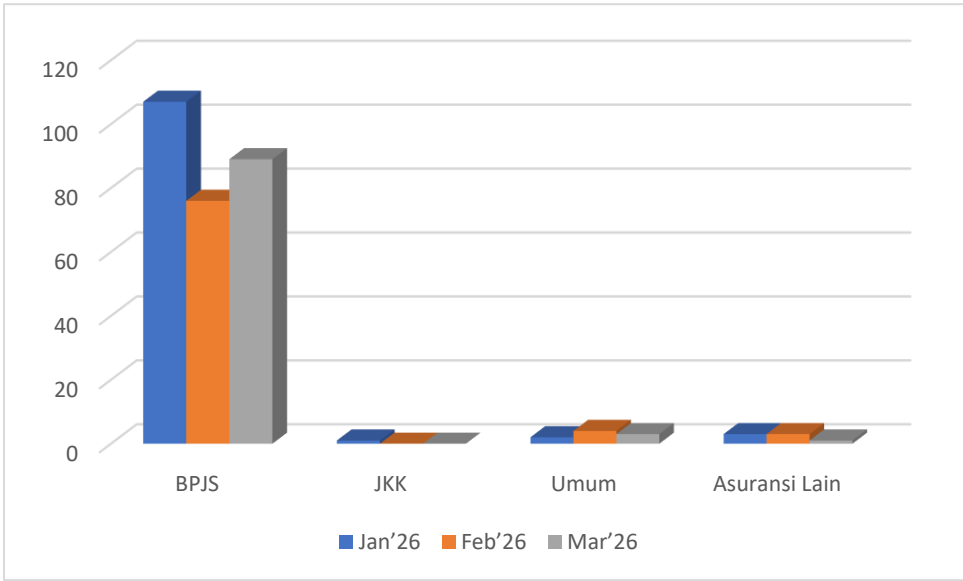
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Maret 2026	Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan Maret 2026 sebesar penurunan 25,4 %	Pasien Umum pada bulan Maret 2026 mengalami penurunan yaitu sebanyak 20 %	Jumlah Pasien JKK pada bulan Maret 2026 sama dengan bulan Februari sebanyak 0 %	Jumlah Pasien JR pada bulan Maret sama dengan bulan sebelumnya pasien asuransi mengalami kenaikan 100%	Penurunan jumlah pasien di bulan Maret 2026 menurun sebanyak 23,45 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A dikarenakan TT dilantai 2A 15 TT serta terdapat ruang transit 6. Lantai 3A dibuka jika memang disemua lantai penuh.				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Jan'26	Feb'26	Mar'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	107	76	89	↑14,60%
2	JKK	1	0	0	0
3	Umum	2	4	3	↓33,33%
4	Asuransi Lain	3	3	1	↓66,66%
Total Pasien		113	83	93	↑10,75%

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Januari 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑7,47% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑100% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami peningkatan ↑100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↑50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Januari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑11,88%
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

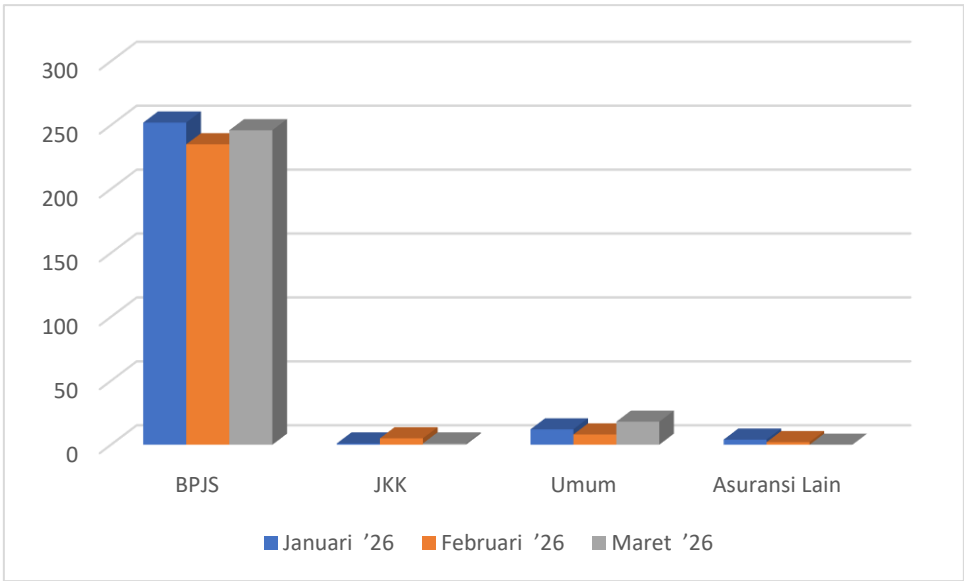
2	Analisis capaian Februari 2026	Total Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak ↓40,78% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑50% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓36,14% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Januari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami Penurunan dari bulan sebelumnya sebesar ↓36,14%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian Maret 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑14,60% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami penurunan sebanyak ↓33,33% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓66,66% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Maret 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑10,75%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Januari '26	Februari '26	Maret '26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	252	235	246	↑ 6,7%
2	JKK	1	5	1	↓ 100%
3	Umum	12	8	18	↑ 55,5%
4	Asuransi Lain	4	2	0	↓ 100%
Total Pasien		268	250	265	↑ 5,6%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

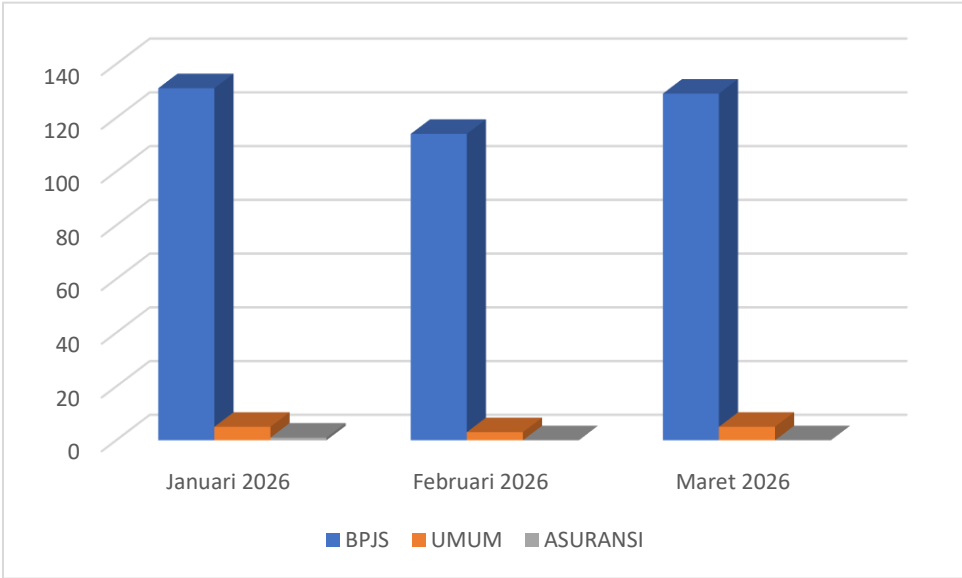
Bulan	Rawat Inap				Kesimpulan
	BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan maret 2026 yaitu sebanyak 11 pasien disebabkan meningkat dibandingakan februari hanya 28 hari	Pasien Umum mengalami peningkatan pada bulan maret 2026 yaitu sebanyak 10 pasien, terkendala pasien KLL yang tidak mengurus BPJS	Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan maret 2026 yaitu sebanyak 4 pasien	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami penurunan 100% pada bulan maret 2026	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan maret dengan jumlah pasien sebanyak 15 pasien
RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
1	BPJS	131	114	129	↓0,12%
2	UMUM	5	3	5	↑0,4%
3	ASURANSI	1	0	0	0%
Total Pasien		137	117	134	↓0,13%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

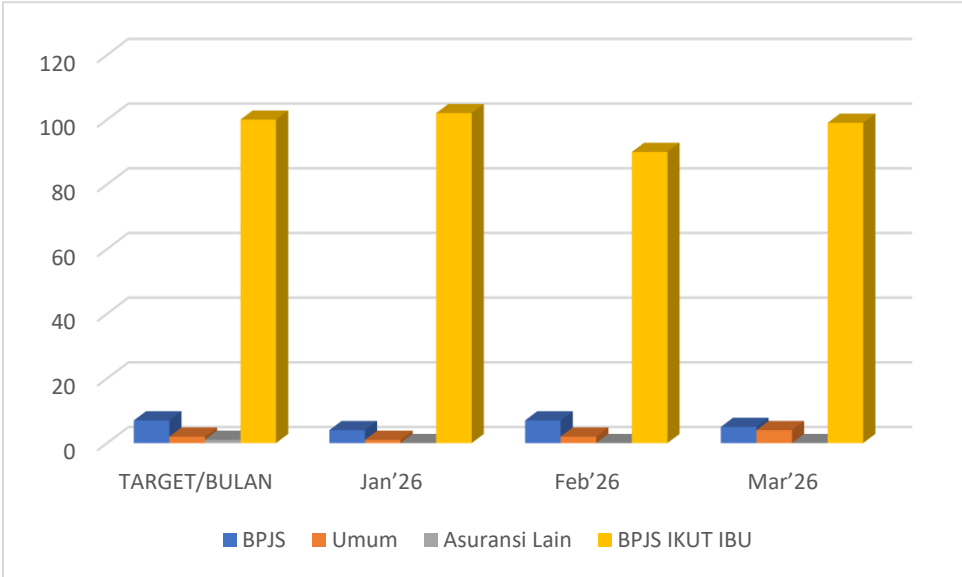
No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
	Analisis capaian Bulan Januari-Maret	Pasien BPJS pada bulan Maret mengalami Kenaikan 0,12%	Pasien umum pada bulan Maret mengalami Penurunan ↓0,4%	Tidak ada Pasien Asuransi pada bulan Maret	Kunjungan turun dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	TARGET/BULAN	Jan'26	Feb'26	Mar'26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	4	7	5	↓4,63%
2	Umum	2	1	2	4	↑3,7%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0
4	BPJS IKUT IBU	100	102	90	99	↑91,7%
Total Pasien		110	107	99	108	↑9,09%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasien
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	Januari 2026	4	1	0	102	107
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,03%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,2%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 2,68%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
2	Februari 2026	7	2	0	90	99
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 7,1%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 11,76%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
3	Maret 2026	5	4	0	99	108
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 4,63%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,7%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 91,7%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

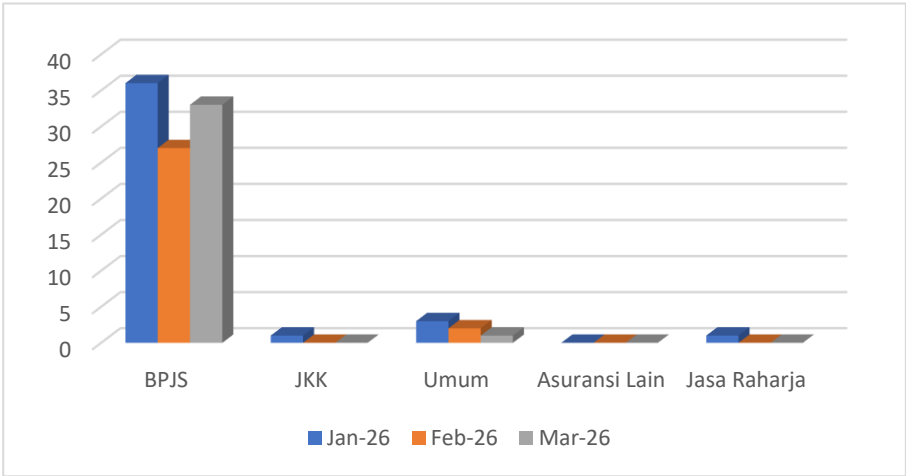
3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	Cara Bayar	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	36	27	33	↑0,22%
2	JKK	1	0	0	Tetap
3	Umum	3	2	1	↓0,5%

4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	Jasa Raharja	1	0	0	Tetap
Total Pasien		41	29	34	↑0,17%

3.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

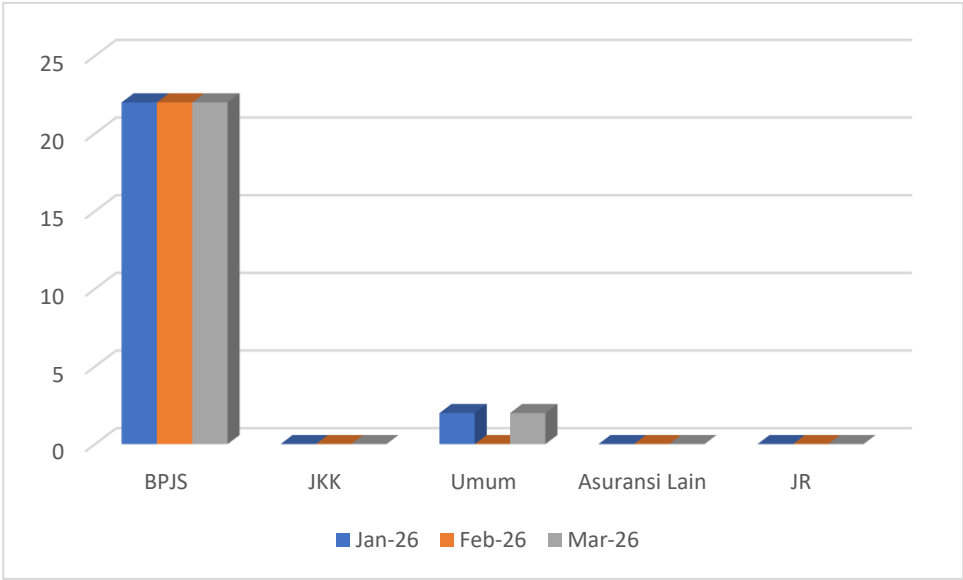
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2026 mengalami penurunan 0,22% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan 0,5% di bulan maret dibandingkan bulan dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir ada 1 di bulan januari	Tidak ada pasien penjamin asuransi lain selama 3 bulan terakhir	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami penurunan sebesar 0,17 % dibandingkan dari bulan sebelumnya.
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	22	22	22	Tetap
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	2	0	2	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		25	24	22	↑0,09%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

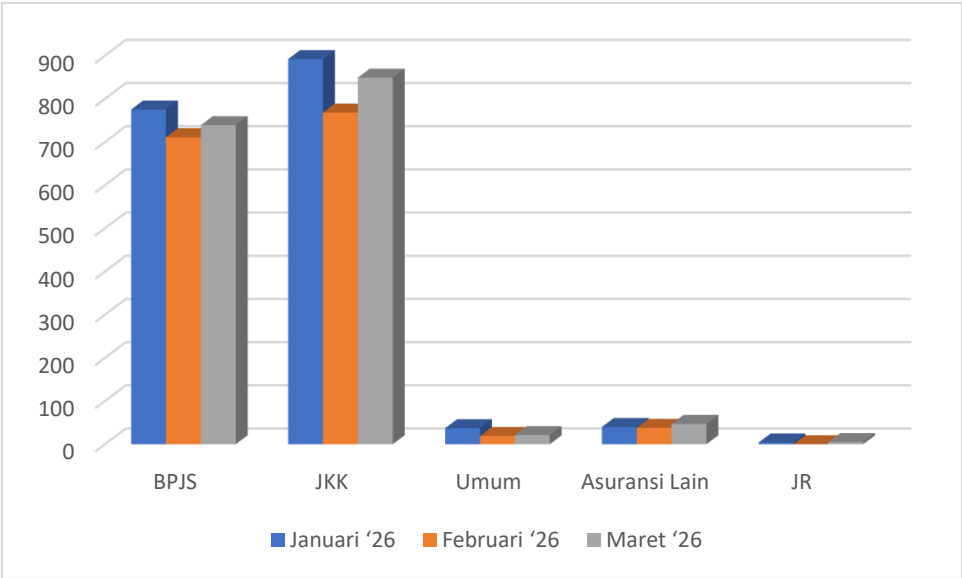
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan maret 2026 sama bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 adalah 2 pasien di bulan Maret 2026	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir	Tidak ada Pasien JR/ Asuransi bulan Maret 2026	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada menurun dari bulan sebelumnya 0,09%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Januari '26	Februari '26	Maret '26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	775	711	739	↑3,9%
2	JKK	892	768	849	↑9,5%
3	Umum	37	19	21	↑9,5%
4	Asuransi Lain	40	38	47	↑19%
5	JR	4	0	5	↑100%
Total Pasien		1.748	1.536	1.661	↑0,11 %

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

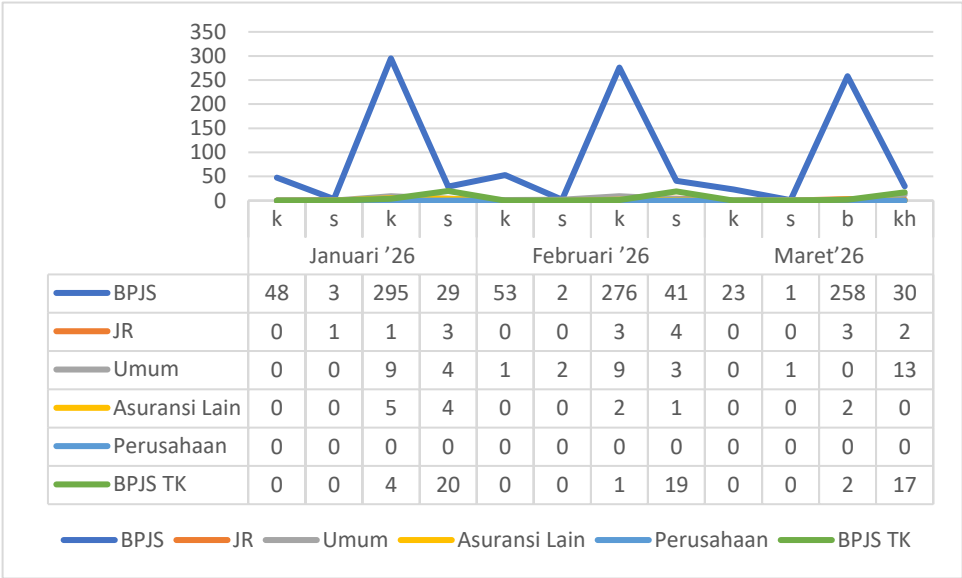
No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	Januari	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di bulan Maret mengalami peningkatan 3,9%	Kunjungan pasien UMUM dari bulan Maret mengalami peningkatan 9,5%	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK mengalami peningkatan sebanyak 9,5% dari bulan Februari 2026	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain pada bulan Maret 2026 mengalami peningkatan 19% dari bulan Februari 2026	Kunjungan pasien dengan jaminan JR bulan Maret meningkat dari bulan Februari 2026	Total kunjungan pasien IGD semua jaminan di bulan Maret 2026 mengalami peningkatan 7,5%
	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Januari 2026 – Maret 2026)

NO	HAL	Januari '26				Februari '26				Maret'26			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	48	3	295	29	53	2	276	41	23	1	258	30
2	JR	0	1	1	3	0	0	3	4	0	0	3	2
3	Umum	0	0	9	4	1	2	9	3	0	1	0	13
4	Asuransi Lain	0	0	5	4	0	0	2	1	0	0	2	0
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	4	20	0	0	1	19	0	0	2	17
Total Pasien		426				417				352			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Januari 2026 – Maret 2026)



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	Maret	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien ODC Pacho menurun karena Ramadhan pasien banyak yang menunda dilakukan tindakan.	Pasien Iridectomy menurun	Operasi besar menurun karena Ramadhan pasien banyak yang menunda dilakukan tindakan.	Operasi khusus menurun karena Ramadhan pasien banyak yang menunda dilakukan tindakan.
	RTL	Tingkatkan capaian dengan mengawal pasien-pasien yang menunda tindakan.	Meningkatkan capaian dengan sosialisasi ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Meningkatkan capaian dengan sosialisasi ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Tingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

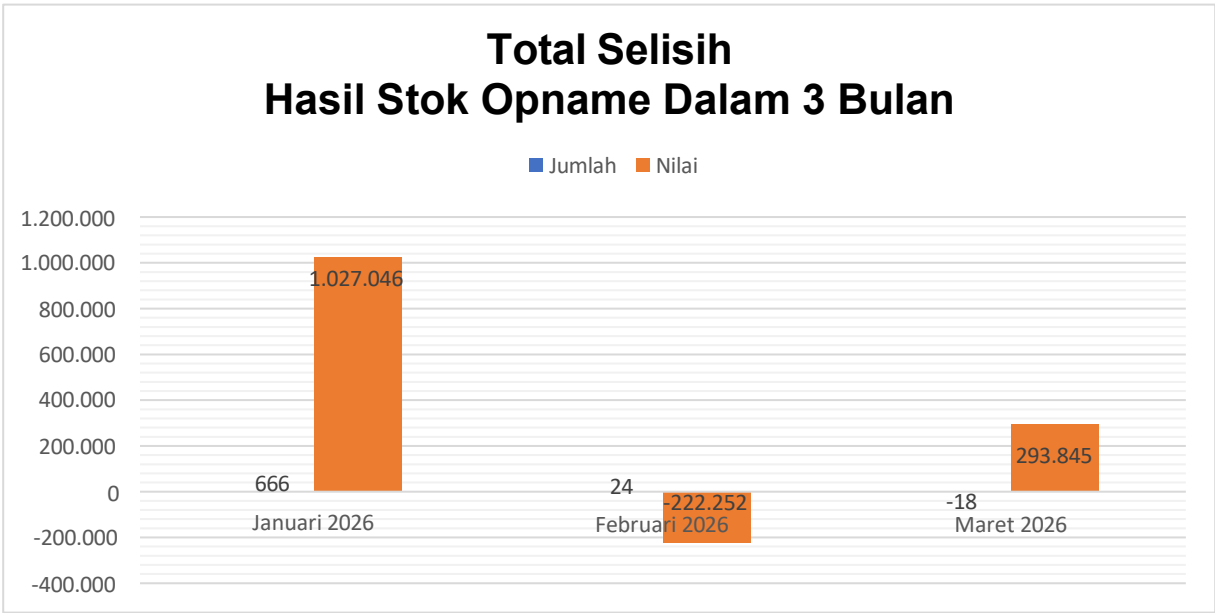
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Januari - Maret 2026

Unit	Stok	Januari 2026		Februari 2026		Maret 2026	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDANG	Fisik	1.014.860	1.930.830.190,08	858.275	1.683.188.894,52	879.268	1.797.587.675,72
	Sistem	1.014.860	1.930.830.190,08	858.275	1.683.188.894,52	879.288	1.797.587.675,72
	Selisih	0	0	0	0	-20	0
DEPO FARMA SI	Fisik	219.843	615.516.368,57	241.864	643.787.152,87	192.762	605.412.759,68
	Sistem	219.177	614.489.323	241.841	644.009.405,22	192.759	605.118.914,59
	Selisih	666	1.027.045,57	24	-222.252,35	3	293.845
IKO	Fisik	3.431	87.123.387,25	3.370	80.672.655,09	3.252	88.728.804,95
	Sistem	3.431	87.123.387,25	3.370	80.672.655,09	3.252	88.728.804,95
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		666	+1.027.046	24	-222.252	-18	293.845

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Januari - Maret 2026



3.1.1.1 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Maret - September 2026)

1. Depo Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Jan 25 – Mar 26 (Depo+IKO)
							Jan 26	Feb 26	Mar 26		
1.	F01395	Foley cath silicon no 12 - rusch	Pcs	77.000	28/02/2026	kme21c0415	5	4	3	231.000	2
2.	F00244	Diazepam rectal 10 mg / 25 ml - actavis	Pcs	17.903	30/05/2026	C2670201	0	0	1	17.903	49
3.	F00517	Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/04/2026	E24D0116A	10	10	10	109.010	12
4.	F00292	Ethambutol tab 400 mg (hibah)	Tab	0	30/05/2026	SL515	65	19	153	0	228

5.	F01314	Delta dry 10cmx2.4m - bsn	Pcs	140.400	30/06/2026	006	4	4	4	561.600	0
6.	F00527	Nimotop tab 30 mg - bayer	Tab	4.110	30/06/2026	CM24874	54	36	10	41.100	284
7.	F03236	Topsy cream 5 g	Tub	40.664	30/06/2026	F24002	2	1	3	121.992	3
8.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra - sanofi	Vial	149.625	30/06/2026	5dfn0d3	2	2	2	299.250	149
9.	F00606	Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros	Amp	1.532	30/07/2026	76803001	25	25	25	38.300	16
10.	F05100	Puspalin tab 500 mg - dipa pharmlab	Tab	2.000	30/07/2026	UX4A194	310	174	74	148.000	1.548
11.	F04472	B fluid inf 1000 ml - otsuka	Flash	175.232	30/07/2026	F78G54A	1	1	1	175.232	4
12.	F00972	Benang t-vio 5-0 v38 - triton	Pcs	85.000	30/08/2026	230801RA	7	15	8	680.000	81
13.	F00174	Cendo mydriatil 0.5 % - cendo	Btl	26.276	30/08/2026	3M50816	3	3	3	78.829	19
14.	F00395	Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma	Tab	0	30/08/2026	H4163N	0	77	102	0	1.033
15.	F00672	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/08/2026	TSJ02853	177	129	36	0	777
16.	F00695	Sanoskin oxy 30 g - interbat	Tub	422.750	30/08/2026	215	2	2	2	845.500	1
17.	F00119	Cairan inf mgso4 20% 25 ml - otsuka	Flash	4.928	30/09/2026	B82B54A	5	5	5	24.640	63
Sub Total Depo Farmasi										3.372.355	

2. Gudang Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expir ed	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga
							Jan 26	Feb 26	Mar 26	
1.	F00968	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	30/03/2026	2303490	33	33	33	2.739.000
2.	F00944	Benang t-mono 6-0 m54 - triton	Pcs	144.000	30/04/2026	230405CF	26	26	26	3.744.000
3.	F01372	Feeding tube fr no 3.5 - terumo	Pcs	19.250	30/04/2026	230520B	17	17	7	134.750
4.	F01435	Handscoon steril 8 - saveglove	Psg	3.243	30/05/2026	011102587	450	250	200	648.600
5.	F00672	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/06/2026	TSG75153	1.170	1.282	1.282	0
6.	F01413	Guedel airway 50 mm/no 00 - forsch	Pcs	10.800	30/07/2026	2114423h	5	2	2	21.600
7.	F00696	Sanprima forte kaps - sanbe	Tab	2.100	30/07/2026	CG2905	300	300	300	630.000
8.	F04497	Vaksin formening - mersi	Vial	113.526	26/07/2026	8202301002	0	0	79	8.968.554
9.	F00806	Vaksin rotateq - gsk	Vial	245.395	30/07/2026	z007996	9	9	9	2.208.555
10.	F00182	Cendo tonor mds - cendo	Pcs	6.934	30/08/2026	3TR60816	40	40	40	277.360
11.	F00695	Sanoskin oxy 30 g - interbat	Tub	422.750	30/08/2026	214	7	7	6	2.536.500
12.	F05117	Skycellflu quadrivalent - dextra medica	Vial	167.200	30/08/2026	Q0225009	11	4	10	1.672.000
Sub Total Gudang Farmasi										23.580.919

3. IKO

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expir ed	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga
							Jan 26	Feb 26	Mar 26	
1.	F01382	Foley cath 3 way no 20 - rusch	Pcs	66.150	30/03/2026	183430	10	10	10	661.500
2.	F00517	Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/04/2026	E23D0069A	4	4	10	109.010
3.	F01389	Foley cath no 18 - rusch	Pcs	19.250	30/07/2026	T21H05	5	5	5	96.250
4.	F00972	Benang t-vio 5-0 v38 - triton	Pcs	85.000	30/08/2026	230801RA	12	13	10	850.000
5.	F00944	Benang t-mono 6-0 m54 - triton	Pcs	144.000	30/09/2026	230902MA	11	10	9	1.296.000
Sub Total IKO										3.012.760
Grand Total										29.966.034

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Mar - Sep 2026)

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Maret 2026 - September 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Foley cath silicon no 12 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. 2. Diazepam rectal 10 mg / 25 ml – actavi mengatasi kecemasan, kejang. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari Klinik MS Lawang pada tanggal 27/03/2026 sebanyak 2 pcs. 3. Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica meringankan gejala myasthenia gravis, ileus paralitik, atau retensi urine pascaoperasi, serta menghilangkan efek obat bius pascaoperasi. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 amp. 4. Ethambutol tab 400 mg (hibah) untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 27/09/2025 sejumlah 308 tablet. 5. Delta dry 10cmx2.4m – bsn sebagai bantalan pelindung bagi anggota tubuh yang akan digips dan membantu proses pengeringan pada pengaplikasian gips. Penggunaan alkes death moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/03/2023 dari distributor sejumlah 3 pcs. 6. Nimotop tab 30 mg – bayer untuk pencegahan dan terapi defisit Neurologik Iskhemik yang disebabkan vasospasme serebral yang terjadi setelah pendarahan subarakhnoid akibat Aneurisma. Faktur pembelian terakhir tanggal 08/06/2025 dari distributor sejumlah 100 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 7. Topsy cream digunakan untuk anestesi topikal untuk bedah kulit superfisial, kebocoran vena pada anak-anak, mengikis moluskum contagiosum (penyakit kulit karena virus yang menimbulkan bintil keputihan dengan cekungan di tengahnya, berisi sesuatu yang menyerupai butir nasi) pada anak-anak, kauteri kondiloma akuminata, biopsi vulva/pukas. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/06/2025 dari distributor sejumlah 2 tube. 8. Vaksin vaxigrip tetra – Sanofi untuk mencegah penyakit Influenza yang disebabkan oleh 4 tipe virus influenza yaitu 2 tipe A dan 2 tipe B yang sangat mudah menular melalui air liur. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari RS PHS pada tanggal 30/01/2026 sebanyak 2 vial. 9. Phenobarbital inj 50 mg/ml – phapros untuk sedasi, status epilepticus. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 06/03/2025 dari distributor sejumlah 30 ampul. 10. Puspalin tab 500 mg - dipa pharmlab untuk kehilangan kesadaran karena kerusakan otak, cedera kepala atau bedah otak & infark serebri. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/01/2026 dari distributor sejumlah 600 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. Bisa di retur H-1 bulan mendekati kedaluwarsa. 11. B fluid inf 1000 ml – otsuka membantu memenuhi nutrisi pada pasien yang tidak mampu menyerap nutrisi di saluran pencernaannya. Penggunaan obat death moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/10/2024 dari distributor sejumlah 4 flash.	1. Sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan near ED dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ bmhp/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 6. Floorstok IKO yang slow moving di tukar dengan ED jauh.

12. Benang t-vio 5-0 v38 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/07/2024 dari distributor sejumlah 12 pcs. Proses diajukan tukar barang dengan distributor. 13. Cendo mydriatil 0.5 % - cendo untuk menghasilkan midriasis (pelebaran pupil) dan sikloplegia (kelumpuhan otot akomodasi mata) untuk keperluan prosedur diagnostik mata. Faktur pembelian terakhir tanggal 08/08/2024 dari distributor sejumlah 28 btl. 14. Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan pada tanggal 24/05/2025 sejumlah 300 tablet. 15. Rifampicin tab 450 mg (hibah) untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 07/02/2026 sejumlah 112 tablet. 16. Sanoskin oxy 30 g - interbat digunakan pada luka superfisial dan luka dalam misalnya tukak dalam tungkai. Penggunaan obat death moving karna harga mahal dan tidak bisa di klaim asuransi JKK dan JR mulai tahun 2025. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/06/2024 dari distributor sejumlah 10 tube. 17. Cairan inf mgso4 20% 25 ml – otsuka untuk mencegah dan mengendalikan kejang eklampsia pada ibu hamil dengan preeklampsia berat. Termasuk obat emergensi yang ada di trolley emergency, obat near ed dikeluarkan dari trolley emergency untuk digunakan terlebih dahulu. 18. Benang t-vio 2-0 v9 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/03/2023 dari distributor sejumlah 48 pcs. Proses tukar barang dengan distributor. 19. Benang t-mono 6-0 m54 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 07/08/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs. Proses tukar barang dengan distributor. 20. Feeding tube fr no 3.5 – terumo digunakan untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi atau makanan pada pasien yang mengalami kesulitan menelan ataupun pada pasien yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau koma. Penggunaan alat kesehatan death moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/03/2025 dari distributor sejumlah 20 pcs. 21. Handscoon steril 8 – saveglove digunakan untuk tindakan steril. Faktur pembelian terakhir tanggal 21/11/2025 dari distributor sejumlah 200 psg. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 22. Guedel airway 50 mm/no 00 – forsch digunakan untuk mempertahankan saluran napas tetap terbuka. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor tanggal 08/01/2026 sebanyak 5 pcs. Bisa di retur H-1 bulan mendekati kedaluwarsa. 23. Sanprima forte kaps – sanbe nfeksi saluran kemih (UTI); Bronkitis akut/menahun; Otitis media; Shigellosis, gastroenteritis; Infeksi saluran empedu; Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) terapi & profilaksis; Infeksi kulit & jaringan lunak. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 29/11/2022 dari distributor sejumlah 400 tablet. 24. Vaksin formening – mersi untuk vaksin meningitis. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari RS PHS pada tanggal 27/03/2026 sebanyak 79 vial.	
--	--

	25. Vaksin rotateq – gsk untuk mencegah infeksi saluran cerna akibat 5 strain Rotavirus (Pentavalen) yang menular lewat makanan terkontaminasi. Faktur pembelian terakhir tanggal 12/09/2025 dari distributor sejumlah 10 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 26. Cendo tonor mds – cendo untuk pengobatan glaukoma sudut terbuka kronis dan hipertensi okular. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/02/2024 dari distributor sejumlah 200 pcs. 27. Skycellflu quadrivalent - dextra medica untuk vaksin influenza. Faktur pembelian terakhir tanggal 02/04/2026 dari distributor sejumlah 10 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 28. Foley cath 3 way no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/06/2024 dari distributor sejumlah 20 pcs. 29. Foley cath no 18 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/04/2025 dari distributor sejumlah 10 pcs.	
--	--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter

2	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah Tenaga Vokasi Farmasi/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

6	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Maret 2026

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	16	199	0	0	1	216
	Jumlah Resep Obat Jadi	404	6274	0	325	41	7044
	Jumlah Resep Obat	420	6473	0	325	42	7260
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	110	25	0	0	0	135
	Jumlah Resep Obat Jadi	1320	2159	1	144	20	3644
	Jumlah Resep Obat	1430	2184	1	144	20	3779
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	227	1263	0	0	0	1490
	Jumlah Resep Obat Jadi	1078	6355	0	253	12	7698
	Jumlah Resep Obat	1305	7618	0	253	12	9188
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	28	947	0	75	15	1065
	Jumlah Resep Obat	28	947	0	75	15	1065
TOTAL		3183	17.222	1	797	89	21.292

3.2.1.8 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari - Maret 2026

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Jan 26	Feb 26	Mar 26	
1	Pengkajian resep	100%	98,95%	99,47%	98,87%	Jumlah pengkajian resep yaitu Januari 2026 = 24.084 Februari 2026 = 22.472 Maret 2026 = 21.292 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu Januari 2026 = 254 Februari 2026 = 118 Maret 2026 = 240
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan

						dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	1	1	0	Terdapat kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Tidak ada visite ronde besar
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	29	12	39	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

Analisa :

1. Pengkajian resep :
Penulisan resep yang lengkap bulan Maret 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Februari 2026 sebanyak 99,47% dan bulan Maret 2026 sebanyak 98,87%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep :
 - Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS.
 - Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 240 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.
 - Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.
2. Dispensing Sediaan Steril
 - Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten. Apoteker yang memiliki sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik tersertifikasi kemenkes yaitu 1 orang. Sedangkan Apoteker, TTK, bidan, dan perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan obat steril non sitostatika di pelatihan internal.
 - Tersedia bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF.

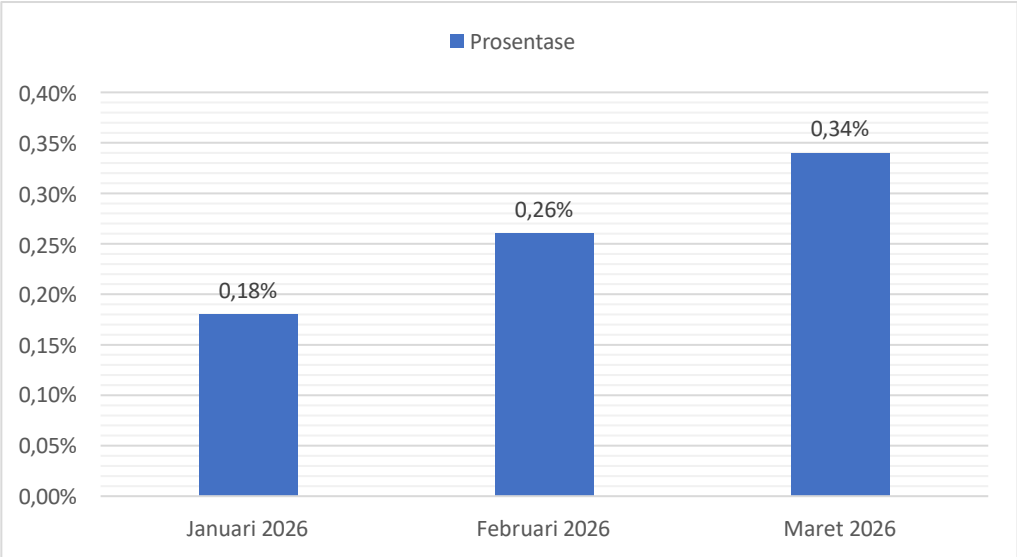
-
- Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
- Kebersihan ruangan dispensing sediaan obat non steril dan obat steril selalu terjaga. Petugas melakukan desinfeksi sebelum melakukan dispensing obat non steril dan obat steril. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl. Tata letak ruang sudah di sekat dimana terdapat ruang persiapan dan ruang ganti APD, ruang antara, dan ruang steril (ada alat UV ruangan, pass box, LAF)
 - Pencampuran obat IV dilakukan di LAF dengan dilengkapi APD sesuai ketentuan setiap pukul 13.00 WIB, untuk resep obat injeksi sore dan malam. Tidak ditemukan keterlambatan pengiriman obat ke ruangan.
3. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
Tersedia bukti pelaksanaan Pemantauan Terapi Obat dan sudah terisi lengkap oleh apoteker sesuai kriteria PTO.
 4. Kejadian Efek Samping Obat
 - Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Januari 2026 ditemukan terjadinya efek samping obat yaitu Nospirinal tab pasien mengeluhkan gatal, sesak, bengkak.
 - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.
 5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga
 - Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi.
 - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.
 6. Konseling
Pelaksanaan konseling sudah dilakukan pada pasien di rawat jalan dan/ataupun rawat inap yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis. Apoteker memanggil pasien, identifikasi, menyerahkan obat dan edukasi. Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
 7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
 8. Visite Ronde Besar
Visite ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan waktu visite DPJP dan tenaga kesehatan lainnya tidak secara bersamaan.
 9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik
Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya medication error dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap
 10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
 11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien Januari 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Desember 2025 sebanyak 22 dan bulan Januari 2026 sebanyak 29. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyediaan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.

Tindak lanjut :

1. Pengkajian resep :
 - Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi.
 - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
 - Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
2. Dispensing Sediaan Steril
 - Pelatihan penyiapan obat IV dan teknik aseptik tahun 2025 target peserta Apoteker, TTK, Perawat, Bidan di laksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.
 - Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo farmasi, gudang farmasi, dan ruang pencampuran obat (LAF) oleh apoteker setiap hari.
 - Supervisi Kains secara berkala dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik
3. Pemantauan Terapi Obat (PTO) : supervisi secara berkala
4. Kejadian Efek Samping Obat
 - Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
 - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
 - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
 - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
 - Menganalisa laporan ESO.
 - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
 - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
 - Konsul ke DPJP terkait keluhan pasien dan advice DPJP obat di stop.
5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
6. Konseling : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan konseling di rawat inap dan rawat jalan.
7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
8. Visite Ronde Besar
Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan visite pasien di rawat inap.
10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
 - Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
 - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
 - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada					
No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/01/2026-31/01/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	1/01/2026-31/1/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	29/01/2026-31/1/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramivex 0.25 mg
Total prosentase Januari 2026 = 0.18%					
1	1/02/2026-28/02/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	1/02/2026-28/02/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	1/02/2026-28/02/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramivex 0.25 mg
4	23/02/2026-25/02/2026	Hydrochlorotiazide tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Februari 2026 = 0.27%					
1	01/03/2026-31/03/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/03/2026-31/03/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/03/2026-31/03/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
4	01/03/2026-31/03/2026	Pramivex 0.25 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
Total prosentase Maret 2026 = 0.34%					

1.2.1.11 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Januari – Maret 2026



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok Pramivex 0,125 mg dan Pramivex 0.25 mg di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.12 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Maret 2026

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	-	-	-	Tidak ada BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Maret 2026

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut
1	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP

3	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi. Form monitoring suhu depo farmasi dan ruang pencampuran obat : https://drive.google.com/drive/folders/1XYh_AQhMkHwhOGCJ76IK4TQ4sewn7MHR Form monitoring suhu Gudang farmasi : https://drive.google.com/drive/folders/1Afz8-tngWZOA01zotU7Ju6TrzEje6OMF	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari						
4	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 1 pada Bulan Januari Tahun 2026 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : <table><tr><td>No</td><td>Temuan obat near ED < 6 bulan</td><td>Pergantian obat near ED</td></tr><tr><td>1</td><td>Box emergency poli lantai 1: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26</td><td>1) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 9/28 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27</td></tr></table>	No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1	Box emergency poli lantai 1: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 9/28 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED							
1	Box emergency poli lantai 1: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 9/28 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27							
		<table><tr><td></td><td>7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 7/26 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 11/25 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 7/28 12) Iv Cannul (1 buah) ED 06/28</td><td>7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 6/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 10/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 06/30 12) Iv Cannul (1 buah) ED 01/30</td></tr><tr><td>2</td><td>Box emergency poli treadmill: 1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah)</td><td>1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah)</td></tr></table>		7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 7/26 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 11/25 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 7/28 12) Iv Cannul (1 buah) ED 06/28	7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 6/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 10/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 06/30 12) Iv Cannul (1 buah) ED 01/30	2	Box emergency poli treadmill: 1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah)	1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah)	dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan. d. Tidak ada obat near ED < 6 bulan.
	7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 7/26 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 11/25 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 7/28 12) Iv Cannul (1 buah) ED 06/28	7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 6/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 10/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 06/30 12) Iv Cannul (1 buah) ED 01/30							
2	Box emergency poli treadmill: 1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah)	1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah)							

			ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	
		3	Box emergency poli lantai 2: 1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Amiodarone inj (4 amp) ED 01/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Amiodarone inj (4 amp) ED 01/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	
		4	Box emergency poli vaksin: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 -> 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Infus asering (1 buah) ED 9/27	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 -> 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Infus asering (1 buah) ED 9/27 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26 -> 9/27	
			6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26 -> 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Infus NS 0.9% (1 buah) ED 7/26 -> 7/28 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Infus Kaen 3B (1 amp) ED 07/26 -> 11/27	7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Infus NS 0.9% (1 buah) ED 7/26 -> 7/28 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Infus Kaen 3B (1 amp) ED 07/26 -> 11/27	
		5	Trolley emergency IGD: 1) Iv Cannul 20 (1 amp) ED 09/19 -> 06/29 2) Valisanbe inj (1 buah) ED 11/26 -> 11/27 3) Spuiit 10cc (1 buah) ED 06/27 -> 06/30	1) Iv Cannul 20 (1 amp) ED 09/19 -> 06/29 2) Valisanbe inj (1 buah) ED 11/26 -> 11/27 3) Spuiit 10cc (1 buah) ED 06/27 -> 06/30	
		6	Box emergency infant Ponek IGD: 1) Dexamethasone inj (1 amp) ED 6/26 -> 10/27	1) Dexamethasone inj (1 amp) ED 6/26 -> 10/27	

			2) Handscoon (1 buah) ED 5/26 -> 8/26 3) WI (1 buah) ED 05/26 -> 08/27	2) Handscoon (1 buah) ED 5/26 -> 8/26 3) WI (1 buah) ED 05/26 -> 08/27	
		7	Box HPP – Eklamsi IGD: 1) As. tranexamat (2 amp) ED 6/26 -> 3/28 2) Infus NS 0,9% (1 buah) ED 6/26 -> 12/27 3) WI (1 buah) ED 05/26 -> 08/27	1) As. tranexamat (2 amp) ED 6/26 -> 3/28 2) Infus NS 0,9% (1 buah) ED 6/26 -> 12/27 3) WI (1 buah) ED 05/26 -> 08/27	
		8	Kit emergency IGD 1: 1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 3) Mayo putih (1 buah) ED 08/26 -> 03/28 4) Iv cannul no 22 (1 buah) ED 07/26 -> 10/30	1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 3) Mayo putih (1 buah) ED 08/26 -> 03/28 4) Iv cannul no 22 (1 buah) ED 07/26 -> 10/30	
		9	Kit emergency IGD 2: 1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 3) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/272) 4) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 5) MgSO4 (2 buah) ED 09/26 -> 10/27	1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 3) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/272) 4) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 5) MgSO4 (2 buah) ED 09/26 -> 10/27	
		10	Box emergency ambulance: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 11/26 -> 4/27 2) Nospirinal (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 -> 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 -> 9/28 6) CPG (5 tab) ED 08/27 -> 11/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Dexamethasone inj (1 amp) ED 06/26 -> 10/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Amiodarone (1 amp) ED 6/26 -> 6/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 11/29 12) Iv Cannul no 22 (1	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 11/26 -> 4/27 2) Nospirinal (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 -> 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 -> 9/28 6) CPG (5 tab) ED 08/27 -> 11/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Dexamethasone inj (1 amp) ED 06/26 -> 10/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Amiodarone (1 amp) ED 6/26 -> 6/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 11/29 12) Iv Cannul no 22 (1	

			buah) ED 01/29 13) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 10/26 -> 12/27 14) lidokain (3 buah) ED 10/26 -> 10/30 15) Infuset (1 buah) ED 7/26 -> 12/27 16) Spuit 10 cc (2 buah) ED 01/29 -> 06/30 15) Spuit 5 cc (2 buah) ED 12/27 -> 10/29 17) Spuit 3 cc (2 buah) ED 12/27 -> 04/30 18) Spuit 1 cc (2 buah) ED 11/27 -> 1/30	buah) ED 01/29 13) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 10/26 -> 12/27 14) lidokain (3 buah) ED 10/26 -> 10/30 15) Infuset (1 buah) ED 7/26 -> 12/27 16) Spuit 10 cc (2 buah) ED 01/29 -> 06/30 15) Spuit 5 cc (2 buah) ED 12/27 -> 10/29 17) Spuit 3 cc (2 buah) ED 12/27 -> 04/30 18) Spuit 1 cc (2 buah) ED 11/27 -> 1/30	
		11	Trolley emergency IKO: Tidak ada near ED	-	
		12	Box emergency infant IKO: Tidak ada near ED	-	
		13	Box HPP-Eklamsi IKO: As. Tranexamat (3/26), Misoprostol (11/25), Kondom (3/26), Cairan WFI (5/26), Calcii gluconas (4/26), MgSO4 20 % (6/25), MgSO4 40% (5/25), Jarum no. 23 (8/26)	As. Tranexamat (10/26), Misoprostol (3/26), Kondom (12/26), Cairan WFI (9/26), Calcii gluconas (3/27), MgSO4 20 % (9/26), MgSO4 40% (11/26), Jarum no. 23 (11/27)	
		14	Box emergency 2C:		
			Amiodarone (9/25), dexametasone (5/25), Dopamine (9/25), valisanbe (3/25), Infus D5% (7/25) Infus gelafusal (6/25)	Amiodarone (6/26), Dexametasone (6/26), Dopamine (9/26), valisanbe (6/26), Infus D5% (11/26), Infus gelafusal (4/27)	
		15	Box emergency ICU: Amiodarone (11/25), Dopamine (9/25), Phenytoine (7/25), Infus D5% (7/25)	Amiodarone (5/26), Dopamine (9/26), Phenytoin (9/27), Infus D5% (11/26)	
		16	Box emergency ICU ventilator: Dexametasone (5/25), Norepinephrine (6/25).	Dexametasone (6/26), Norepinephrine (4/26).	
		17	Box emergency HCU: Amiodarone (8/25), Dopamine (9/25), Infus D5% (7/25), Spuit 1cc (8/25)	Amiodarone (6/26), Dopamine (9/26), Infus D5% (11/26), Spuit 1cc (5/29)	

		18	Box emergency 3C anak: Amiodarone (8/25), Dopamine (9/25), furosemide (9/25), infus D5 (7/25), Iv cannula no. 20 (10/25)	Amiodarone (6/26), Dopamine (2/26), furosemide (6/26), Infus D5% (11/26), Iv cannula no. 20 (6/26)
		19	Box emergency PICU Ventilator: Tidak ada obat near ED	-
		20	Box emergency PICU: ISDN (5/25), Ephineprine (10/25), Dexametasone (8/25), suction cath no. 8 (10/25)	ISDN (8/26), Ephineprine (8/26), Dexametasone (6/26), Suction cath no. 8 (2/28) - BE PICU Ventilator :
		21	Box emergency 2A: Tidak ada obat near ED	-
		22	Box emergency 3A: Amiodarone (9/25), Dexametasone (8/25), Dobutamine (8/25), Furosemide (9/25), Na phenytoin (7/25), Dopamine (9/25), Infus D5 (9/25), Clopidogrel (12/25)	Amiodarone (6/26), Dexametasone (6/26), Dobutamine (11/27), Furosemide (6/26), Na Phenytoin (9/27), Dopamine (2/26), Infus D5% (11/26), Clopidogrel (10/26)
		23	Box emergency 4A: Dobutamin (10/25), Dopamine (11/25), Dexametasone (6/25), Furosemide (9/25), Manitol (9/25)	Dobutamine (11/27), Dopamine (9/26), Dexametasone (6/26), Furosemide (6/26), Manitol (6/26)
		24	Box emergency infant Maternitas:	

			Tidak ada obat near ED	-	
		25	Trolley emergency Maternitas: Sput 3 cc (10/25), Blood set (8/25), Sput 20 cc (7/25), Oxyflow dewasa (10/25)	Sput 3 cc (6/29), Blood set (7/29), Sput 20 cc (10/29), Oxyflow dewasa (11/29)	
		26	Box emergency infant Perinatologi: tidak ada obat near ED	-	
		27	Box emergency 5C: Infus D5% (9/25), infus gelafusal (9/25), amiodarone (11/25), clopidogrel (11/25), dexamethasone (10/25), dopamin (4/26), ephineprine (8/25), na. phenytoin (7/25), furosemide (9/25), atropine sulfate (11/26), manitol (1/26)	Infus D5% (11/26), infus gelafusal (4/27), amiodarone (6/26), clopidogrel (10/26), dexamethasone (6/26), dopamin (9/26), ephineprine (7/27), na. phenytoin (9/27), furosemide (6/26), atropine sulfate (4/27), manitol (6/26)	
		28	Box emergency 6A: Infus D5% (7/25), Manitol (5/25), Dexametasone (6/25)	Infus D5% (11/26), Manitol (1/26), Dexametasone (6/26)	
		29	Box emergency 7A: Dexametasone (6/25), atropin sulfate (11/25), Infus D5% (8/25)	Dexametasone (6/26), Atropin sulfate (4/27), Infus D5% (11/26)	
		30	Box emergency 8A: Ephinephrine (8/25), sput 10 cc terumo (10/25), sput 3 cc terumo (10/25)	Ephinperine (7/27), Sput 10 cc terumo (6/29), Sput 3 cc terumo (6/29)	
		31	Box emergency Radiologi: Amiodaron (8/25), Aspilet (11/25), Atropin (11/26), Clopidogrel (2/26), Dexametason (10/25), Dopamine (9/25), Furosemide (9/25), Infus D5% (9/25), Manitol (1/26), Na phehytoin inj (1/26), Valisanbe Inj (12/25), IV cannula no. 22 (1/26)	Amiodarone (6/26), Aspilet (8/26), Atropin (4/27), Clopidogrel (10/26), Dexametason (6/26), Dopamine (9/26), Furosemide (6/26), Infus D5% (11/26), Manitol (6/26), Na phehytoin inj (9/27), Valisanbe Inj (6/26), IV cannula no. 22 (1/29)	
5	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.			- Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap

			menuliskan pada kartu stok - Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	- Ditemukan perawat menyimpan sisa infus NS 0.9% dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam

3.2.2. Laboratorium

Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	Target	Jan 26	%	Feb 26	%	Mar 26%	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1950	1684		1506	<8,7%	1427	<5,2%
FAAL HEMOSTASIS	716	817		733	< 9,9%	710	<3,1%
HEMATOLOGI LAIN	1	2		4	>50%	0	
URINALISIS	418	272		261	4,04%	232	<11,1%
ANALISA FEACES	30	7		14	>50%	22	>36,3%
FUNGSI HATI	611	393		278	2,89%	281	>1,0%
LEMAK DARAH	806	781		740	5,4%	744	>0,5%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1590		1394	>18,0%	1257	>9,8%
GULA DARAH	1187	2372		2120	>10,6%	2080	<1,18%
JANTUNG	583	629		500	<20,5	515	>2,9%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	230		196	<14,7	176	<10,2%
IMUNO SEROLOGI	481	216		171	<20,8	137	<19,8%
REMATIK	6	5		8	<37,5	4	<50%
ENDOKRINOLOGI	60	58		71	13%	44	<38,0
REPRODUKSI	44	98		60	<38,7%	47	<21,6
MIKROBIOLOGI	32	63		34	<31,8	43	>20,9
Jumlah	8654	9217		8090	<12,55	7719	<4,5%

Analisis :

Jumlah Pemeriksaan Pada bulan Februari mengalami penurunan sebanyak 4,8% dari bulan Februari dengan 7719 pemeriksaan Laboratorium

Rencana Tindak Lanjut :

Tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke pada pasien khususnya pasien Laboratorium

1.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Maret 2026

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
1	-				

Analisis :

Tidak ditemukan sampel darah yang rusak

Rencana Tindak Lanjut :

-

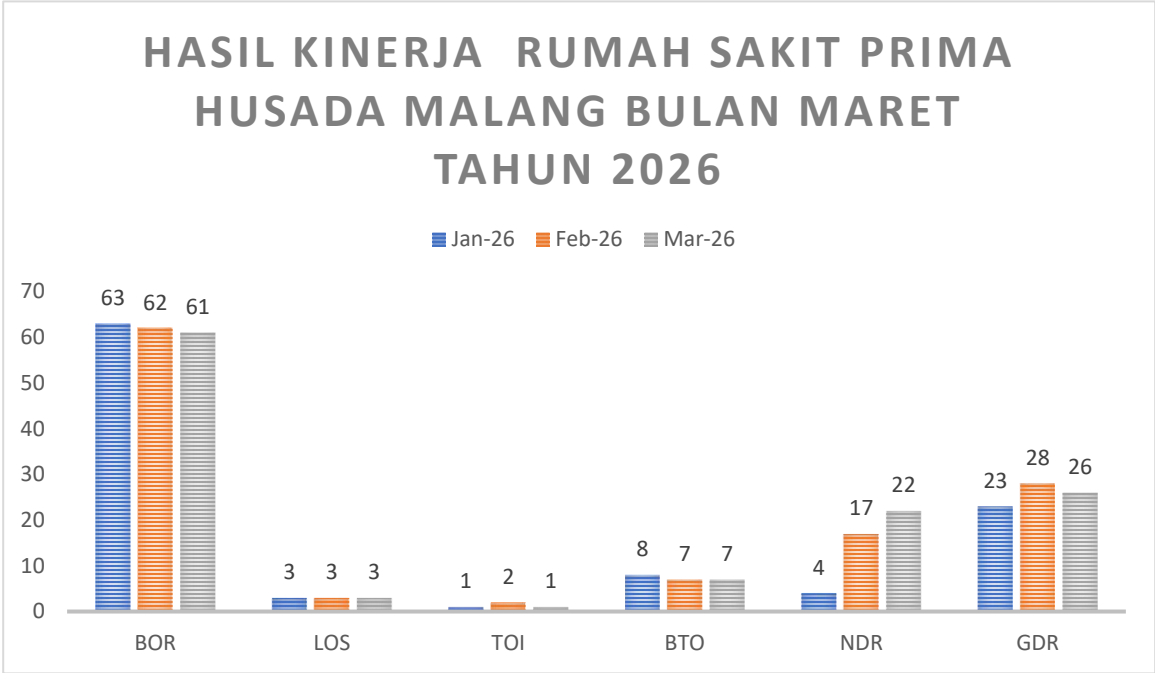
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Maret 2026

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT 2C	LT 2A	LT 3A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	Januari 26	60	48	18	56	66	57	66	65	65	66	16	47	32	63
					Februari 26	60	46	13	65	72	54	74	77	80	65	52	57	26	62
					Maret 26	44	59	0	60	54	56	70	59	62	63	32	56	27	61
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Januari 26	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	5	4	3
					Februari 26	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3
					Maret 26	3	4	0	2	3	3	3	3	3	2	3	4	5	3
3TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Januari 26	2	3	14	2	1	2	2	1	1	1	17	6	9	1
					Februari 26	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	3	2	5	2
					Maret 26	3	1	0	1	1	1	0	1	1	0	10	0	6	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	Januari 26	6	5	2	8	9	7	7	8	7	10	2	3	2	8
				(dalam hitungan bulan)	Februari 26	6	5	1	6	8	6	8	8	8	9	5	5	4	7
					Maret 26	5	5	0	8	6	6	8	7	7	11	2	4	3	7

NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati} > 48 \text{ jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25%	Januari 26	0	0	0	0	7	9	0	0	11	0	0	0	59	4
					Februari 26	21	0	0	0	16	21	10	0	0	0	276	300	0	17
					Maret 26	0	0	0	0	10	32	22	0	23	0	0	0	684	22
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45%	Januari 26	0	33	0	0	7	27	12	21	23	7	0	500	471	23
					Februari	21	0	0	0	16	31	21	0	11	0	379	600	111	28
					Maret 26	0	0	0	0	10	32	22	12	23	0	842	0	0	26

3.1.1.1 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Maret 2026



Indikator	Jan 2026	Feb 2026	Maret 2026
BOR (Bed Occupancy Rate)	63	62	61
LOS (Length of Stay)	3 hari	3 hari	3 hari
TOI (Turn Over Interval)	1 hari	2 hari	1 hari
BTO (Bed Turn Over)	8 kali	7 hari	7 hari

1. Analisa

a. BOR (Bed Occupancy Rate)

Terjadi penurunan dari Januari (63%) → Februari (62%) → Maret (61%).
Nilai BOR masih dalam kategori **belum optimal** (ideal umumnya 60–85%, namun cenderung di batas bawah). Hal ini menunjukkan pemanfaatan tempat tidur belum maksimal.

b. LOS (Length of Stay)

Stabil di angka **3 hari** selama 3 bulan.
Ini menunjukkan lama rawat pasien relatif **efisien dan konsisten**, tidak ada indikasi overstay.

c. TOI (Turn Over Interval)

Fluktuatif: 1 hari → 2 hari → 1 hari.
Pada Februari terjadi peningkatan TOI, artinya tempat tidur sempat lebih lama kosong sebelum terisi kembali → indikasi penurunan efisiensi.

d. BTO (Bed Turn Over)

Menurun dari 8 kali → 7 kali → 7 kali.
Menunjukkan frekuensi penggunaan tempat tidur per periode sedikit menurun, sejalan dengan tren BOR.

2. Masalah

a. Penurunan BOR secara bertahap
 - Indikasi penurunan jumlah pasien rawat inap atau utilisasi TT kurang optimal.

b. Penurunan BTO
 - Frekuensi penggunaan tempat tidur berkurang → potensi underutilization.

c. Fluktuasi TOI
 - Adanya periode tempat tidur kosong lebih lama (terutama Februari).

d. Ketidakseimbangan efisiensi layanan
 - LOS sudah baik, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pasien.
3. Tindak Lanjut
- | No | Masalah | RTL | PIC | Waktu |
|----|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 1 | BOR menurun | Meningkatkan promosi layanan unggulan RS dan jejaring rujukan (FKTP, klinik) | Manajemen RS / Humas | Triwulan berikutnya |
| 2 | BTO rendah | Optimalisasi pemanfaatan TT dengan koordinasi antar unit (IGD, poli, rawat inap) | Kepala Ruangan | 1 bulan |
| 3 | TOI fluktuatif | Mempercepat proses admisi dan discharge planning | DPJP & Perawat | Berkelanjutan |
| 4 | Jumlah pasien rawat inap menurun | Evaluasi pola kunjungan pasien dan analisis tren penyakit | Komite Mutu | Triwulan berikutnya |
| 5 | Efisiensi belum optimal | Monitoring indikator BOR, LOS, TOI, BTO secara rutin (bulanan) | Komite Mutu | Setiap bulan |
- 3.1.1.2 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Maret 2026
- | NO | CODE ICD 10 | DIAGNOSIS | JUMLAH |
|----|-------------|---|--------|
| 1 | E11.4 | With neurological complications | 407 |
| 2 | E11.9 | DM Tanpa komplikasi / Without complications | 321 |
| 3 | I25.9 | Chronic ischemic heart disease, unspecified | 225 |
| 4 | I11.9 | HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 212 |
| 5 | I63.9 | CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified | 201 |
| 6 | I51.9 | Decomp Cordis / Heart disease, unspecified | 192 |
| 7 | K04.1 | Necrosis of pulp | 178 |
| 8 | K80.8 | Other cholelithiasis | 177 |
| 9 | F41.2 | Mixed anxiety and depressive disorder | 165 |
| 10 | R10.4 | Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain | 154 |
- 3.1.1.1 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Maret 2026
- | NO | KODE | DIAGNOSA | TOTAL |
|----|-------|------------------------|-------|
| 1. | A09.9 | Gastro Enteritis Acute | 75 |
| 2. | J18.9 | Pneumonia | 40 |
| 3. | I63.9 | Cva Infark | 34 |
| 4. | E14.9 | Dm Hyperglukemia | 26 |
| 5. | M72.6 | Necrotizing Fascitis | 18 |
| 6. | A90 | Dengue Fever | 15 |
| 7. | N20.0 | Nefrolithiasis | 14 |
| 8. | A01.0 | Typhoid Fever | 12 |
- 59

9.	N20.1	Batu Ureter	10
10.	D24	Tumor Mammae	10

Analisis :

Diagnosa terbanyak pasien rawat inap bulan Maret 2026 adalah GASTRO ENTERITIS ACUTE sejumlah 75 Pasien. Diagnosa tersebut diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang.

Rencana Tindak Lanjut :

-

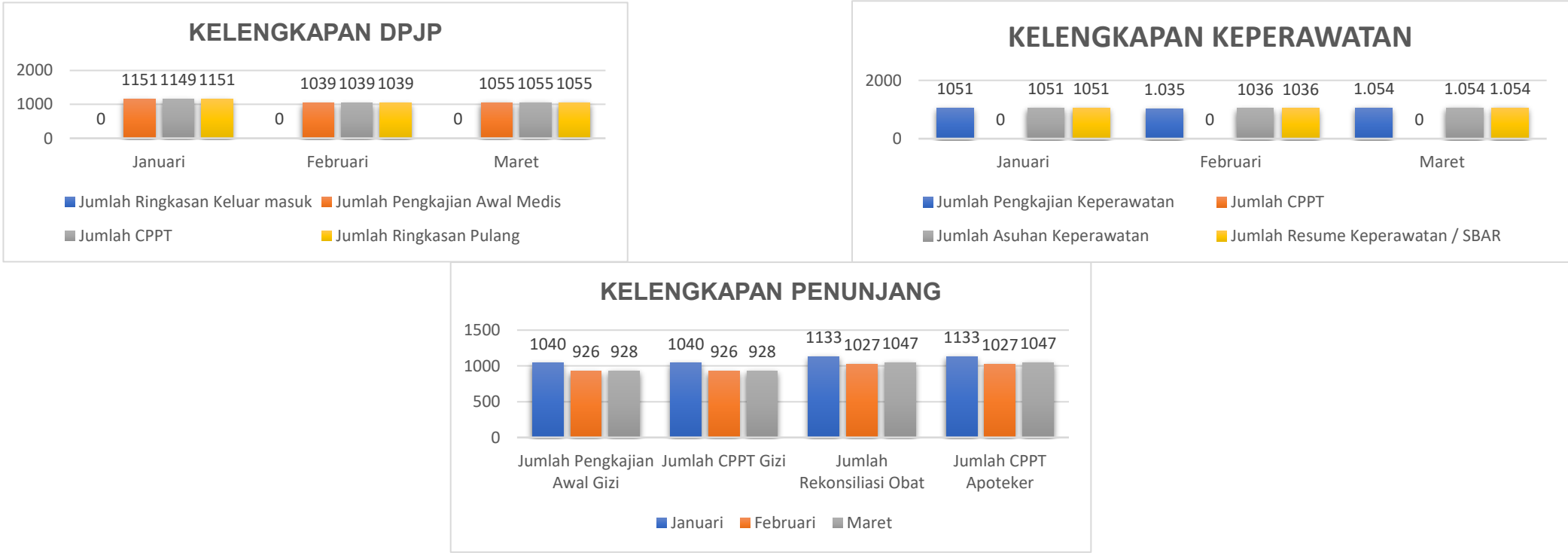
3.1.1.2 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Maret 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16%	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan tertinggi poli per poli : IGD dan IRJA
- 2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 98% pada Bulan Maret 2026.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Maret 2026.

Rencana Tindak Lanjut :

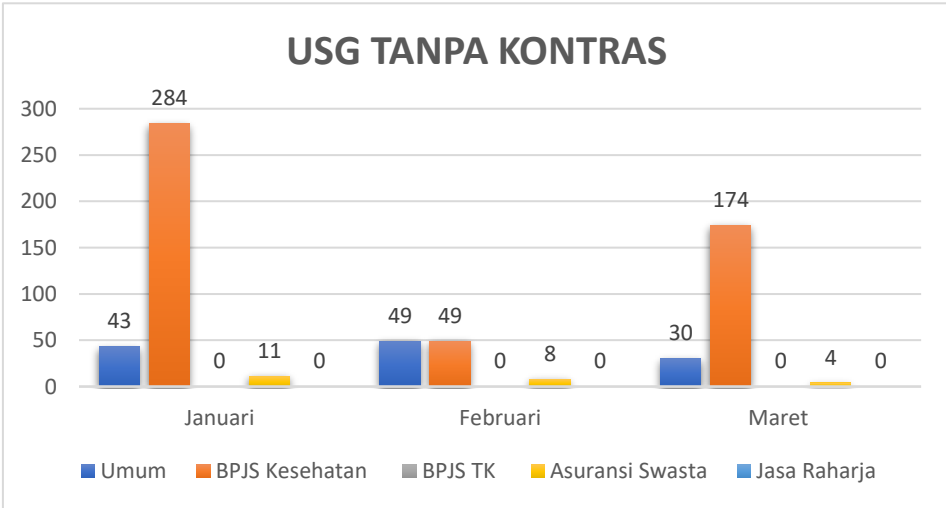
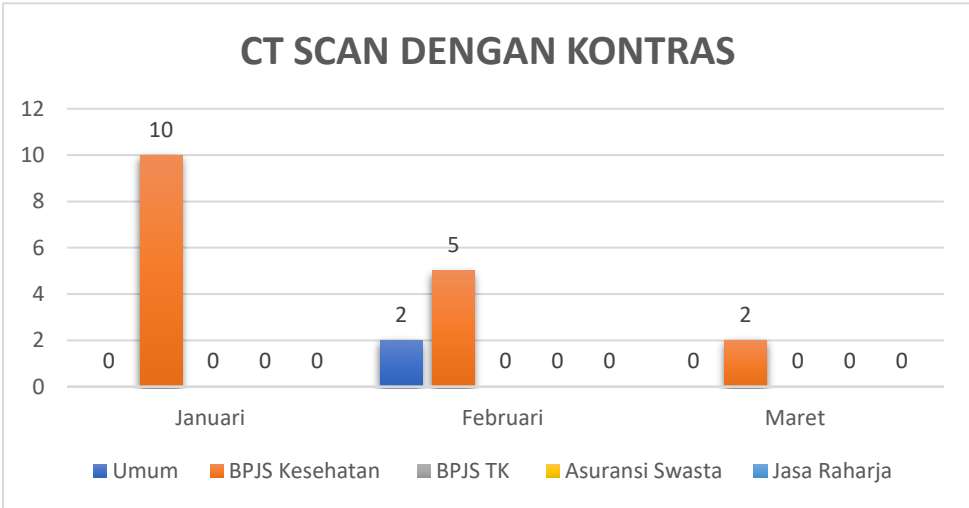
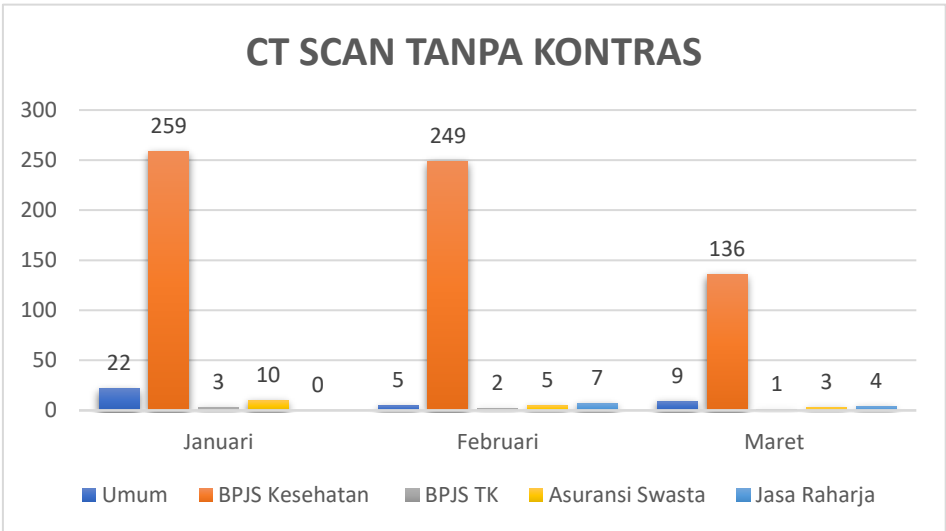
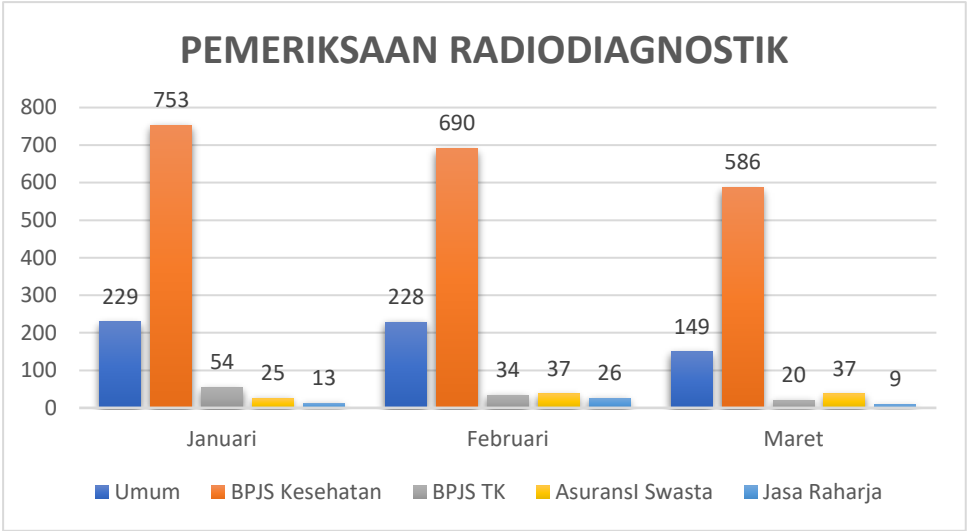
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan.

6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Maret 2026

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			JAN	FEB	MAR
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	229	228	149
		BPJS KESEHATAN	753	690	586
		BPJS TK	54	34	20
		ASURANSI SWASTA	25	37	37
		JASARAHARJA	13	26	9
	TOTAL		1.074	1.015	801
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	22	5	19
		BPJS KESEHATAN	259	249	136
		BPJS TK	3	2	1
		ASURANSI SWASTA	10	5	3
		JASARAHARJA	0	7	4
	TOTAL		294	268	163
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	2	0
		BPJS KESEHATAN	10	5	2
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		10	7	2
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	43	49	30
		BPJS KESEHATAN	284	249	174
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	11	8	4
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		338	304	208
TOTAL KESELURUHAN					

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Maret 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Maret 2026 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada Bulan Februari 2026 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - a. Radiodiagnostik : 801
 - b. USG Tanpa Kontras : 208
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 136
- 2. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Maret 2026 adalah sebanyak 1.174 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - a. Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - b. Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
 - 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
-
- 3. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Tahun 2026

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Januari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Abd Salam	Brain Atrofi Senilis	Brain Atrofi senilis, Infark	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-
Bulan Februari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Damiasih / 135744	Infark akut di periventrike	Tambahan bacaan Hydrocefalus obstrukti	
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	M Danendra Al Hussen / 201495	Normal	Normal	
Bulan Maret 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Asiyo Waga/24520	Fraktur distal ulna dan radius	Tambahan bacaan keterlibatan intra articular (epiphyphysis)	
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	Sumarmi/011074	Fractura caput Os Humerus sinistra.Dislokasi sendi(+)	Tambahan bacaan fraktur epiphisis	

Analisis :

Untuk bulan Maret 2026 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak sesuai dengan kondisi pasien pada surat permintaan radiologi sehingga dokter radiolog kurang menambahkan hasil bacaan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

1. dr.Agung Setyawan, Sp.Rad (K)

PEMERIKSAAN	RATA-RATA SELESAI PERIKSA (Menit)	RATA-RATA SELESAI PEMBACAAN (Menit)
Ro Thorax	00:03:20	00:25:00 (waktu efektif) 00:180:00 (diatas jam 12 malam)
Ro Vertabrae	-	-
Ro Abdomen	-	-
Ro Ekstremitas	-	-
Ro Skull	-	-
USG	00:08:00 00:05:0	00:08:00 00:05:0
CT Scan Non kontras	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)
CT Scan Kontras	00:15:00	00:25:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)
Radiologi Cito	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)

Analisa :

- a. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen 3 menit 20 detik dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit dijam elektif. Hal ini disebabkan karna hasil rontgen dapat langsung dikonsulkan via media sosial (*whatsapp*). (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- b. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen jika waktu diluar jam efektif rata- rata hasil pemeriksaan mencapai 180 menit. Hal ini disebabkan karna hasil rontgen langsung dikonsulkan via media sosial (*whatsapp*) namun radiolog belum membalas (Tidak sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- c. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi USG 8 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 5 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- d. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi CT Scan Non Kontras 5 menit dan rata- rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien ct scan dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- e. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi CT Scan Kontras 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien ct scan dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)

2. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad (K)

PEMERIKSAAN	RATA-RATA SELESAI PERIKSA (Menit)	RATA-RATA SELESAI PEMBACAAN (Menit)
Ro Thorax	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Vertabrae	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Abdomen	00:10:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Ekstremitas	00:02.00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Skull	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
USG	00:15:00	00:10.00
CT Scan Non kontas	-	-
CT Scan Kontras	-	-
Radiologi Cito	00:10:00	00:10:00

Analisa :

- a. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Thorax 3 menit 4 detik dan rata- rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- b. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Vertabrae 4 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- c. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Ekstremitas 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- d. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Abdomen 10 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- e. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Skull 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- f. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi USG 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 10 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)

- g. Semua pemeriksaan CT Scan di alihkan ke dokter Agung Setyawan, Sp.Rad berdasarkan kesepakatan antar radiolog.
- h. Terdapat pembacaan CITO selama bulan Agustus 2025 dan hasil *ekspertise* sesuai target yakni kurang dari 30 menit

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

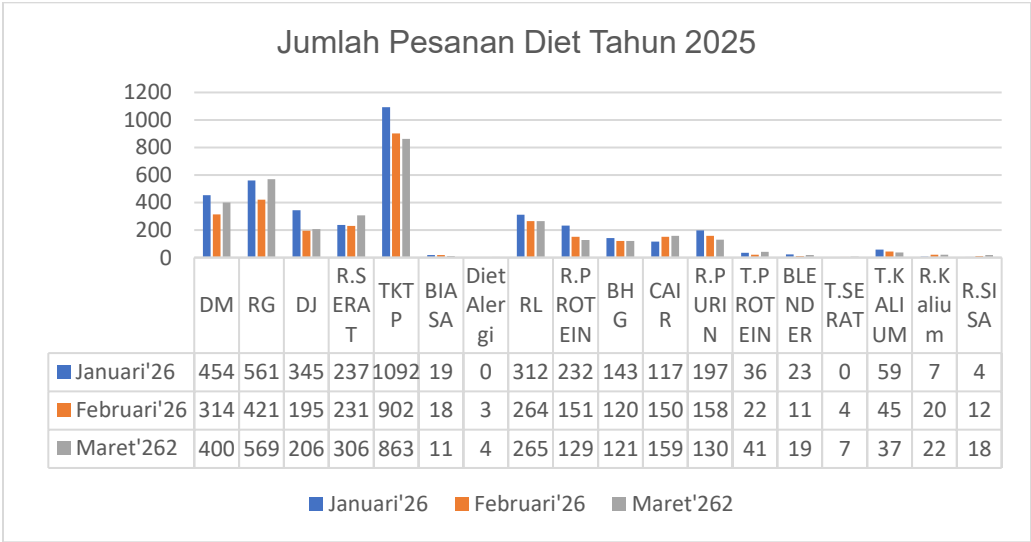
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Maret 2026

No	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	
1.	Diabetes Mellitus	454	314	400	27,3
2.	Rendah Garam	561	421	569	35
3.	Jantung	345	195	206	5,6

No	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	
4.	Rendah Serat	237	231	306	32,4
5.	TKTP	1092	902	863	-4,3
6.	Makanan Biasa	19	18	11	-38,8
7.	Diet Alergi	0	3	4	33,3
8.	Rendah Lemak	312	264	265	0,37
9.	Rendah Protein	232	151	129	-14,5
10.	Bubur Halus	143	120	121	0,83
11.	Cair	117	150	159	6
12.	Rendah Purin	197	158	130	-17,7
13.	Tinggi Protein	36	22	41	86,3
14.	Blender	23	11	19	72,7
15.	Tinggi Serat	0	4	7	75
16.	Tinggi Kalium	59	45	37	-17,7
17.	Rendah Kalium	7	20	22	10
18.	Rendah Sisa	4	12	18	50
Jumlah		4208	3041	3307	8,7

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Maret 2026



Analisis :

Jumlah pesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Pemberian diet alergi meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan keluhan alergi makanan. Bentuk makanan cair mengalami kenaikan, dikarenakan permintaan pasien rawat inap terhadap makanan cair juga meningkat, biasanya makanan cair diminta karena dipengaruhi oleh faktor kesadaran pasien. Diet yang mengalami penurunan adalah diet DM, rendah garam, rendah serat , TKTP, rendah lemak, rendah protein, diet jantung dan tinggi kalium.

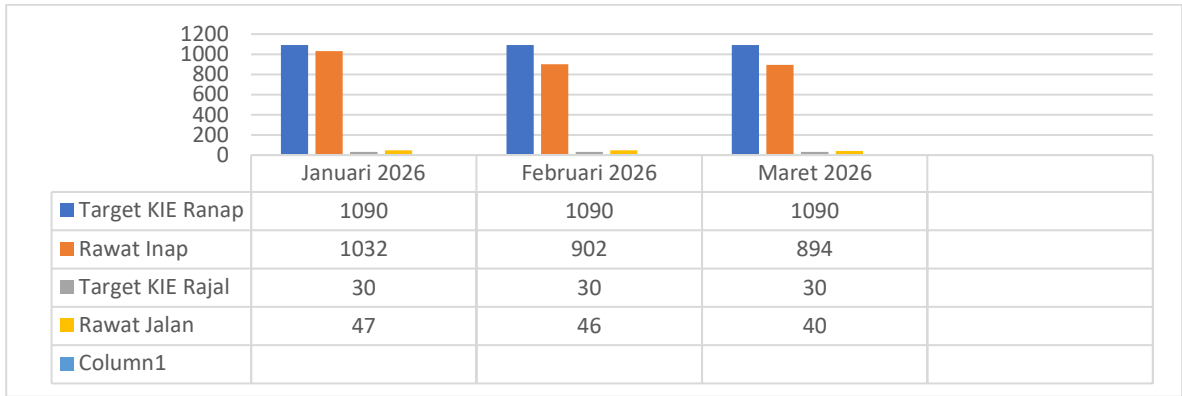
Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Maret 2026

No.	Indikasi	Jumlah Pasien Januari 2026	Jumlah Pasien Februari 2026	Jumlah Pasien Maret 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	1032	902	894
2.	Konsultasi Rawat Jalan	47	46	40

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Maret 2026



Analisis :
Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan Maret menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan Februari mengalami penurunan namun tidak signifikan dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ardhany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Maret 2026

No	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	1	2
	ISI KOMPLAINAN	- Pasien 4A atas nama Bu Krisna komplain makan pagi tidak ada nasi. - Pasien 4A atas nama Pak Jahman komplain makanan bekas pasien lain diberikan kepada pasien.		
	Analisis	- Tidak dilakukan check ulang sesudah pemberian nasi. - Penyaji Tiyas kehabisan makanan untuk pasien baru, sehingga meminta kepada penyaji Dwi Ratna untuk meminta cadangan makan lantai yang dibagi. Dwi Ratna memberikan cadangan makan tanpa dicek dahulu. Dan penyaji Tiyas menerima tanpa mencheck dahulu juga, sehingga box makan diterima pasien dalam keadaan sudah dimakan.		
	RTL	- QC makanan sebelum ditutup, harus dilakukan double QC. - Perlu adanya check ulang sebelum pendelegasian kepada teman, dan teman yang menerima harus melakukan check ulang kembali.		

2.4.5.6 Tabel Rekap *Food Waste* (Sisa Makanan) Maret 2026

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	65,9	54,4	57,8	75% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan Maret 2026 meningkat 0,7% dari bulan Februari 2026
		Nasi Tim	101,3	83,6	82,2	
	Total		167,2	138	140	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang pada bulam Maret tidak ada sisa yang kembali dari pasien.
		Setup Pisang	0	0	0	
		Kacang Hijau	0	0	0	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	0	0	0	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0	
		Brule Bomb	0	0	0	
	Total		0	0	0	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,3	3,6	2,7	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)				
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	3,5	3,6	2,4	
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)				
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon	11,2	11,2	7,7	
	Total					
	2.	Menu 2				
Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026		
Pagi		Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,2	4	2,2	
		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				

	Tambahan VIP	Telur Rebus			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3,8	3,9	3,8
		Ayam Wijen			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Telur Gulung			
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	3,5	3,4	2,3
		Telur dadar tebal			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
Total			10,5	11,3	8,3
3.	Menu 3				
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,9	3,9	2,7
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	3,4	3,9	2,7
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	3,2	3,9	3,2
		Telur rebus			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		10,5	11,7	8,6
4.	Menu 4				
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,6	3,7	3,6
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	1,5	2,7	3,9
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			

	Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sas u polong orang	3,4	2,8	3,5
		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
	Total		8,5	9,2	11
5.	Menu 5				
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	2,8	3	3
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,9	2,9	3,6
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Tahu Krispy			
	Sore	Soto ayam	4,2	4	3,5
		Telur rebus			
		VIP= Perkedel ayam			
	Total		10,9	9,9	10,1
	Total Sisa Menu tanpa KH		51,6	53,3	45,7
	Total Keseluruhan dengan KH		218,8	191,3	185,7

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2026

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2026	218,8
2.	Februari 2026	191,3
3.	Maret 2026	185,7
4.	April 2026	-
5.	Mei 2026	-
6.	Juni 2026	-
7.	Juli 2026	-
8.	Agustus 2026	-
9.	September 2026	-
10.	Oktober 2026	-
11.	November 2026	-

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2026



Analisis :

- 1. Terdapat 185,7 food waste pada bulan Maret 2026
- 2. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
- 3. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
- 4. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
- 2. Melakukan plating secara menarik.
- 3. Mengadakan cooking class.
- 4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
- 5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
- 6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
- 7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan

PRIMA HUSADA

Monitoring

	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			
	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	
Batas suhu min (°C)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Batas suhu maks (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Nilai Suhu (°C)	75	75	85	75	85	80	75	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	
Initial Staff	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an
Supervisi Karu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

ROBERT SHOT PRIMA HUSADA

Suhu Air Panas (Suhu Normal = 75° - 80° Celcius)

TANGGAL																																																
16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			
P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57		
an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

(-->) Suhu air panas tidak lebih dari 80°C (--->) Suhu air panas tidak kurang dari 75°C

2.4.5.8 Lampiran Rekap Data Kehilangan Alat Makan

DATA NAMA PASIEN MENGHILANGKAN / MERUSAKKAN ALAT							
NO.	TANGGAL	RUANGAN	NAMA PASIEN	KWITANSI	DOKUMENTASI	Nama Alat	KET
DESEMBER 2025							
1	01/12/2025	C3C-3	SYABIL ISMAIL DWIFARO	-	-	GELAS	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar pergantian ke kasir
JANUARI 2026							
1	06/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas tiba-tiba retak, tidak layak pakai
2	12/01/2026	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

3	13/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas mengalami pemuaian saat diangkut oleh CS dan pecah di trolly.
4	17/01/2026					SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok makan sudah tidak layak pakai karena berkarat.
5	20/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	
6	20/01/2026	D7A-5	Bakri	-		BOX MAKAN PECAH	Pasien memecahkan box makan merah, namun pasien tidak bersedia membayar dan pulang.

7	21/01/2026	C4B-3	Amelia Novita Sari	-		SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok hilang terbawa pasien pulang
8	27/01/2025	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.
9	30/01/2026	D6A-2	Sukirno	-		SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok hilang terbawa pasien pulang
FEBRUARI 2026							

1.	06/02/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Saat menuangkan teh, gelas retak. Sudah tidak layak pakai
2.	07/02/2026	C4A-2	HADI SUTRISNO			GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah dibayar
3.	15/2/2026	-	-	-		MANGKOK KECIL SNACK	Pecah oleh penyaji Tiyas
MARET 2026							
1.	08/03/2026	-	-	-		Box merah	Box merah pecah

2.	11/03/2026	D6A-12	MIFTAKHUL JANAH			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir
3.	22/03/2026	ICU	SARMI KUSUMAWATI			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir

Analisis :

- 1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 kehilangan alat makan pada Bulan Februari 2026
- 2. Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
- 2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

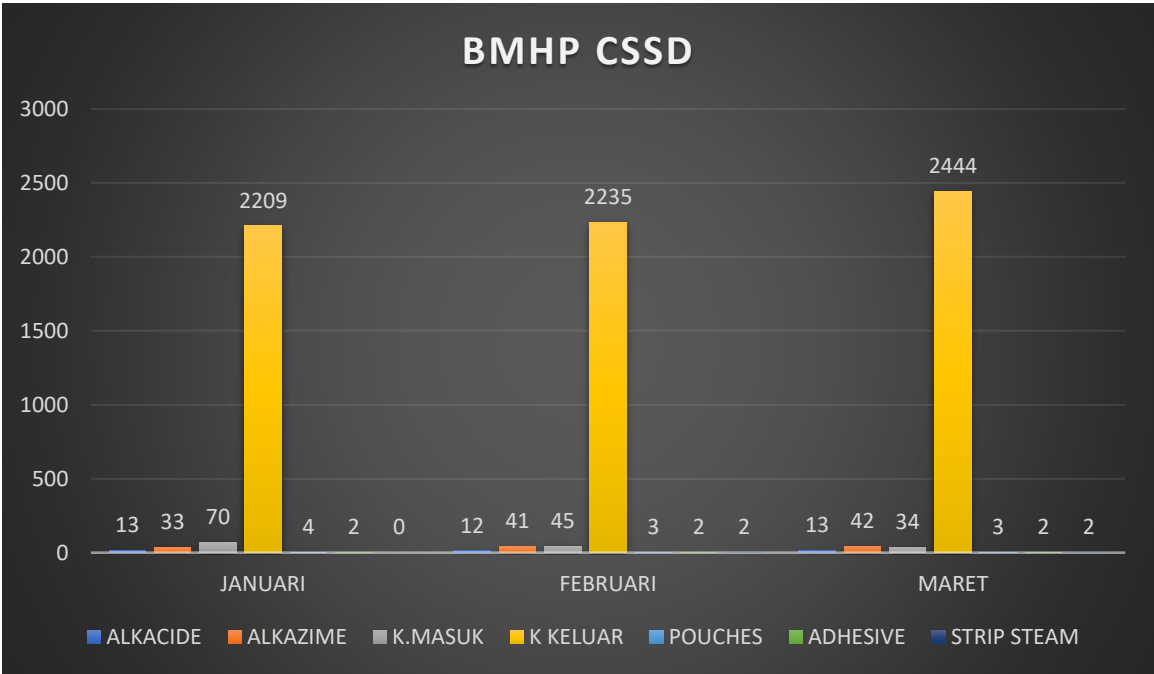
4.4.7 CSDD – Laundry

4.4.7.1 CSDD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSDD Februari 2026

NO	HAL	BULAN			
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026	
BHP					
1.	Chemical Alcacide (ml)/ oplos	13 kali oplos	12	13	
2.	Chemical Alkazyme (pcs)/ oplos	33 kali oplos	41	42	
3.	Kassa Masuk (roll)	70	45	34	
4.	Kassa Keluar (pouches)	2209	2235	2444	
5.	BHP Pouces (roll)	4	3	3	
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	2	
7.	Indikator Strip Steam (roll)	0	2	2	
Alat yang disetor (set)					
8.	IKO	445	456	461	
9.	IRJA	115	106	126	
10.	IRNA 5C	4	3	3	
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	4	4	6	
12.	IRNA 3C ANAK	4	2	1	
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	22	19	16	
14.	IRNA 2C VIP	2	2	2	
15.	IRNA ICU	4	3	2	
16.	IGD	106	121	121	
17.	MATERNITAS	178	171	189	
18.	NEONATOLOGI	65	46	55	
Jumlah					

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSDD Bulan Maret 2026



Analisis :

Pada bulan Maret Kassa Keluar (pouches) yang paling tinggi

-

Rencana Tindak Lanjut :

-

1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Produksi Linen Steril

JENIS LINEN	JAN	FEB	MAR	
Linen IKO	206 SET	201 SET	213 SET	
Linen mata	11 SET	8 SET	8 SET	

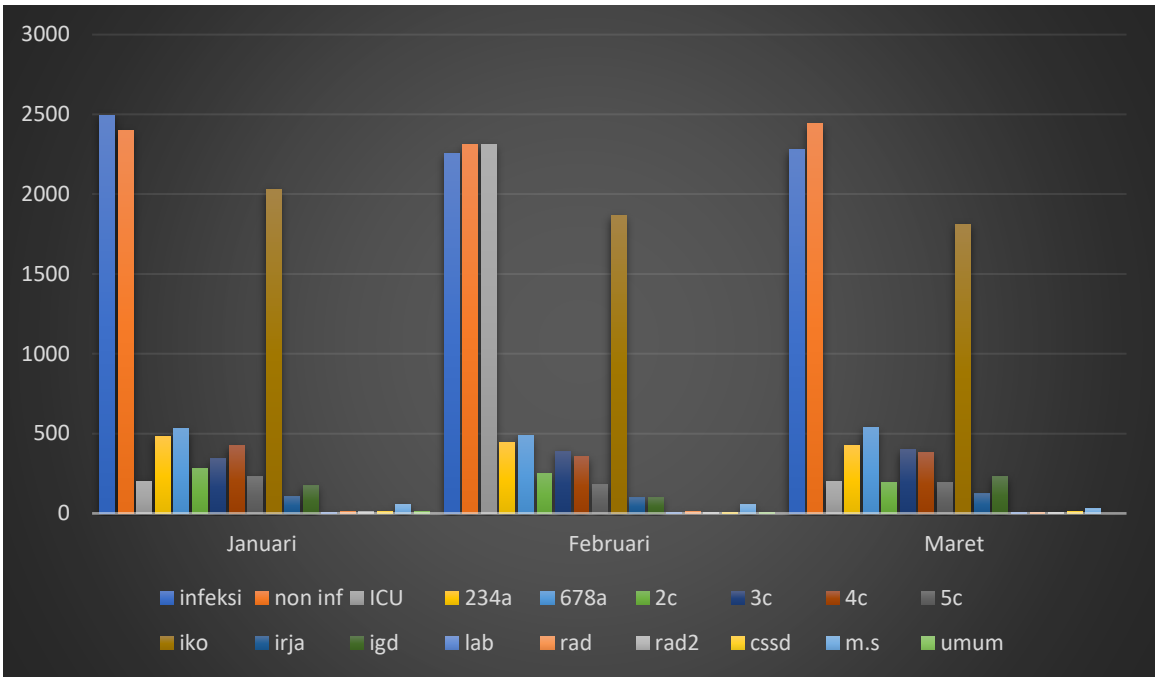
1.4.7.2.2 Penggunaan Chemical Laundry

CHEMICAL	JANUARI	FEBRUARI	MARET
CLAX BUILT LITE	1	1	2
CLAX 100	1	1	2
CLAX SONRIL	1	1	1
CLAX NEUTRAL	1	1	1
CLAX SOFT	1	1	1
SNAPY	15 LITER	0	5 LITER
RAPIKA	14 L	28 L	20 L
BAYKLIN	15 L	17 L	16 L
SOFTENER	0	0	
LIQUID	30 L	30 L	33 L
LPG	22 TABUNG	24 TABUNG	36 TABUNG

1.4.7.2.3 Produktivitas Linen Laundry

Hal	Januari	Februari	Maret				
Lineninfeksius	2496	2256	2278				
Linen non infeksi	2402	2309	2443				
234 A	483	445	426				
678 A	529	487	540				
2 C	280	248	193				
3 C	342	389	400				
4 C/Mater	425	356	382				
5 C	232	183	195				
IKO	2.030	1869	1812				
IGD	173	175	232				
ICU	202	218	201				
IRJA	107	100	123				
M.S	58	56	28				
Umum	9	7	24				
CSSD	13	7	11				
DAPUR/GIZ	9	7	6				
RAD	9	11	8				
LAB	8	7	6				
	4898	4565	4721				

1.4.7.2.4 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Januari 2026



- Analisis :**
- 1. Linen IKO di bulan Februari 2026 mencapai 1869
 - 2. Linen IRJA, IGD mencapai 275
 - 3. Linen IRNA juga mengalami penurunan

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
 - 2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan,
 - 3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
 - 4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
 - 5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
 - 6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

1.4.7.2.5 Kejadian Instrument Kurang Bulan Maret 2026

IKO	IGD	IRNA	IRJA
0	0	0	0

Analisis :
Tidak ada kejadian instrument kurang

Rencana Tindak Lanjut :
-

1.4.7.2.6 Angka Tercampurnya Instrument dengan Benda Asing

IKO	IGD	IRNA	IRJA
2	0	0	0

Analisis :
Tidak ada kejadian tercampurnya instrument dengan benda asing

Rencana Tindak Lanjut :

-

1.4.7.2.7 Kejadian Linen Hilang

IKO	IGD	IRNA	IRJA
0	4	34	0

Analisis :

Tidak ada kejadian linen hilang

Rencana Tindak Lanjut :

-

4.4 Kinerja Bidang Umum

4.4.1 SDM

Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	S1 Kesehatan Lingkungan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	38	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		21	14	7	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	16	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0

14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	14	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	16	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	8	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	8	1	0	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		7	6	1	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	14	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0

		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	40	13	7	6	0
		SMA		22	18	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	11	4	2	2	0
		SMA		7	6	1	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	Profesi Ners	10	5	0	5	0
		D3 TVF		2	0	2	0
		D3 Analis Kesehatan		1	0	1	0
		SMK		1	0	1	0
		SKM		1	0	1	
Total Karyawan			368	368	274	94	0
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan	Pendidikan Dokter	2	2	0	2	0

	Kelamin	Spesialis					
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			63	63	2	61	0
Total Keseluruhan			431	431	276	155	0

SKeterangan :
 Pada bulan Maret terdapat 1 staf resign.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Chandrawati Mustikasari, S.Tr.Gz	Ahli Gizi	11/03/2026	SIP Perpanjangan
2	Inana Agustin Puspitasari,A md. Farm	TVF	11/03/2026	SIP Baru
3	Much. Farchan Abdillah, Amd AK	Analisis Kesehatan	26/03/2026	SIP Baru
4	Nandini Nursyamsiana, S. Kep., Ns	Perawat	11/03/2026	SIP Baru
5	Rizki Halimatus Sa'diyah, S. Kep., Ns	Perawat	25/03/2026	SIP Baru
6	Annisa Fitri, S. Kep., Ns	Perawat	06/03/2026	SIP Baru
7	dr. Arrara Dyah Ayu Pakarti	Dokter Umum	16/03/2026	SIP Baru
8	dr. Ganesha Eka Yudha Paski	Dokter Umum	25/03/2026	SIP Baru
9	Poppy Windi Yolanda, S.Farm.,Apt	Apoteker	06/03/2026	SIP Baru

Keterangan :
 Pada bulan Maret 2026 terdapat 9 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
4	Dokter Umum IGD	2	0	2	Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.	Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.
5	Dokter Casemix	1	0	1	Mengganti dokter yang akan resign	Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	21 Oktober 2025 – 20 Januari 2026	Khusus	Kendita Putri Mahadini	S1	Perawat Gigi	21 Oktober 2025	Penempatan IRJA Poli Gigi
1	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Elis Rahmawati, Amd. Farm	D3	TVF	01 Februari 2026	Penempatan Farmasi
2	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Inana Agustin Puspitasari, Amd. Farm	D3	TVF	01 Februari 2026	Penempatan Farmasi
3	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Much. Farchan Abdillah, Amd AK	D3	Analisis Kesehatan	01 Februari 2026	Penempatan Laboratorium
4	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Nandini Nursyamsiana, S. Kep., Ns	S1	Perawat	01 Februari 2026	Masih rolling setiap 2 minggu ke seluruh unit irja dan irna
5	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Rizki Halimatus Sa'diyah, S. Kep., Ns	S1	Perawat	01 Februari 2026	Masih rolling setiap 2 minggu ke seluruh unit irja dan irna
6	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Annisa Fitri, S. Kep., Ns	S1	Perawat	01 Februari 2026	Masih rolling setiap 2 minggu ke seluruh unit irja dan irna
7	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Dewi Eka Yanti, S. Kep., Ns	S1	Perawat	01 Februari 2026	Masih rolling setiap 2 minggu ke seluruh unit irja dan irna
8	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Ineke Yulkarnain, S. Kep., Ns	S1	Perawat	01 Februari 2026	Masih rolling setiap 2 minggu ke seluruh unit irja dan irna
9	01 Februari 2026 – 30 April 2026	Khusus	Mukhammad Roisul	SMK	Security	01 Februari 2026	Penempatan Security
10	25 Februari 2026 – 24 Mei 2026	Khusus	Nuril Maulidatul Qorida, S. KM	S1	PMKP	25 Februari 2025	Penempatan Sekre PMKP

Keterangan : Pada bulan Maret 2026 ada 10 staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	38	0	11	24	3	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	6	3	0	1	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									kinerja umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	4	1	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	9	6	0	1	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrtng & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	23	0	21	2	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	11	0	10	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	4	1	1	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	28	0	22	6	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	5	2	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	16	0	16	0	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	19	1	0	1	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	9	0	2	7	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	8	0	2	6	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	1	4	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	4	3	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	14	0	3	10	0	1	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	3	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	0	2	0	1	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	21	18	1	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	11	0	9	2	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	3	2	1	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
41	Staf Orientasi	Umum	10	0	0	10	0	0	Staf orientasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Keterangan:
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Maret 2026.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	38	0	7	21	7	1	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	6	3	0	1	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja

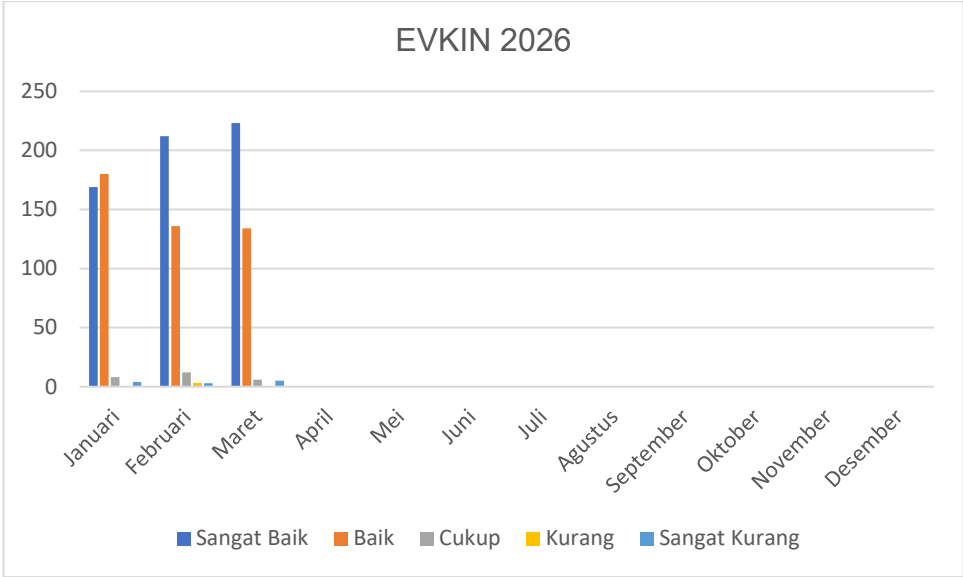
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	4	1	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	9	7	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	10	0	7	3	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	23	0	17	6	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	11	0	10	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRs	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	28	0	18	7	3	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	16	0	14	2	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	5	3	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	20	1	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	7	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	9	0	2	7	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	8	0	2	6	0	0	Unit Laboratorium secara

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	1	4	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	2	5	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	14	0	3	10	0	1	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	1	2	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	23	17	0	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	3	2	1	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Maret 2026.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	169	212	223									
Baik	180	136	134									
Cukup	8	12	6									
Kurang	0	3	0									
Sangat Kurang	4	3	5									
TOTAL	361	366	368									

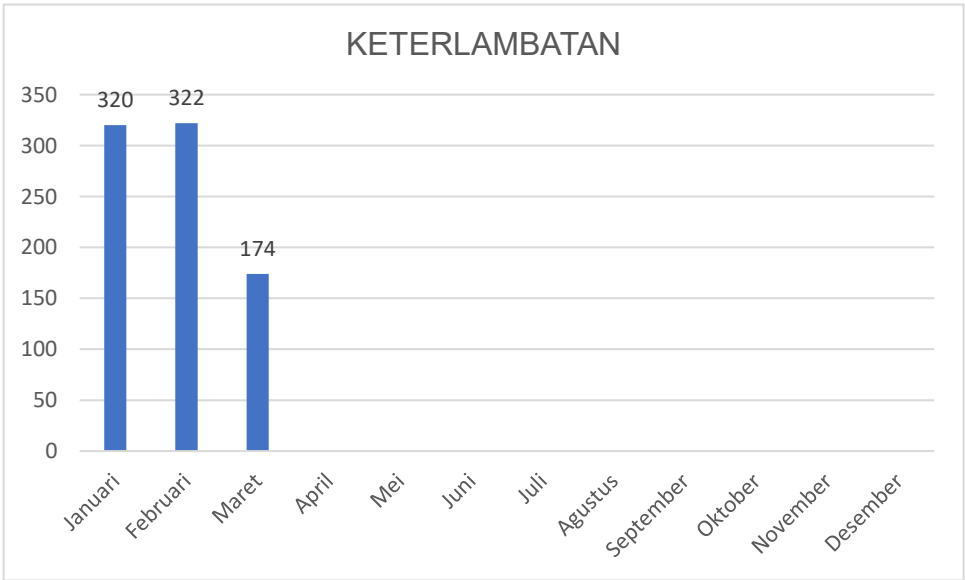
Analisa :
Secara umum terdapat kenaikan kategori sangat baik.

Rencana Tindaklanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
- 4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	320	332	174									



Analisa :
Secara umum terdapat penurunan jumlah keterlambatan pada bulan ini karena adanya system finger terbaru.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	1
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	1
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	1
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	0
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	1
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	1
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	1

33	Parkir	0	0	0	0	0	0	1
Total		0	0	0	0	0	0	7

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.6.1 Supervisi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	0	0									

Analisa:
 Belum dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Lebih ditingkatkan supervisi ke tiap unit khususnya unit dengan tingkat temuan banyak.

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Fella Pancarani, Amd. Kep	IRNA 234A	IRNA 5C
2	Lailatul Badriyah, Amd. Kep	IRNA 5C	IRNA 234A

Analisis : pada bulanMaret 2026 terdapat 2 staf rotasi

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	58,97%	82,05%	64,10%										

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	276	119	43,12%
Februari	276	138	50%
Maret	276	124	44,93%
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			

September			
Oktober			
November			

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	8
Februari	16
Maret	16
April	
Mei	
Juni	
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	
November	

Analisa :
 Pada bulan ini capaian adalah 82,05% untuk ruangan dan 50% untuk alat kesehatan. Terjadi peningkatan dari bulan lalu.

Rencana Tindak Lanjut :
 Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	4	8	13	25
FEBRUARI	276	138	50%	276
MARET	3	6	18	27
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :
 P Pemeliharaan AC bulan Maret secara umum turun.

Link terlampir : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan			
5	Mei	4x/bulan			
6	Juni	4x/bulan			
7	Juli	4x/bulan			
8	Agustus	4x/bulan			
9	September	4x/bulan			
10	Oktober	4x/bulan			
11	November	4x/bulan			

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala
Melalui link :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbs_oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan			
Mei	4x/bulan			
Juni	4x/bulan			
Juli	4x/bulan			
Agustus	4x/bulan			
September	4x/bulan			
Oktober	4x/bulan			
November	4x/bulan			
Desember	4x/bulan			

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan

rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

- 1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
- 2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
- 3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7 SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497>
- 4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
- 5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAyz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
- 6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwtuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen
1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Maret 2026							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/03/2026	2774	2466	308	MMHG			MMHG
02/03/2026	2466	2158	308	MMHG			MMHG
03/03/2026	2158	1850	308	MMHG			MMHG
04/03/2026	1850	1556	294	MMHG			MMHG
05/03/2026	1556	1115	441	MMHG			MMHG
06/03/2026	1115	3230	0	MMHG	sesudah pengisian	2115	MMHG
06/03/2026	3230	3088	142	MMHG			MMHG
07/03/2026	3088	2847	241	MMHG			MMHG
08/03/2026	2847	2553	294	MMHG			MMHG
09/03/2026	2553	2250	303	MMHG			MMHG
10/03/2026	2550	1993	557	MMHG			MMHG
11/03/2026	1993	1723	270	MMHG			MMHG
12/03/2026	1723	1273	450	MMHG			MMHG
13/03/2026	1273	3224	0	MMHG	sesudah pengisian	1951	MMHG
13/03/2026	3224	3075	149	MMHG			MMHG
14/03/2026	3075	2761	314	MMHG			MMHG
15/03/2026	2761	2489	272	MMHG			MMHG
16/03/2026	2489	2241	248	MMHG			MMHG
17/03/2026	2241	1983	258	MMHG			MMHG

18/03/2026	1983	1732	251	MMHG			MMHG
19/03/2026	1732	1200	532	MMHG			MMHG
20/03/2026	1200	3360	0	MMHG	sesudah pengisian	2160	MMHG
20/03/2026	3360	3348	12	MMHG			MMHG
21/03/2026	3348	3108	240	MMHG			MMHG
22/03/2026	3108	2861	247	MMHG			MMHG
23/03/2026	2861	2613	248	MMHG			MMHG
24/03/2026	2613	2355	258	MMHG			MMHG
25/03/2026	2355	2077	278	MMHG			MMHG
26/03/2026	2077	1626	451	MMHG			MMHG
27/03/2026	1626	3284	0	MMHG	sesudah pengisian	1658	MMHG
27/03/2026	3264	3161	103	MMHG			MMHG
28/03/2026	3161	2882	279	MMHG			MMHG
29/03/2026	2882	2590	292	MMHG			MMHG
30/03/2026	2590	2350	240	MMHG			MMHG
31/03/2026	2350	2007	343	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8315	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						5769	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			532.5862069	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2884.5	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan			
Mei	1x/bulan			
Juni	1x/bulan			
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan			
Mei	1x/bulan			
Juni	1x/bulan			
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift

NO	LOKASI	KONDISI
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				

September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOk6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapitan Kegiatan External

Bulan	Jumlah Kegiatan	Waktu yang Dibutuhkan
Januari	19	47 jam 27 menit
Februari	12	37 jam 7 menit
Maret	15	33 jam 47 menit
April		
Mei		
Juni		
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	INSTANSI	PETUGAS	SELESAI	KET
02/03/2026	14:00	Pemindahan dan instalasi listrik untuk meja skrining pasien	klinik ptp	M Arifin	15:30	selesai
04/03/2026	09:00	pendampingan	Gudang	M Arifin	11:30	selesai

		pemindahan genset di proyek upi	upi			
06/03/2026	12:30	perbaikan pipa drain bowl dan cup dental unit	klinik ptp	M Arifin	14:30	selesai
09/03/2026 12/03/2026	13:30 12:12	setting ulang ruang lab dan setting kursi kantor 4 unit perbaikan pompa air proyek di upi	klinik ptp Gudang upi	M Arifin Dian T	16:00 14:03	selesai selesai
13/03/2026	09:30	kirim alat cuci dan beli solar molen	Gudang upi	Dian T	11:00	selesai
15/03/2026	15:00	finsihing ac casette	klinik bedali	Dian T	17:00	selesai
16/03/2026	11:30	perbaikan dental	klinik karlos	M Arifin	14:30	selesai
20/03/2026	07:15	maintenance ac klinik bedali	klinik bedali	Dian T, Yonatan d	12:30	selesai
24/03/2026	14:30	ganti 4 titik lampu dan setting timer taman	Dpm	M Arifin, Yonatan d	16:30	selesai
25/03/2026	09:00	penambalan dinding ruang farmasi	klinik bedali	M Arifin, Dian T	12:00	selesai
25/02/2026 25/03/2026	13:30 12:30	penambalan plafon ruang poli gigi penambalan plafon ruang tunggu pengambilan alat mobile xray ke phs	klinik ptp rsphs	M Arifin M Arifin, Dian T	16:30 15:00	selesai (dengan pak yadi) selesai
25/03/2026	17:43	setting timer taman dpm Off 21:00	Dpm	Dian T, Yonatan d	18:15	selesai

Keterangan :
 Total 47 jam lebih 27 menit untuk perbantuan eksternal.

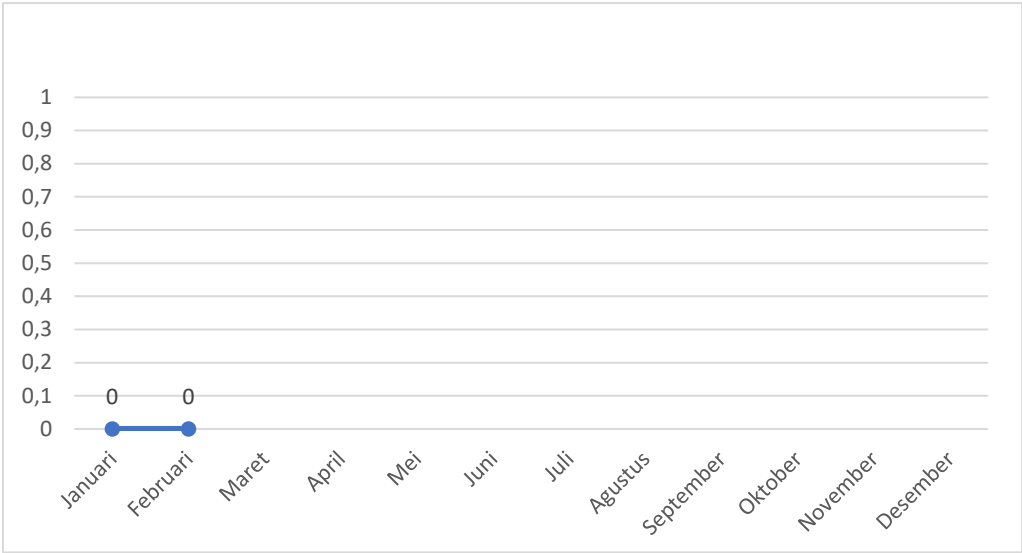
Rekapan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	1									

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



Analisa :
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	6	1	4								

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



3.7.6 Tabel Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

TANGGAL	KETERANGAN	RTL
	Hp penunggu pasien hilang di area ruangan rawat inap	hp sudah ditemukan pemilik lupa tertinggal di dalam tas

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0								

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

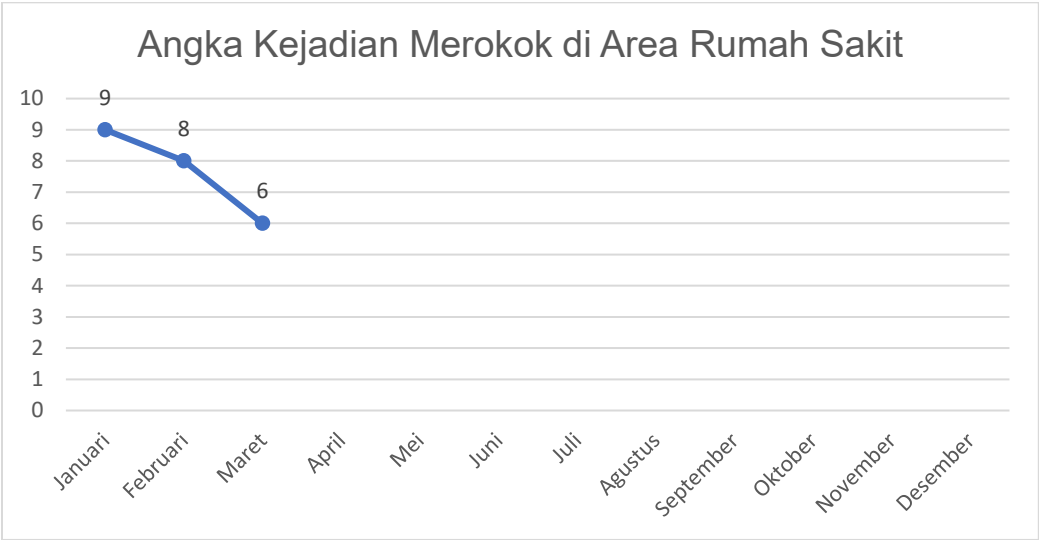
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	9	8	6									



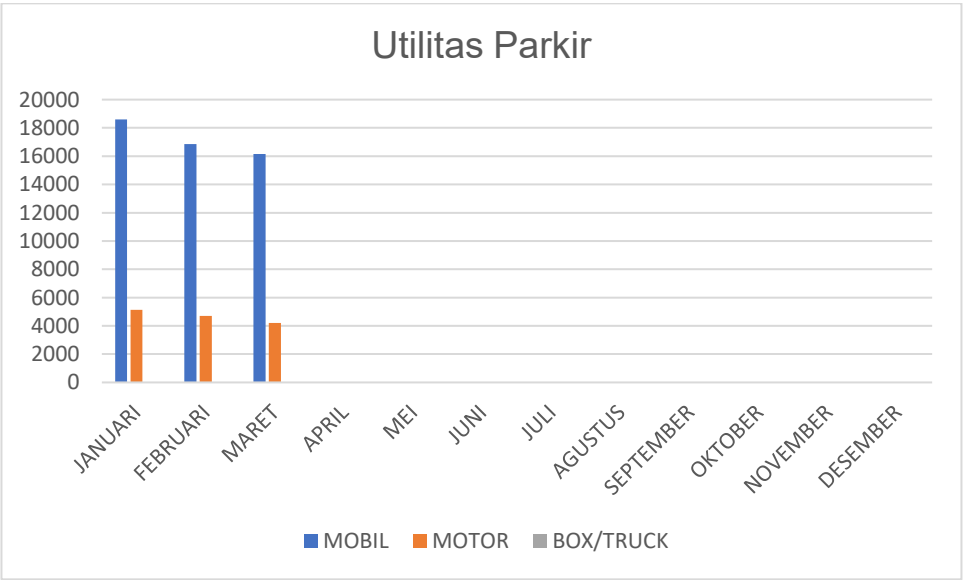
Analisis :

Angka 6 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir



Analisis :

Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

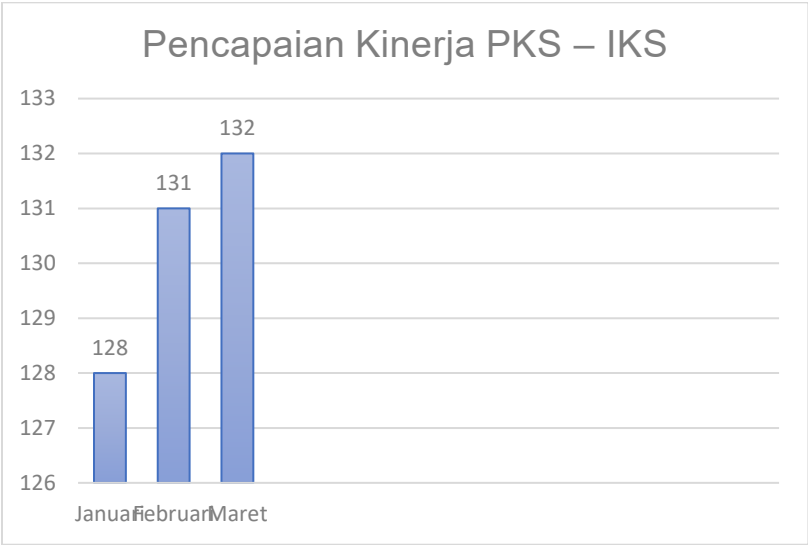
3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2026

No	Bulan	Target	Jumlah					
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	Total Kurang
1	Januari	1 IKS baru	128	1	1	0	1 (Proses review)	1
2	Februari	1 IKS baru	131	2	1	2	1 (Proses Perpanjangan 2)	2
3	Maret	1 IKS baru	132	1	1	2	2 (Proses perpanjangan)	2
Analisis ; - Pada bulan Maret 2026, PKS baru dengan Klinik Waras Wiris Selesai, PKS dengan Asuransi Astra Life proses review, Perpanjangan MOU dengan Panti Nirmala, Perpanjangan MOU dengan RSUD Lawang Tahap Tanda Tangan Pihak ke-2, dan Perpanjangan MOU dengan TPA Halodoc. - Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : - Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
2	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Review
3	Dipenduk Kab. Malang Ketan Ireng	TTD Pihak ke-2	Selesai
4	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
5	TPA Halodoc	Review	Proses Tanda Tangan
6	Klinik Waras Wiris	Review	Selesai
7	SLB tingkat Nasional Bagian C	Review	Selesai
8	PMI Kota Malang	Review	Selesai
9	PMI Kabupaten Malang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
10	SK dan PKS Tim Penerjemah untuk Akreditasi	Review	Selesai
11	MOU Kementerian Agama Kabupaten Malang	Review	Selesai
12	MOU Klinik Muslimat Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
13	MOU klinik BLK Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
14	RSUD Lawang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
15	Asuransi Astra Life	Review	
16	Panti Nirmala	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
17	Panglima Sudirman	Review	Proses Review



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

1.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2026

No	Bulan	Target	Jumlah Pasien GOSHOW	ON SITE
1	Januari	150	275	-
2	Februari	150	172	-
3	Maret	150	44	-

Analisis ;

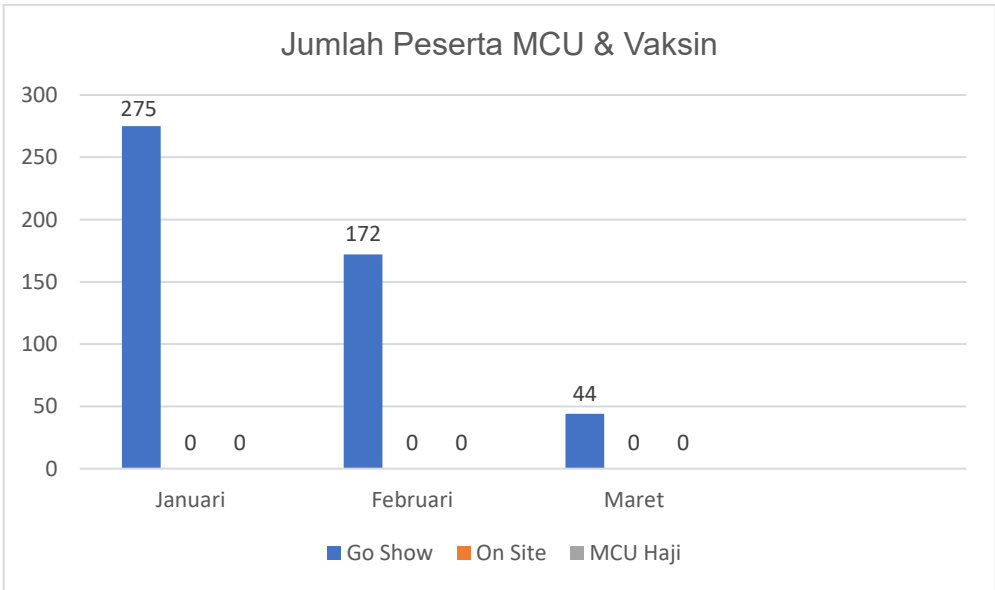
1. Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Februari mengalami penurunan kunjungan sebesar 128 pasien atau sekitar 74,42% dari periode sebelumnya.

2. Hal ini dapat terjadi karena adanya agenda lebaran dan libur panjang sehingga peserta vaksinasi dan mcu turun

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan Promosi kesehatan kembali melalui Social Media

2. Kunjungan Perusahaan dan sekolah untuk menawarkan program MCU



1.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2026

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Sinergi Pangan	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit

		Travel Kbih Al Muchsinin	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 24 Jamaah di RSPHM
		Travel King Salman	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 5 Jamaah di RSPHM
2	Februari	PT Pangan Lestari Malang	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah terlaksana MCU dengan 1 Orang di Rumah Sakit
3	Maret	PT Multi Daya Mitra	Tidak berhasil karena Harga Tinggi
		PT Bangun Sarana Wreksa	Belum terlaksana karena perubahan Pimpinan dan Penawaran masih diajukan kembali

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

Target	N o	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
5 Kunjungan per bulan	1	12/01/2026	PT TENTREM	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	2	12/01/2026	PT KEMAS SUPER INDONESIA (KSI)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

				negosiasikan 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	3	12/01/2026	PT ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	4	12/01/2026	PT BANGUN SARANA WREKSA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	5	12/01/2026	CV AUMIRETA ANGGUN	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

				Perusahaan		
	6	12/01/2026	PT CIPTA SANDHI DARMA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	7	12/01/2026	PT INTAN PRAMADITA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menanyakan untuk paket Pemeriksaan Narkoba dan sudah dijelaskan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

				n dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	8	12/01/2026	PT INDOMARINE	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menyampaikan penawaran akan menjadi bahan referensi	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	9	12/01/2026	PT LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

				dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	10	12/01/2026	PT MALINDO INTITAMA RAYA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	11	12/01/2026	PT UNGGUL ANUGRAH SEJAHTERA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan,	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. PIC akan menanyakan kepada pimpinan dan bila pimpinan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

				3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksa an dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusaha a n	mengadakan program MCU akan di arahkan ke RS	
	1 2	15/01/20 26	PT OTSUKA	1. Menyampa ikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasik an, 3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksa an dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusaha a n	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	1 3	15/01/20 26	PT RAGAM RAYA RASA	1. Menyampai kan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasik an, 3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaika n dengan jadwal dari Perusahaa n	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	1 4	15/01/20 26	PT KHARISMA SELARAS	1. Menyampai kan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasik an, 3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaika	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

				n dengan jadwal dari Perusaha n		
	1 5	15/01/20 26	PT ADI PUTRO	1. Menyampai kan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasik an, 3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaika n dengan jadwal dari Perusaha n	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	1 6	15/01/20 26	PT USTEGRA	1. Menyampai kan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasik an, 3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

				dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	17	15/01/2026	PT INDOSTAR BUILDING MATERIAL	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	18	15/01/2026	PT SUMBER ALFARIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan,	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

				3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaika n dengan jadwal dari Perusahaa n		
	1 9	15/01/20 26	PT WIM (KTG)	1. Menyampai kan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasik an, 3. Penyampai an untuk Pemeriksa an dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaika n dengan jadwal dari Perusahaa n	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	20	20/01/2026	PT SINAR TAMAN PLASTINDO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaann	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	21	20/01/2026	PT PADMA INDAH PRIMA PERKASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaa n dapat disesuaikan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

				n dengan jadwal dari Perusahaa n		
	2 2	31/01/20 26	Kegiatan Senam Yoga Lansia	1. Program dengan komunitas Lansia geriatri berupa Yoga 2. Jumlah peserta 56 orang 3. Peserta aktif mengikuti seluruh kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan	Koordinasi dengan PKRS untuk agenda selanjutnya
	2 3	03/02/20 26	PT Pangan Lestari	1. Menyampaika n Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaika n untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up untuk Agreement Letter
	2 4	06/02/20 26	PT Multi Daya Mitra	1. Menyampaika n Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga	Follow up ulang

				dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	
	25	09/02/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang akhir bulan
	26	11/02/2026	Puskesmas Lawang	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Puskesmas menyampaikan koordinasi dengan tim pelayanan sudah baik dan bagus karena selalu direspon dengan cepat 2. Puskesmas menyampaikan bahwa adanya beberapa pasien yang sudah tidak aktif BPJSnya,	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala

					walaupun pemberitahuan Program BPJS baru dinformasikan tetapi dari bulan januari sudah ada peserta BPJS yang dinonaktifkan dan harus melakukan konfirmasi ke pihak desa menerima informasi layanan terbaru. Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk ltr pasien yang mendapatkan obat yang bisa didapatkan di Faskes apakah bisa jika di PRBkan saja 2. Puskesmas menyampaikan mohon dibantu untuk menginformasikan kepada pasien terkait SRB diberikan ke Puskesmas dan pasien tidak perlu membawa SRB ketika menuju ke RS	
	27	11/02/2026	Klinik Garuda	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya.	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS	1. Bina komunikasi untuk menjalin

				2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	sudah baik dan selalu direspon dengan cepat 2. Klinik menyampaikan bahwa adanya perubahan jadwal di klinik dari yang biasanya buka sampai dengan jam 20.00, berubah hanya sampai jam 15.00, sehingga beberapa peserta klinik ada yang berganti ke faskes lain. Kritik dan Saran : 1. Klinik menyampaikan bahwa ada satu pasien yang diminta untuk kembali ke klinik dengan memberikan surat pemeriksaan dari IGD dan meminta untuk dibuatkan rujukan, apakah bisa dibantu untuk pemeriksaan dari IGD diberikan surat keterangan bila memang hasil pemeriksaan	kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala
--	--	--	--	---	---	--

					di IGD menyatakan Perlu untuk dibuatkan rujukan maka pasien diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan agar klinik bisa mengkonfirmasi dengan data tersebut	
	28	11/02/2026	Puskesmas Singosari	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS cukup baik dan selalu direspon dengan cepat Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk PRB pasien dari RS PHM masih sedikit sedangkan rapot puskesmas di BPJS merah di RS PHM 2. Puskesmas menyampaikan ada satu pasien dengan 2 rujukan yang aktif dan 1 rujukan tersebut obatnya di PRB kan, tetapi dari RS memberikan Obat untuk 2 rujukan sehingga	

					ketika Puskesmas memberikan klaim ke Kimia Farma, mereka meminta untuk obat tersebut dikembalikan karena pihak kimia farma tidak bisa mengklaim obat PRB yang diberikan oleh RS 3. Pihak Puskesmas meminta tolong untuk ketika ada pasien yang membutuhkan dua rujukan apakah bisa jika diselangi untuk jadwal kontrolnya sehingga habisnya berbeda 4. Puskesmas menyampaikan untuk diagnosa dokter dicky masih dibuat berbeda dengan kondisi asli pasien, seperti cholelithiasis dibuat ulcerative 5. Pihak Puskesmas meminta saran untuk Print Out resume pulang pasien karena	
--	--	--	--	--	--	--

					data tersebut digunakan jika ada audit dari BPJS 6. Adapun penolakan dari IGD untuk rujukan jantung dari Puskesmas Singosari di bulan Desember rujukan jantung dengan hasil EKG SVT, dari RS Prima husada menginformasi kan bahwa tindakan PCI belum ada dan pasien hanya bisa ditindak rawat inap saja sedangkan ketika puskesmas konfirmasi ke marsudi rujukan langsung diterima dengan tindakan kejut jantung sesuai dengan SOAP yg diberikan oleh tim puskesmas	
	29	16/02/2026	PMI Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kabupaten Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kabupaten Malang	Follow up MOU
	30	16/02/2026	PMI Kota Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS	Sudah diterima oleh PIC PMI Kota Malang	Follow up MOU

				dengan PMI Kota Malang		
	3 1	24/02/20 26	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Menyampaikan dokumen MOU dengan SLB Tingkat Nasional Bagian C untuk kebutuhan Penerjemah Bahasa Isyarat	Sudah diterima oleh PIC SLB Tingkat Nasional Bagian C	Follow up MOU
	3 2	24/02/20 26	PMI Kota Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	3 3	24/02/20 26	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen MOU dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang untuk kebutuhan Bimbingan kerohanian	Sudah diterima oleh PIC Kementrian Agama Kabupaten Malang	Follow up MOU
	3 4	27/02/20 26	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	3 5	27/02/20 26	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	3 6	10/03/20 26	Klinik Waras Wiris	Mengantarkan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Ibu Kholifa	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	3 7	10/03/20 26	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan MOU yang sudah selesai 2. Koordinasi terkait Cross selling yang akan terjadi antara Fitness Plus Singosari dengan RS PHM	1. Sudah diterima oleh Mba Nanda 2. Koordinasi dilakukan terkait kerjasam Flyer Membership Fitness Plus 3. Voucher MCU RSPHM 4. Penempatan desain Banner untuk diletakkan di Fitness Plus	Menginformasi kan hal tersebut kepada Kepala Bidang dan Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	3 8	14/03/20 26	Klinik Losari Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama wahyu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	3 9	14/03/20 26	Bidan Indi (KRI Putra Husada)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama diandra	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 0	14/03/20 26	Klinik BLK	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Ria	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 1	14/03/20 26	Klinik Mitra Prima Care	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Dokter tari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 2	14/03/20 26	Puskesmas Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 3	16/03/20 26	CV Aumireta Anggun	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Team Security	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 4	16/03/20 26	PT Kemas Super Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Suryono	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 5	16/03/20 26	PT Malindo Intitama Raya	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Gunawan	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 6	16/03/20 26	PT Molindo Raya Industri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Yudi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 7	16/03/20 26	PT Bangun Sarana Wreksa	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Bapak Nanda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	4 8	16/03/20 26	PT Pesta Pora Abadi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	49	16/03/2026	PT Kencana Tiara Gemilang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Andik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	50	16/03/2026	PT Lawangmas Primapack Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Dian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	51	16/03/2026	Puskesmas Ardimulyo	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Mailing Ibu Vale	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	52	16/03/2026	Klinik Garuda	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Dinda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	53	16/03/2026	Klinik Brawijaya Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC TU Pak Rizza	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	54	16/03/2026	DPM Lidya Putri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh ibu resi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	55	16/03/2026	DPM Suhariningsih	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Rosia	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	56	16/03/2026	DPM Farida Rusniah	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Setiani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	57	16/03/2026	KRI Muslimat Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu devi putri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	58	16/03/2026	Klinik Wijaya Husada	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Yeni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	59	16/03/2026	DPM Wulandarti Wien	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Anak atas nama Ibu Nastiti	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	60	17/03/2026	PT Jasa Raharja	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC bapak Hari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	61	17/03/2026	Klinik Kartini Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Rendy	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	62	17/03/2026	Klinik Nayaka 02	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter Virda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	63	17/03/2026	DPM Arry Budiarti	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Suami	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	64	18/03/2026	DPM Ida Bagus D.	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh dr Ida Bagus	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	65	18/03/2026	PKM Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter syamsu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	66	18/03/2026	DPM Yosephine Pratiwi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Novi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	67	18/03/2026	PT Kharisma Selaras	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Lina	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	68	18/03/2026	PT Indostar Building Material	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Riri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	69	18/03/2026	Relawan Siaga Utara (RESITA)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Istri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026

Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
MCU	1	09/01/2026	PT Sinergi	Program MCU	Sudah	Hasil

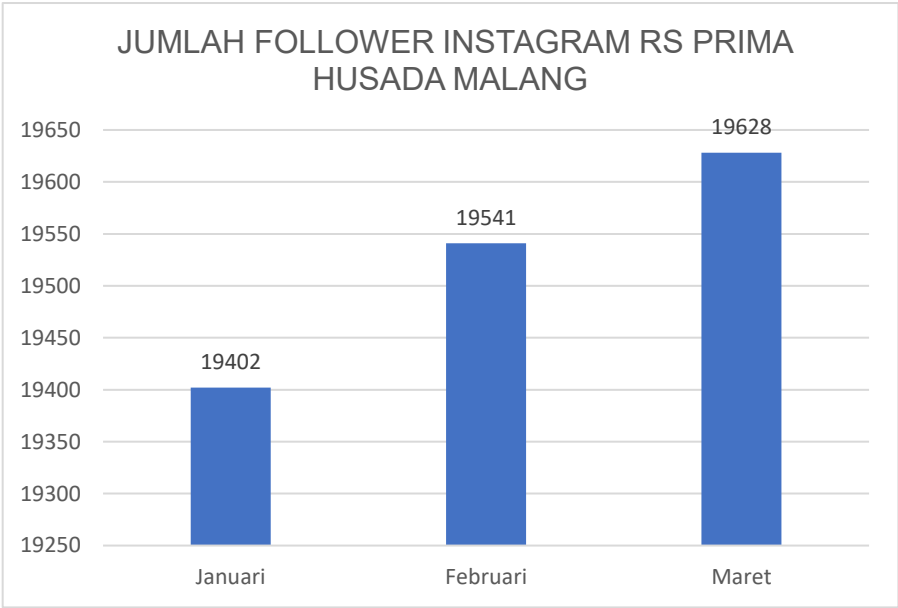
dan Vaksin			Pangan Gemilang	Karyawan di RS dengan PT Sinergi Pangan Gemilang	dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	2	14/01/2026	KBIH AI Muchsinin	Program Vaksin 24 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan vaksin untuk 24 orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	3	26/01/2026	KBIH Alfattah Singosari	Program Vaksin 9 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan Vaksin untuk 6 Orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	4	26/01/2026	Travel King Salman	Program Vaksin 5 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	5	04/02/2026	PT Riset Perkebunan Nusantara	Program MCU Karyawan Baru di RS dengan PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 1 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	6	19/02/2026	PT Pangan Lestari Malang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Pangan Lestari Malang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Sudah selesai

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

JUMLAH KONTEN BARU	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
FEED FOTO	12	5	16									
REELS	4	6	6									
STORY	13	31	28									
TOTAL	29	41	50									0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R

FEED FOTO	13	5	16									
FEED VIDEO	4	6	6									
REELS	4	6	6									
STORY	89	85	53									
TOTAL	110	102	81									
JENIS	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	19402	19541	19628									
JENIS	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	311	242 300	177									
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



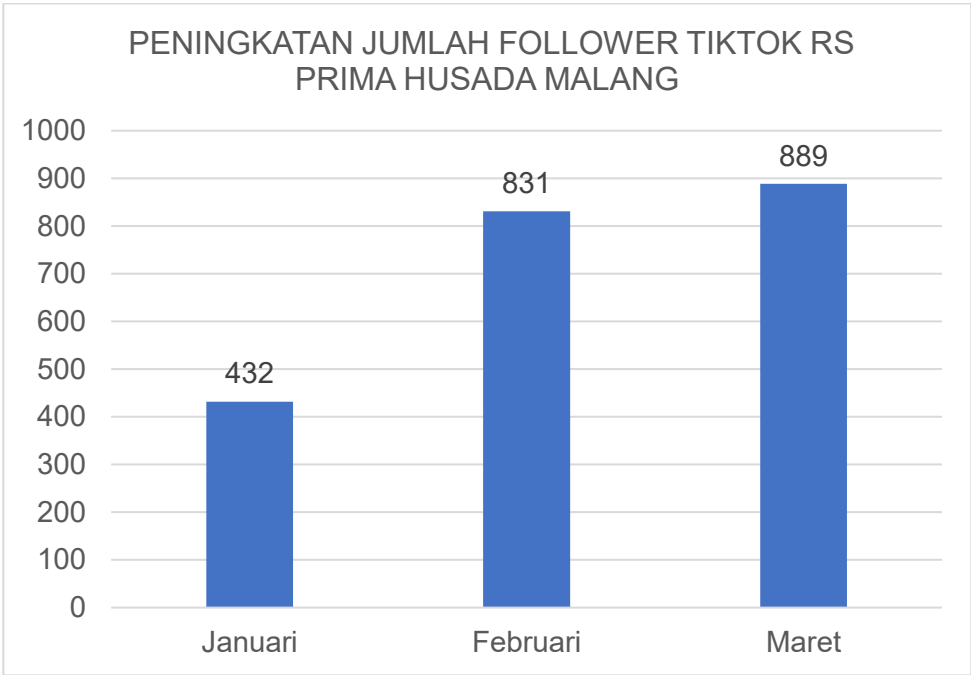
Analisa :
 Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 87 Followers atau sebesar 0.45% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH KONTEN BARU	2	9	5									
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH FOLLOWER	432	831	889									

(CUT OFF TANGGAL 1)												
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	23	399	58									
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH LIKE	1876	3374	3753									



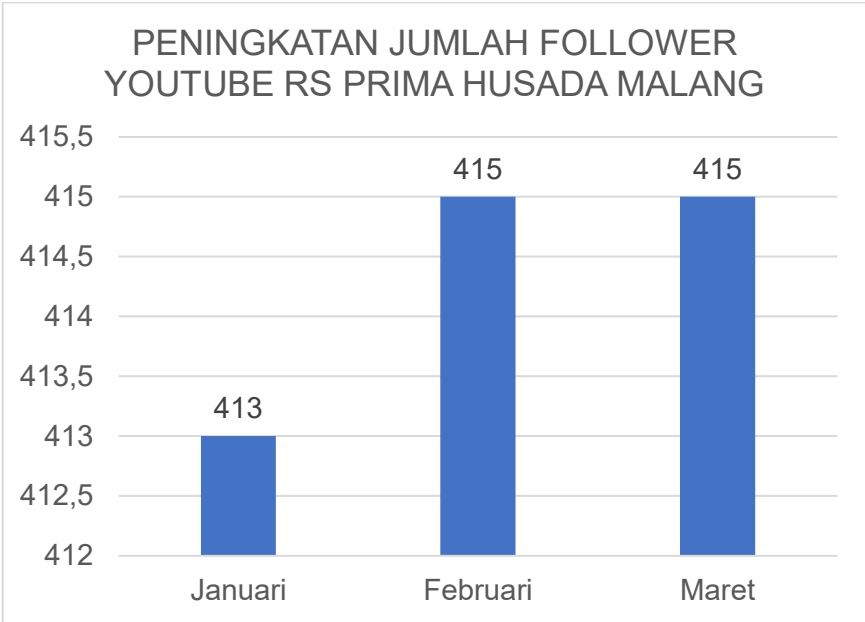
Analisa :
 Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 58 Followers atau sebesar 6,98% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH KONTEN BARU	0	0	0									
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH SUBS	413	415	415									
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	5	2	0									0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

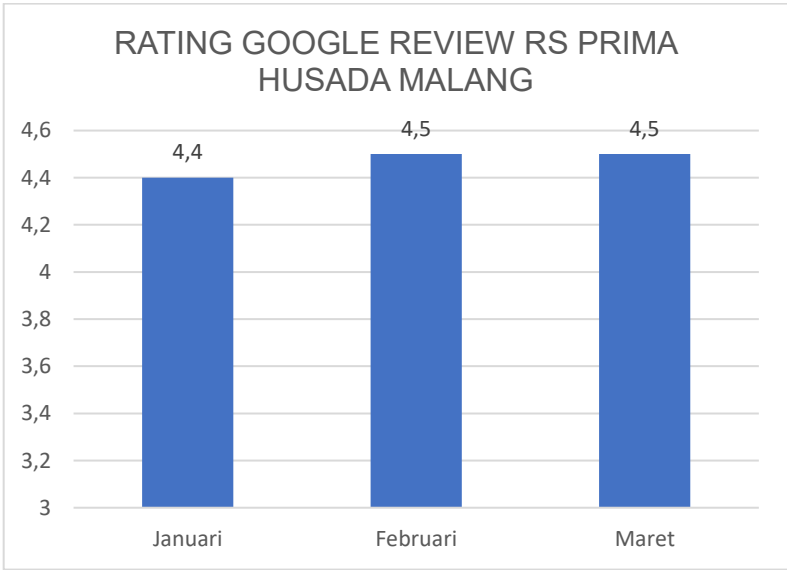


Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 1,23 % dari bulan Sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.4	4.5	4.5									



BULAN	RATE CAPAIAN GOOGLE REVIEW	
	POSITIF	NEGATIF
Januari	122	4
Februari	133	3
Maret	114	5

- Analisa :
- 1. Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan sebelumnya
 - 2. Pengisian Google Review mengalami penurunan 17 review atau sekitar 12,50% dibanding bulan sebelumnya.
 - 3. Pengisian Google Review dengan Rate Positif mengalami penurunan 19 review atau sekitar 14,29% dibanding bulan sebelumnya.
 - 4. Pengisian Google Review dengan Rate Negatif mengalami kenaikan 2 Review atau sekitar 66.67% dibanding bulan sebelumnya.

- Rencana Tindal Lanjut :
- 1. Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PERIODE MARET 2026 :																
1	Anmrasi	461.465.393	193.528.071	4.310.834	263.626.289	158.543.613	6.215.252	394.100	149.394.231	413.560.520	272.949.793	22.595.779	16.292.084	72.748.181	28.942.744	413.560.521
2	Perencanaan	813.394.362	572.295.081	2	241.099.079	195.137.861	-	-	195.137.861	436.236.341	351.694.011	5.273.524	-	5.149.888	80	362.107.545
3	Musdri Isuakth	88.886.956	71.646.305	1208.353	16.025.698	20.018.689	-	-	20.018.689	36.044.387	-	-	-	-	-	36.044.387
4	Juris Pkajerja	274.126.509	146.782.195	0	127.344.314	95.881.591	-	-	95.881.591	223.225.905	223.225.905	-	-	-	-	223.225.905
5	BPJS Ketenagakerjaan	822.682.988	53.931.710	233.468	768.517.810	540.937.989	-	-	540.937.989	1.309.455.799	1.309.455.799	77.867.249	-	-	-	1.309.455.799
Total Saldo										2.416.523.552	8.186.322.556	804.358.632	16.292.084	77.908.107	28.942.764	2.344.394.157
NOTE :																
UNTUK BPJS TK DI BULAN MARET SUDAH ADA PEMBAYARAN SEBESAR Rp 212.834.180 NAMUN BELUM BISA DILUNASI KARENA UNTUK PERINCIAN PEMBAYARAN MASIH BELUM DIBERIKAN OLEH BPJS TK SEHINGGA DIMASUKKAN DALAM TITIPAN PEMBAYARAN.																

Keterangan : Cut off 31 Maret 2026 sebesar Rp 2.344.394.157

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Pasien ranap kurang dari 6 jam atau sudah indikasi rujuk klaim diajukan rajal.	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Tidak ada indikasi pasien diranapkan, klaim rajal	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak sesuai standar pelayanan, indikasi dilakukan tindakan berulang	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Dari hasil penunjang yg dilampirkan tidak tampak batu, dilakukan URS batu UK 0,3-0,4. Sesuai PNPK, ukuran batu 1 cm dpt dengan MET, reseleksi kode 56.0 menjadi 56.31	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Pada laporan operasi masih menggunakan bahasa koding, sesuaikan dengan ketentuan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Tiidak sesuai kaidah pengkodean klinis, px sequele, gunakan kode du I69.3	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Tatalaksana pneumonia tidak sesuai ketentuan, px pro rujuk, RAJAL	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Rehab medis 6x	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi

			Pending
2	Kunjungan kronis potensi PRB iter	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Kunjungan mata berulang tanpa indikasi, rujukan internal/fragmentasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Kunjungan multipoli hingga 5 poli	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	RJ beririsan dgn RI selisih 2 hari, indikasi pre op atau pemecahan episode	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Indikasi numpang rujukan dan self referral (top 5 poli perujuk)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

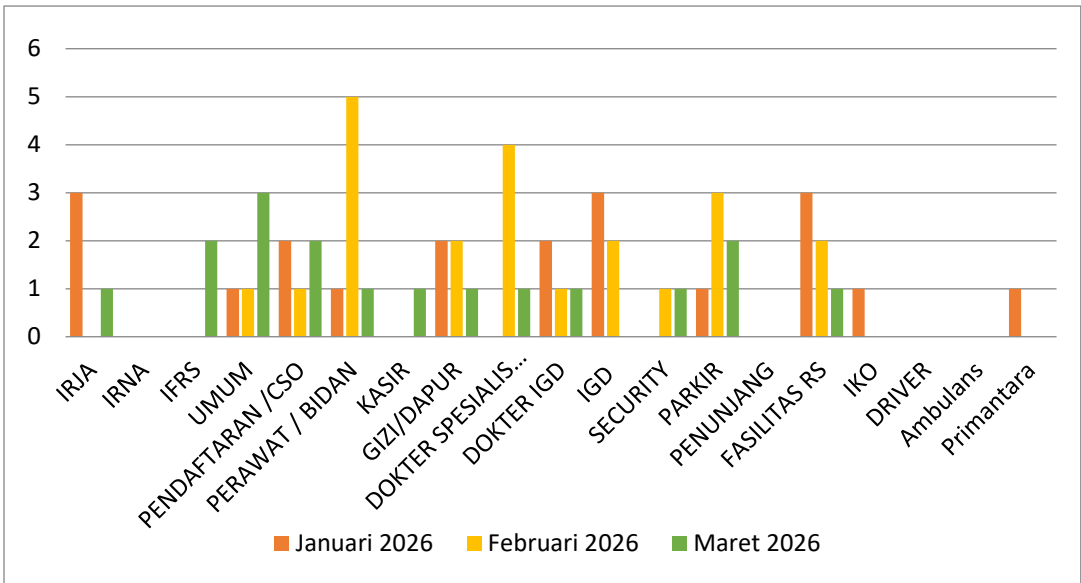
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Februari 2026

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1.	IRJA	3	0	1
2.	IRNA	0	0	0
3.	IFRS	0	0	2
4.	UMUM	1	1	3
5.	PENDAFTARAN /CSO	2	1	2
6.	PERAWAT / BIDAN	1	5	1
7.	KASIR	0	0	1
8.	GIZI/DAPUR	2	2	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	0	4	1
10.	DOKTER IGD	2	1	1
11.	IGD	3	2	0
12.	SECURITY	0	1	1
13.	PARKIR	1	3	2
14.	PENUNJANG	0	0	0
15	FASILITAS RS	3	2	1
16	IKO	1	0	0
17	DRIVER	0	0	0
18	Ambulans	0	0	0
19	Primantara	1	0	0
Total		20	22	17

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Maret 2026



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Maret 2026 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- 1. Jumlah complain Pada bulan Maret 2026 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan januari 2026 sebanyak 20 pasien, pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien. Sedangkan pada bulan maret 2026 sebanyak 17 pasien
- 2. Komplain terbanyak pada bulan Maret 2026 yaitu dari bagian UMUM sebayak 3 kasus, Parkir, CSO dan IFRS sebanyak masing-masing 2 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- 3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 3 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya :
 - Parkir

Terdapat 3 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Maret 2026

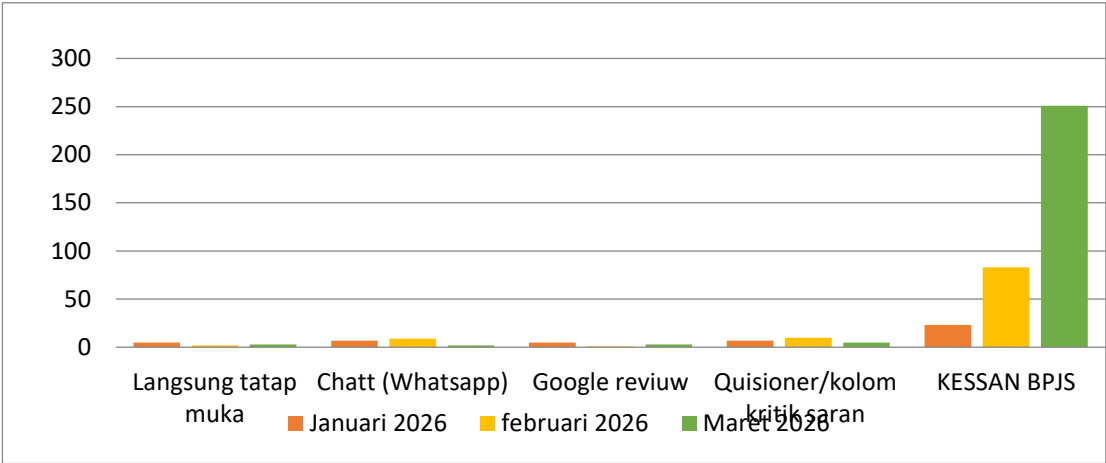
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026
1.	Langsung tatap muka	5	2	3
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	7	9	2
	b. Google reviuw	5	1	3
3.	Quisioner/kolom kritik saran	7	10	5
4	KESSAN	23	83	251

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

	KESSAN BPJS	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
		2	0	4	245	703

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Maret 2026



Analisis :

Pada bulan Maret 2026 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari penilaian KESSAN yang dinilai dari pemberian Bintang 1 sampai dengan 4 yaitu sebesar 251 kasus. Quisioner sebanyak 5 kasus complain. Sedangkan terbanyak dari tatap muka sebanyak 3 kasus complain

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Februari 2026

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google rewiuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	70%	30%	0
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Maret 2026 sudah terselesaikan masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner

dengan capaian 70%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen. Pada bulan Maret 2026 terdapat 3 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya :

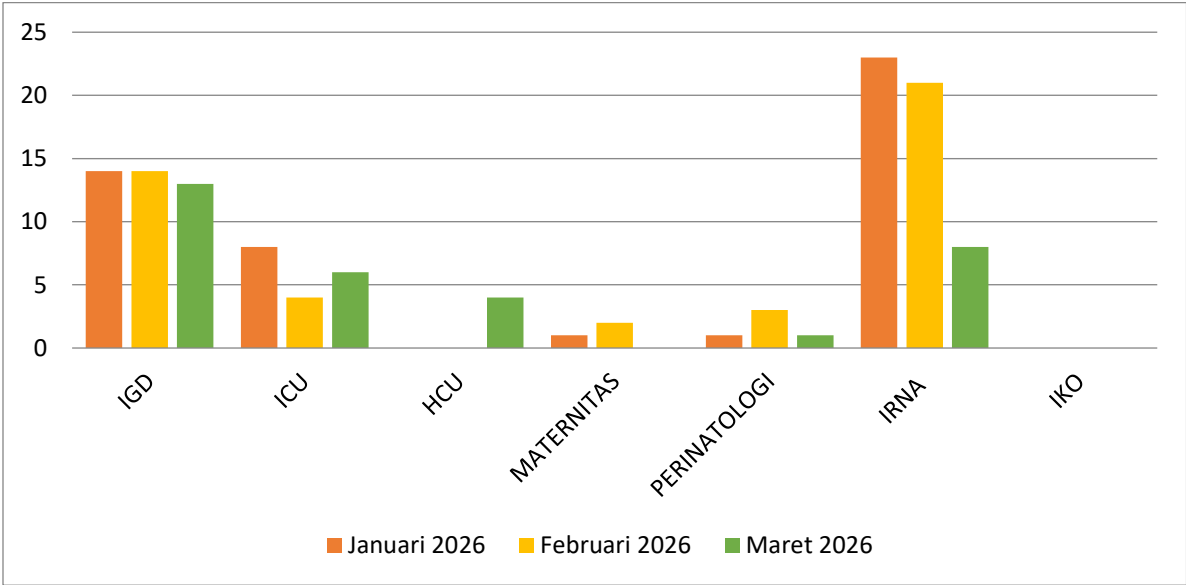
- Parkir
Terdapat 3 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap

Rencana Tindak Lanjut :
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Maret 2026

NO	UNIT PERUJUK	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1.	IGD	14	14	13
2.	ICU	8	4	6
3.	HCU	0	0	4
4.	MATERNITAS	1	2	0
5.	NEONATOLOGI	1	3	1
6	IRNA	23	21	8
7	IKO	0	0	0
Total		51	44	32

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Maret 2026



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Maret 2026

NO	NO RM	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	PLAVON HABIS
1	245848	PUJI ASTUTIK	ICU	SAH e.c Ruptur anguarisme PCOM	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RSUD SOETOMO SURABAYA	Pro *DSA dan claping colling	TIDAK
2	240953	Tn. Yunus	5C	CVA Trombosis 2nd Attack dd Autoimmune Process	DR FAHIMMA, SP. N	RSSA	Pro Unite Stroke	Tidak
3	246015	BY NY SAVIRA AYU MAULIDYAH	NEO	RDS ok Neonatal Pneumonia DD MAS, Upper GI bleeding ok	DR FIONA PARAMITHA SP.A	RST	Pro Subspesialis Neonatologi	TIDAK

				systemic dd local site				
4	146401	MOELJADI	HCU	Cva emboli, Pneumonia, CKD st 3, Cor pulmonale	DR DEWI MAHARANI SP. S	RS LAVALETTE	Pro Unite Stroke/ Tatalaksana lebih lanjut	TIDAK
5	169909	HUSEN	IGD	chest pain dt stemi inferior new onset	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RSSA	PRO PCI	TIDAK
6	194976	ISWAHYUDI	IGD	chest pain dt stemi inferior	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS UMM	PRO PCI	TIDAK
7	105482	DJUMI'AN	IGD	Susp. Close Fracture Femur Dextra	DR ARIANTO, SP.OT	RS SOETOMO SURABAYA	c arm dan Mega Prostesis	TIDAK
8	15199	ABDUL ROKHIM	8A	ESRD, Uresemic Gastropaty, HT, Renal Anemia	DR ARDHI BUSTAMI, SP.PD	RSUD LAWANG	PRO HEMODIALISA	TIDAK
9	246276	NY. SUKARTI	IGD	STEMI ANTEROSEPTAL LATE ONSET KILLIP 1	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RS UMM	PRO PCI	TIDAK
10	194113	INDAH HARTI WINARSIH	ICU	Syok kardiogenik pada CAD post PCI, UAP, CKD stage 4	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RSSA	PRO PCI Back Up HD	SUDAH
11	246294	DIDIK SUSANTO	HCU	1. CVA EMBOLI dd TROMBOSI LUAS 2. HEMATEMESIS 3. HEMIPLEGIA	DR FAHIMMA, SP. N	RSSA	PRO STROKE UNIT	TIDAK
12	246422	NGADISO	8A	TRAUMA TUMPUL THOTAK, PNEUMOTHORAK DEXTRA, MULTIPLE FRACTUR COSTAE 4,5,6,7 DEXTRA	DR. ANDI ABDILLAH, SP.B	RSSA	PRO BTKV+ORIF COSTAE	TIDAK
13	90524	GANDA SARI	5C	SUSP DIFTERI,	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RSSA	PRO RUANG ISO DAN KPTI	TIDAK
14	223333	SABRINA AISYAH PUTRI	7A	ANEMIA NN DT CHRONIC DIAEASE DD ANEMIA HEART DIASES DD AUTOIMUN	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RS LAVALETTE	PRO IPD KHOM	TIDAK
15	246538	NASERI	HCU	shock septic dan DIC, AKI st 3, PPOK AE, ADHF, RBBB	DR ARDHI BUSTAMI, SP.PD	RSSA	pro HD	tidak
16	246422	NGADISO	8A	Trauma tumpul thorak Pneumothorak Dextra Multiple Fraktur Costae 4,5,6,7 Dextra	DR. ANDY SP. P	RSSA	PRO BTKV + ORIF Costae	TIDAK
17	246513	SUGIANTO	IGD	Stemi anteroseptal late onset killip I	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RST	Rujuk pro primary PCI	TIDAK
18	246519	KOES HARTOJO	IGD	Stemi anterior + syok cardiogenik	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RST	Rujuk pro primary PCI	TIDAK
19	238717	MUSTOFA	IGD	CKD St V	DR ARDHI BUSTAMI, SP.PD	RS UB	Rujuk pro HD Cito	TIDAK
20	246571	HARI ERVIAN TO	ICU	STEMI	DR IRA SETYA WATY SP JP	RSI AISIYAH	RUJUK PRO PCI	TIDAK
21	246572	KUMAIYAH	IGD	Gradula DOC dt Susp ME TB dd Septic dd Metabolic Encephalopathy + Susp TB Abdomen + Leukositosis	DR. ANDY SP. P	RST SOEPRAOEN	PRO PERAWATAN LEBIH LANJUT	TIDAK
22	246603	PAITUN	ICU	DOC ec CVA Squel, Uremic Echelophaty, CKD st 5, Hiperkalemi	DR FAHIMMA, SP. N	RS. LAVALETTE	PRO HD	TIDAK
23	246604	HARIONO	IGD	Trauma Okuli (D)	DR DIAH PUSPITA RISAFANTI, SP.M	RSSA	Pro Rekontruksi	TIDAK
24	246533	AMINAH	6A	CVA INFARK, DM HIPERGLIKEMI	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST SOEPRAOEN	PRO UNIT STROKE	Tarif RS : 4.982.213 Tarif INA : 5.484.100 Selisih : -1.974.474
25	112678	SUBOWO	IGD	ANEMIA DT CKD ST 5	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	RSSA	PRO HD CITO	TIDAK
26	102906	SULTHON AGUNG	IGD	ANEMIA DT CKD ST 5	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	RS LAVALETE	PRO HD CITO	TIDAK

27	246702	SUNANIK	HCU	Sepsis DIC Shock septic Uremic encephalopathy ddx septic encephalopathy AKI st 2 Hematemesis	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS LAVALETE	Rujuk pro back up HD Penatalaksanaan sepsis DIC, kultur darah dan deeskalasi pemberian AB berdasarkan hasil kultur.	TIDAK
28	246592	SAFI UDIN	ICU	CVA Emboli, Respiratory Failure, Pneumonia HAP, DM 2. History Of Seizure	DR FAHIMMA, SP. N	RSSA	PRO PDT	
29	72716	SITI MU'IDAH	ICU	Stroke, Phlegmasia cerulea dolens, Septic shock, CKD stage 4	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RSSA	PRO PCD	Tarif RS : 8.557.399 Tarif INA : 4.702.100 Selisih : -3.855.299
30	246939	RIZKY DWI ARIEL WIDODO	IGD	COB dengan multiple fraktur	DR FACHRY, SP.BS	RS SOETOMO SURABAYA	Pro Craniotomy elevasi fraktur + debridement + Orif	TIDAK
31	243623	RISHA FARIT DIANSYAH	6A	1. HIV st 4 (wasting syndrome) 2. pneumonia ddx PCP 3. bisitopenia 4. AKI 5. hipokalemia	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RSSA	rujuk untuk tatalaksana infeksi dan screening infeksi oportunistik lain	TIDAK
32	247088	Ny. AISYAH KAYLA MARIN	IGD	G1P0000AB000 UK 32- 34 MGG DG PEB +	DR HUMAIRAH, SP. OG	RSSA	rujuk pro terminasi kehamilan	TIDAK

Analisis :

- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Maret 2026.
 Pada bulan januari 2026 sebanyak 47 pasien pada bulan februari 2026 sebanyak 44 pasien Sedangkan pada bulan Maret 2026 turunmenjadi 32 pasien.
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus
 - Membutuhkan pengobatan ARV
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
 Pada bulan februari 2026 terdapat plavon minus sebesar Rp. 3.609.112 sedangkan pada bulan maret 2026 Minus Sebesar Rp.5.829.733

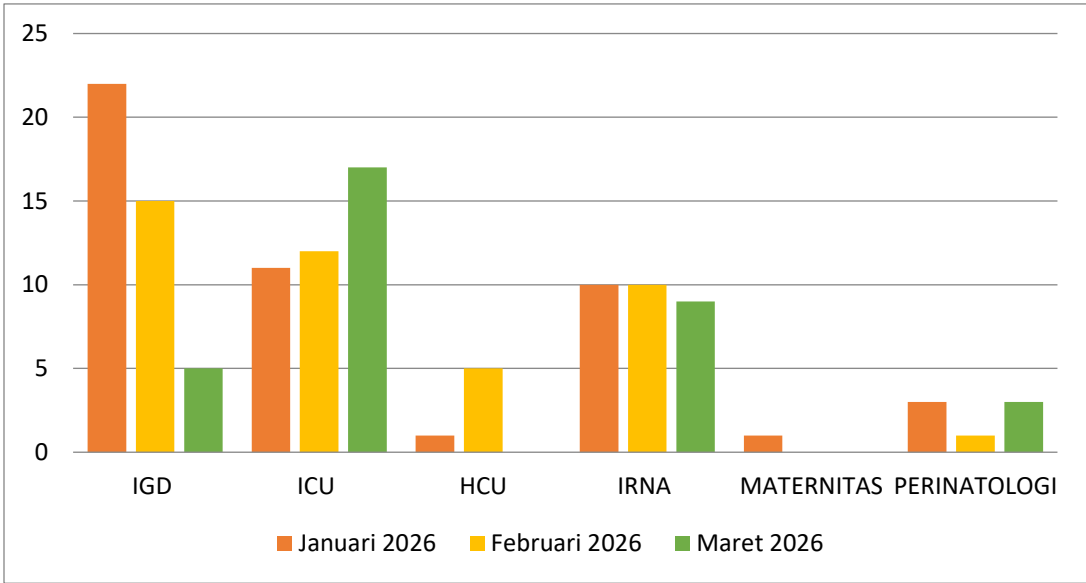
Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Maret 2026

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1.	IGD	22	15	5
2.	ICU	11	12	17
3	HCU	1	5	0
4.	IRNA	10	10	9
5.	MATERNITAS	1	0	0
6	NEONATOLOGI	3	1	3
Total		48	43	34

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Maret 2026



Tabel Rincian Pasien Meninggal Januari 2026

No	NO RM	Nama Pasien	LAMA RAWAT	Status	UNIT	PENYEBAB KEMATIAN	Diagnosis	DPJP	EWS
1	133779	DYAH ROSANTI	1	BPJS Kesehatan	6A	Cardiac Arrest	Colic abdomen dd Ileus	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
2	245908	ABDUL ROKIM	0	BPJS Kesehatan	7A	Cardiac Arrest	Ileus Obstruction	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
3	245799	SULHAN ARIFIN	5	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac Arrest	Post craniotomy evakuasi ICH+EDH	DR FACHRY, SP.BS	√
4	74866	SODIK ROKHIM	7	UMUM	ICU	Cardiac Arrest	DOC dt hepatic encephalopathy	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
5	245865	ALIYAH	4	BPJS Kesehatan	8A	CARDIAC ARREST	SELULITIS PEDIS SINISTRA, DM TIPE 2, PAC	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
6	246070	BY NY. DAYINTA DAMARIS M	1	UMUM	NEO	ANENCHEPALY	NPBBLSR, ANENCHEPALY	DR RATIH KUSUMAWARDHANI, SP. A	√
7	246017	BAMBANG EDY SUSILO	3	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	CVA ICH, EDH POST VP SHUNT	DR FACHRY, SP.BS	√
8	245712	MUHAMMAD SYAFIQIL MAHBUBI	11	BPJS Kesehatan	ICU	respiratory failure	respiratory failure,BP NEC atelektasis superior dextra syok (+) susp PJB low intake feeding difficulty	DR RATIH KUSUMAWARDHANI, SP. A	√
9	83359	MU'ABIDAH	4	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	SUSP ILLEUS , CA CERVIX,CKD	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
10	94219	SUMININGSIH	4	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	Respiratory failure, Shock septic, Shock condition, AKI	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
11	240856	NUR HADI SUBHAN	1	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	Syok sepsis + DM hipoglikemia + AF RVR + Selulitis femur D dd compartment syndrome	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	√
12	96412	SOLIKAH	6	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	Respiratory failure on ventilator dt CVA 2nd attack, Pneumonia VAP, HF dt HHD, AKI dt shock condition	DR DEWI MAHARANI SP. S	√
13	245611	SUDJANTO	1	BPJS Kesehatan	IGD	CARDIAC ARREST	CARDIAC ARREST	DR YOLANDA	√
14	246297	PONTJO PRASETYO	1	BPJS Kesehatan	IGD	CARDIAC ARREST	CARDIAC ARREST	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
15	65426	DARSONO	1	umum	IGD	CARDIAC ARREST	DOA	DR YUNIAR ARDY	√
16	204761	DJUMI	3	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	DOC + obs.dypsnea e.c susp.ckd	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
17	116454	RIZKY KHOIRUL NIZAR	3	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC ARREST	respiratory failure+ARDS+ Asidosis metabolik+DOC ec hiperurisemia+dss	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
18	246269	H MOH IHSAN	5	BPJS Kesehatan	5C	CARDIAC ARREST	PVC+ SHOCK CONDITION	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√

19	241693	SIJANI	2	BPJS Kesehatan	8A	CARDIAC ARREST	Open Wound + COR Post op Debridement	DR FACHRY, SP.BS	√
20	246407	PONAH	3	BPJS Kesehatan	6A	CARDIAC ARREST	DM Hiperglikemi, Hipernatremi	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
21	246448	BUASAN	2	BPJS Kesehatan	IGD	CARDIAC ARREST	PNEUMONIA dd TB dd DM Hipoglikemia	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
22	-	BY NY ANANDITA	1	UMUM	NEO	ABORTUS	ABORTUS / BBLASR	DR HUMAIRAH, SP.OG	√
23	246457	MUZAROH	5	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC AREST	CVA ICH , EDH, POST CRANIOTOMY	DR FACHRY, SP.BS	√
24	246571	HARI ERVIAN TO	1	BPJS Kesehatan	ICU	-	STEMI ANTEROPOSTERIOR	DR IRA SETYA WATY SP JP	√
25	245616	SRIANAH	4	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC AREST	Respiratory failure on ventialotor + Efusi pleura dextra + Susp.TB + Hiperkalemia	DR. ANDY SP. P	√
26	245815	MARKUS EDI SETIAWAN	1	umum	IGD	DOA	DOA	DR YOLANDA	√
27	246553	SARMI KUSUMAWATI	5	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC AREST	Respiratory failure, Post debridement +amputasi pedis D digiti 2-3, DM, Sepsis	DR ANTON, SP.B	√
28	67616	TASRI	1	BPJS Kesehatan	ICU	CARDIAC AREST	SUSP DVT CRURIS DEX, AF, ALO, POST RIWAYAT STROKE	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
29	-	BY NY DEVINTA AYU	1	UMUM	NEO	IUFD	IUFD	DR AIDA, SP.OG	√
30	70978	MATRAWI	4	BPJS Kesehatan	5C	Cardiac arest ac malignancy	Nstemi, Cardiogenic shock	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
31	246902	MUJIAN TO	4	BPJS Kesehatan	5C	Cardiac arest	CVA INFARK ICH+PONS	DR AKHMAD SYAHRIR SP N	√
32	246912	MUNTHOLIP	4	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	Mitral insufiensy Respiratory failure Cva infark	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
33	50300	JUMAKYAH	2	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	Shock sepsis Respiratory failure	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
34	148804	MUHAMMAD SYAUQI ALBAR	3	BPJS Kesehatan	4A	Cardiac arest	syok hipovolemik + fibrosarkoma st IV + GEA kronis	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√

Analisa :

- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Maret 2026 sebanyak 34 pasien
- Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 17 pasien IRNA : 9 pasien IGD : 5 pasien dan Neo : 3 pasien
- Pada bulan Maret 2026 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 2 kasus.
- Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Usia lanjut	7	6	2
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	0	0	0
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	0	0	0
4	Perkiraan biaya tinggi	8	6	3
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	0	0	0
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	0	0	0
7	Potensial komplain tinggi	12	4	1
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	0	0	0
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangnya	0	0	0
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	0	0	0
11	Berpotensi masalah hukum	0	0	0
12	Naik kelas pelayanan	0	4	7
13	Lain - lain	8	7	10

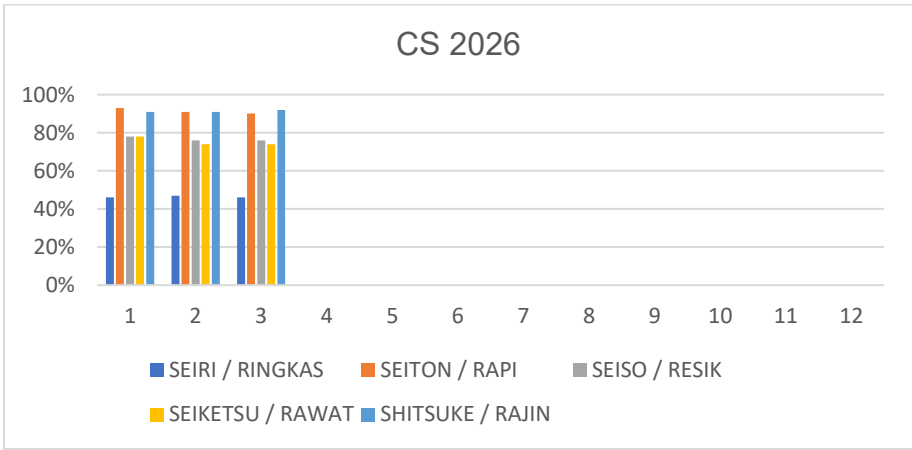
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEIRI / RINGKAS	46%	47%	46%									
2	SEITON / RAPI	93%	91%	90%									
3	SEISO / RESIK	78%	76%	76%									
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	74%	74%									
5	SHITSUKE / RAJIN	91%	91%	92%									



Analisa :
Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

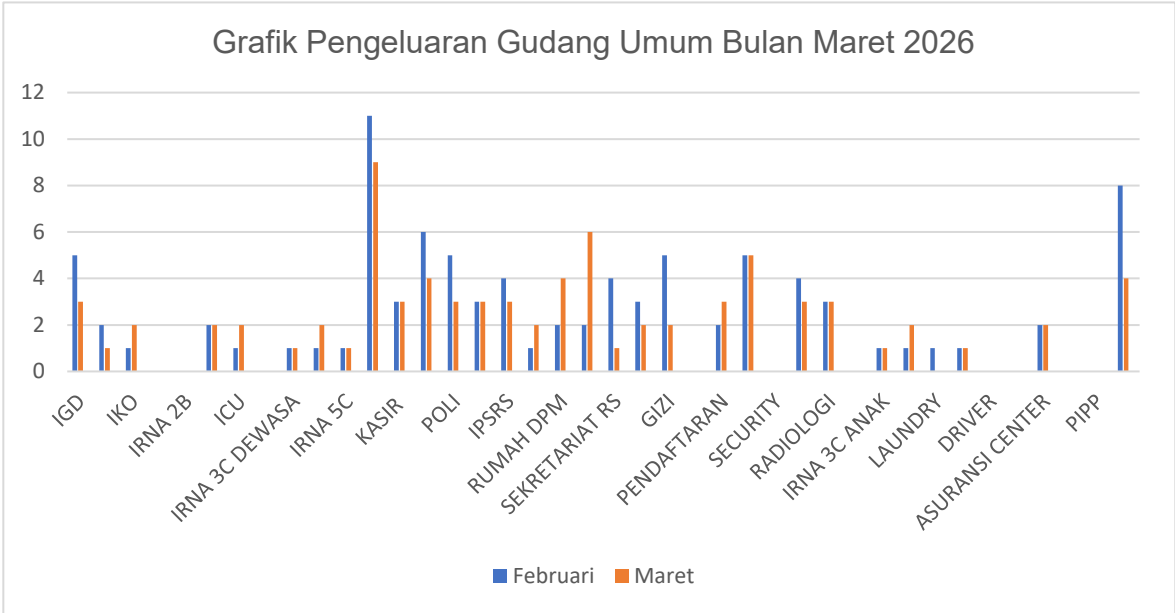
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		FEBRUARI	MARET	
1	IGD	5	3	↓-66,66%
2	MATERNITAS	2	1	↓-50%
3	IKO	1	2	↑50%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	2	2	↑0%
7	ICU	1	2	↑50%
8	IRNA 3A+4A	0	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	1	1	↓0%
10	IRNA 4A	1	2	↑ 50%
11	IRNA 5C	1	1	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	9	↓-22,22%
13	KASIR	3	3	↑0%
14	DAPUR	6	4	↓ -50%
15	POLI	5	3	↓-66,66%
16	CLEANING SERVICE	3	3	↓0%
17	IPSRS	4	3	↓-33,33%
18	GUDANG FARMASI	1	2	↑50%
19	RUMAH DPM	2	4	↑50%
20	SEKRETARIAT PT	2	6	↑66,66%
21	SEKRETARIAT RS	4	1	↓-100%
22	CSSD	3	2	↓-50%
23	GIZI	5	2	↓-100%
24	REKAM MEDIS	0	0	↓0%
25	PENDAFTARAN	2	3	↑33,33%
26	DEPO FARMASI	5	5	↑0%
27	SECURITY	0	0	↓0%
28	LABORATORIUM	4	3	↓-33,33%
29	RADIOLOGI	3	3	↓0%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	1	1	↓0%
32	NS NICU	1	2	↑50%%
33	LAUNDRY	1	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	1	↑0%
35	DRIVER	0	0	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	2	2	↓0%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	8	4	↓-100%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , dan Poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

1.3.5.10.1 Pemeliharaan PC Server

Tabel 6. Pemeliharaan PC Server

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	server SIMRS 2, CCTV, INACBG, SIMIPSRs, SYNOLOGY, FINGER, NYESHARE, SIDOKAR, FREENAS	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun					
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun					
	AGUSTUS						

	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.2 Pemeliharaan Mikrotik

Tabel Pemeliharaan Mikrotik

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	FEBRUARI	56x/bulan	56x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	MARET	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	
	APRIL						
	MEI						
	JUNI						
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.3 Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

Tabel 8. Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	1x/bulan	1x	100%	16/01/2025	Gedung A1, A2, DPM, Gedung B, Gedung C, Maternitas, Gudang Farmasi, Poli sentral It1, It2,	

						Ruang Server IT, Parkiran Karyawan, Blok 3, Parkiran Belakang, Server IPCAM	
	FEBRUARI	1x/bulan	1x	100%	14/02/2025	Selesai	
	MARET	1x/bulan	1x	100%	09/03/2026	Selesai	
	APRIL						
	MEI						
	JUNI						
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.4 Pemeliharaan Modem Internet

Tabel 9. Pemeliharaan modem internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2015	Modem Indibiz, D-NET, Biznet, Indihome	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun					
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun					
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.5 Pemeliharaan Komputer Unit

Tabel Pemeliharaan Komputer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	15PC/Bulan	4x	26%	26/01/2025	Gate Parkir, Server Gate Parkir, Server IPCAM, Irna lantai 2A	
	FEBRUARI	15PC/Bulan	7x	47%	17/02/2026	Belum selesai	
	MARET	15PC/Bulan	8x	54%	23 s/d 25 maret 2026	PC all Farmasi	
	APRIL	15PC/Bulan					
	MEI	15PC/Bulan					
	JUNI	15PC/Bulan					
	JULI	15PC/Bulan					
	AGUSTUS	15PC/Bulan					
	SEPTEMBER	15PC/Bulan					
	OKTOBER	15PC/Bulan					
	NOVEMBER	15PC/Bulan					
	DESEMBER	15PC/Bulan					

Analisa : Perawatan tidak dilakukan. Karena persiapan survey simulasi akreditasi dan terdapat 1 staf yang cuti Panjang akibat sakit dan urusan administrasi.

Tindak lanjut : melanjutkan maintenance di bulan berikutnya dengan menambah jumlah

3.3.5.10.6 Pemeliharaan Printer Unit

Tabel 11. Pemeliharaan Printer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	1/01/2025	PT, Rekam Medis (management), PDF IGD.	
	FEBRUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	16/02/2026	Selesai	
	MARET	3 Printer /bulan	3x	100%	19/03/2026	Selesai	
	APRIL						
	MEI						

	JUNI						
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						

Analisa :
 Perawatan tidak dilakukan. Karena persiapan survey simulasi akreditasi dan terdapat 1 staf yang cuti Panjang akibat sakit dan urusan administrasi.

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.7 Perapian Kabel Internet

Tabel Perapian kabel internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/Tahun	1x	25%	2/01/2025	Poli THT, Poli Syaraf 2, Poli Obgyn 2, SPI	
2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026		
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.8 Perapian Kabel Telepon

Tabel Perapian kabel telepon

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	31/01/2025	Ruang Server PABX	

2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026	Selesai	
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						



Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.9 Pemeliharaan Access Point

Tabel Pemeliharaan access point

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	04/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						



Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.10 Pemeliharaan Switch Internet di Setiap Panel dan Unit

Tabel Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	09/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge loundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPT						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.11 Pemeliharaan Modem GSM

Tabel Pemeliharaan modem gsm

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						

6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5 10.12 Capaian Kegiatan Lainnya

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Januari	Pergantian printer gate in parkir	Tuntas	Vendor	
2	Januari	Intaslasi Server PACS Radiologi	Tuntas	Internal / Vendor	
3	Februari	Maintenace pc IRNA dengan instal ulang win 10. Untuk print surat pengantar lab	Tuntas	Internal	
4	Februari	Melengkapi dokumen dokumen akreditasi bab MRMIK	Tuntas	Internal	
5	Februari	Penarikan kabel lan internet untuk panel CSO	Tuntas	Internal	
6	Februari	Penambahan cctv di area parkir masjid	tuntas	Internal	

3.3.5 10.13 Rencana Kegiatan Lainnya

NO	Kegiatan	Target (Bulan)	Hasil	Keterangan
1.	Maintenace pc IRNA dengan instal ulang win 10. Untuk print surat pengantar lab	Februari	Tuntas	Yang belum : Irna 7a, Irna 8a
2	Melengkapi dokumen dokumen akreditasi bab MRMIK	Maret	Tuntas	Penambahan umandok diklat pelatihan PPA
3	Penarikan kabel lan internet untuk panel CSO	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Migrasi kabel dari server lama blok 1
4	Perpindahan kabel Fiber Telkom/Telfon di server lama	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Kolaborasi dengan Teknisi indihome
5	Perpindahan dan instalasi ulang kabel internet & telfon untuk area poli paru dan lounge	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Dilakukan internal
	Maintenace pc Farmasi	Maret	Tuntas / Tidak Tuntas	All farmasi
	Order Laptop untuk unit Gizi	Maret	Tuntas / Tidak	Acc Mba Novi

			Tuntas	
	Upgrade PC Baru untuk dr Ashlicah	Maret	Tuntas / Tidak Tuntas	Acc PT
	Tarik Kabel Internet untuk ruangan dr Ashlicah	Maret	Tuntas / Tidak Tuntas	Acc PT
	Perpindahan dan instalasi ulang kabel internet & telfon untuk area poli paru dan lounge	Maret	Tuntas / Tidak Tuntas	Dilakukan internal

3.3.6 Penanganan Keluhan

3.3.6.1 Keluhan Terkait Software

Tabel Keluhan Terkait Software

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	51	51	100%
Februari	32	32	100%
Maret	72	72	100%
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.2 Keluhan Terkait Hardware

Tabel 17. Keluhan Terkait Hardware

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	69	69	100%
Februari	107	107	100%
Maret	54	54	100%
April			

Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.3 Jenis Keluhan

Tabel Keluhan Spesifik

SPESIFIK	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PC	13	30										
PRINTER	17	28										
SIMRS	4	6										
JARINGAN INTERNET	60	57										
TELPON PABX	5	5										
CCTV	3	3										
UPS	1	0										
HP / TAB	3	0										
CAMERA	2	0										
KEYBOARD DAN MOUSE	3	0										
LAINNYA	2	3										
TOTAL	113	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.4 Keluhan lain

No	Kegiatan	Jumlah	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Pindah kabel Fiber Optic indihome untuk telfon	1	tuntas	Vendor	Pindah unit modem dari server blok 1 ke server baru Gedung D
2	Setting dan Pindahan computer manajemen	1	tuntas	internal	
3	Komputer IGD p2 sering	1	tuntas	internal	Ganti motherboard, processor,ram

	hang				baru (Stock komp sekre PT)
4	Komputer IRNA 2a lemot (NUC)	1	Tuntas	internal	Ganti pc ex pdf loket 6

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.5 Progress Peremajaan

Tabel Data PC

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PC RS	JUMLAH PC YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	188	- RM - Verif	IRNA 2A (pakai pc ex pdf loket 6)		
2	Februari	188	- Verif - PC poli ipd perawat	IGD p2 IRNA 2A		Sudah Dilakukan peremajaan
3	Maret	188	- Verif - PC poli ipd perawat			

Tabel Data CCTV

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL CCTV RS	JUMLAH CCTV YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH CCTV YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	100	1 (DPM Depan gerbang rumah 7b)			Pergantian power dvr yang konslet
2	Februari	100				
3	Maret	100	Power supply dvr cctv dpm			Pergantian power dvr yang konslet

Tabel Data Printer

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PRINTER RS	JUMLAH PRINTER YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	44		1. Printer etiket parkir get in Jaminan		Untuk printer belum dilakukan permajaan dikarenakan akan proses ERM

2	Februari	44		1. Admin Jaminan (Ganti sensor head dengan kanibal unit printer yg sudah rusak)		
3.	Maret	44	2 (printer hasil & pengantar laborat)			Head printer lx 310 sudah mulai bergaris

3.3.6.6 Downtime

Tabel Laporan Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	22/01/2026	Tidak Terencana	5 menit	Telkom interdent down gangguan masal	Backup Biznet
2	26/02/2026	Tidak Terencana	60 menit	Gangguan brdging ke server bpjs	Info ke group IT BPJS
3	31/03/2026	Terencana	17.00 s/d 05.00	Maintenance bulanan server BPJS	Info ke pendaftaran proses manual

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	47	44	31									
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	1	0									
JEMPUT RUMAH PASIEN	21	27	19									
ANTAR RUMAH PASIEN	22	21	15									
SAMPEL LAB	31	33	29									
SAMPEL SHK	3	4	3									
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	8	4	3									
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	3									
PENGANTARAN JENAZAH	42	33	34									
RUJUK CT SCAN	0	5	0									
ANTAR MCU RSPHM	0	1	0									
LAIN-LAIN	16	17	18									
TOTAL	191	190	155									

Analisa :
Masih dalam batas normal

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.12 PRIMANTARA

Tabel Jumlah Pengantaran Obat

BULAN	JUMLAH	RATA-RATA / BULAN
JANUARI	1024	40
FEBRUARI	1025	44
MARET	907	39
APRIL		
MEI		
JUNI		
JULI		
AGUSTUS		
SEPTEMBER		
OKTOBER		
NOVEMBER		
DESEMBER		
TOTAL		

Analisa :
Penurunan akibat kunjungan juga berkurang dikarenakan adanya libur lebaran.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

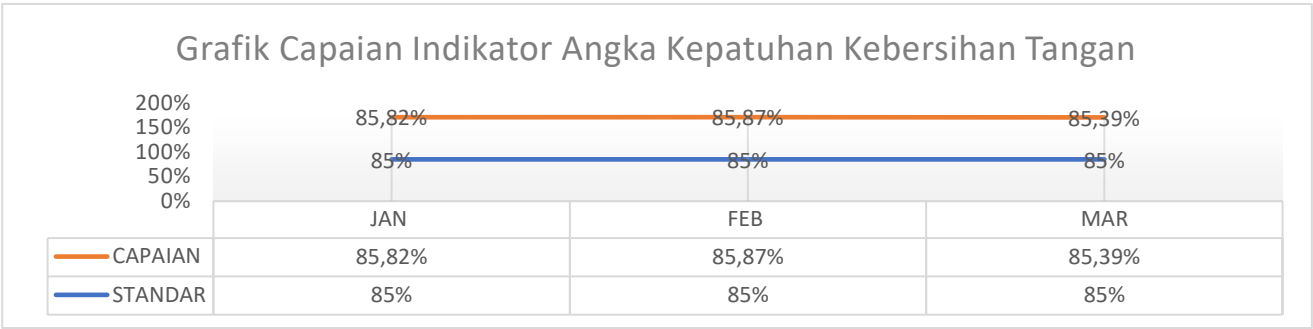
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85.82%	85.87%	85.39%										
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96.82%	96.88%	96.40%										
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99.96%	99.06%	99.89%										
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100.00 %										
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89.9%	86.3%	89.20%										
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0.00%										
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	66.67%	73.63%	68.35%										
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	100%	100%	100.00 %										
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	86.13%	86.07%	86.45%										
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	30.51%	%	18.75%										
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	91.54%	93.31%	95.60%										
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	100%	100.00 %										
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99.7%	99.89%	99.79%										

3.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

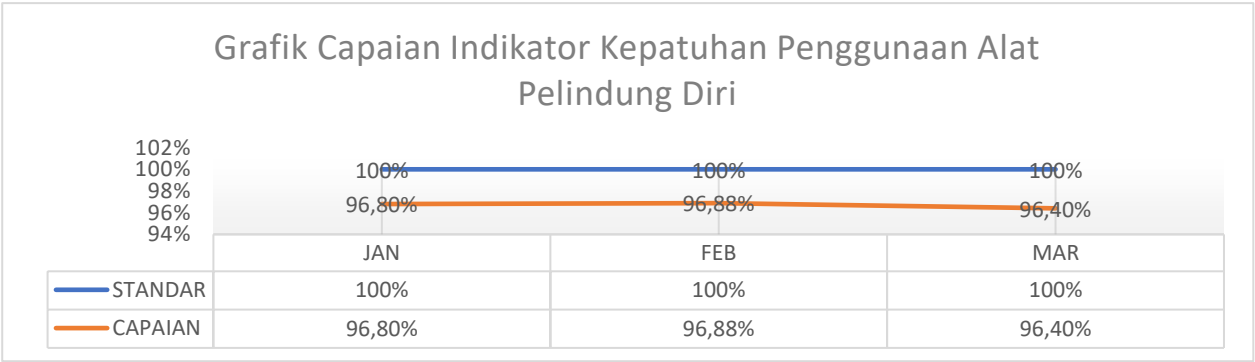


Analisis:

Pada bulan Maret, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai 85.39%. Berdasarkan grafik pada gambar 3.1, diketahui bahwa capaian ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0.48%. Meskipun capaian di bulan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun berada sangat dekat dengan batas tersebut sehigga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaiannya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat program edukasi, monitoring kepatuhan secara berkala, dan pemberian umpan balik kepada petugas. Sebuah studi Quality Improvement yang dilakukan oleh Sitohang dkk., (2025) membuktikan bahwa edukasi tenaga kesehatan, monitoring dan supervise IPCN, serta simulasi langsung 5 *Moments Hand Hygiene* efektif dalam meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan di rumah sakit.

3.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Analisis:

Pada bulan maret, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di RS Prima Husada Malang mencapai 96.40% yang mengalami penurunan dari bulan Februari sebesar 0.48%. Capaian ini masih memiliki gap sebesar 3.60% dari standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Unit yang mencapai angka 100% dalam kepatuhan penggunaan APD terdiri dari IGD, HCU, ICU, PICU, IKO, IFRS, Pengadaan Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Sementara unit yang memiliki angka kepatuhan penggunaan APD terendah berada di IRNA 8A yaitu sebesar 75.83%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Maret tahun 2026

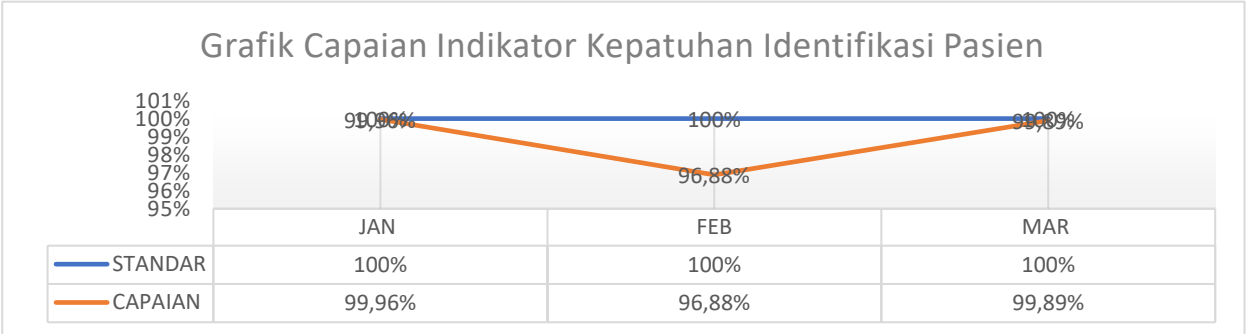
Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD di RS Prima Husada Malang pada bulan Maret 2026 sebesar 96.40% yang artinya masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Terdapat gap sebesar 3.60% yang dapat berisiko pada keselamatan petugas dan pasien. Masalah yang ditemukan adalah masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD baik yang tidak lengkap maupun berlebihan, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata, kebiasaan kerja lama masih memengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten, dan monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan penggunaan APD sehingga mencapai standar minimal (100%) dengan mengingatkan petugas yang memakai APD berlebihan, mengevaluasi penggunaan stok APD, memberikan edukasi, dan melakukan supervisi terkait ketersediaan dan penggunaan APD.
Do	1. Pengawasan penggunaan APD 2. Edukasi penggunaan APD
Study	Capaian target bulan ini masih belum memenuhi standar minimal (100%) sebesar 96.40%. Terjadinya penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya.
Action	1. Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. 2. Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. 3. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 4. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 5. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 6. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 7. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan	Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	1 bulan
2	Peningkatan pemahaman staf terkait APD	Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	Perawat dan tenaga kesehatan	Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	1-2 bulan
3	Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
4	Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Tenaga kesehatan di unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan • IPCN • Komite PMKP	Berkelanjutan
5	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Analisis:

Pada bulan Maret, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai 99.89% yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 3.01%.

Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan (100%) dengan gap sebesar 0.11%. Capaian sebesar 99.89% ini memang menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun adanya gap sebesar 0.11% berarti masih ada ketidakpatuhan dalam identifikasi pasien.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Maret tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Maret sebesar 99.89%. Meskipun capaian ini sangat tinggi, namun masih ditemukan ketidakpatuhan dalam mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Beberapa petugas hanya mengidentifikasi pasien menggunakan nama saja, yang dapat berisiko terhadap keselamatan pasien.
Plan	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan, pemberian obat, maupun pengambilan spesimen. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien.
Do	Komite PMKP bersama kepala unit dan ruangan melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Diingatkan mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan, pemberian obat, pengambilan sampel laboratorium, maupun tindakan lainnya. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.
Study	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui audit kepatuhan identifikasi pasien pada periode monitoring berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien, namun masih ditemukan beberapa petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.
Action	Peningkatan kepatuhan identifikasi pasien

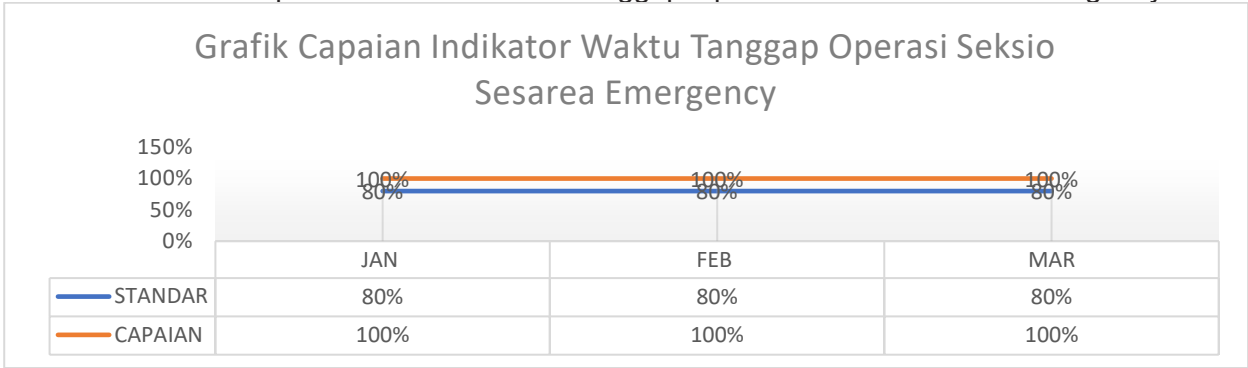
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait	Kepala ruangan	1 bulan

				keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.		
--	--	--	--	---	--	--

3.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

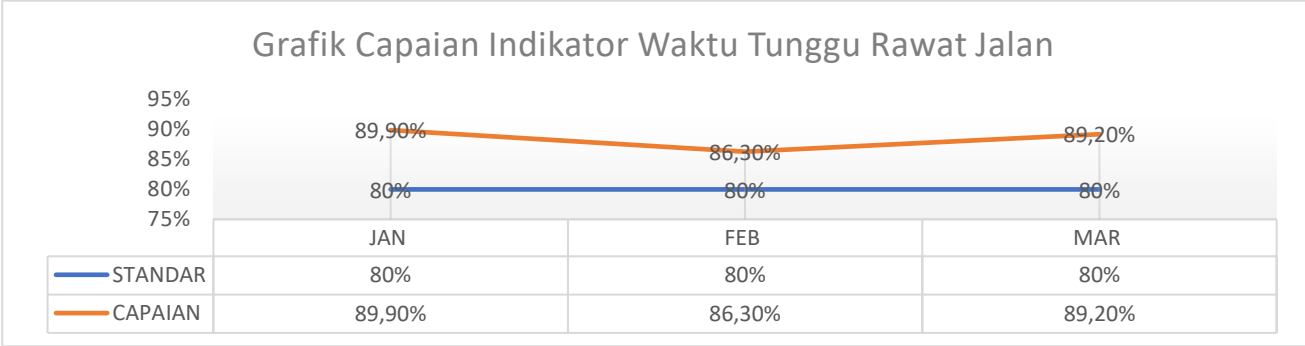


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ≤30 menit mencapai 100%. Capaian tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan (80%). Dari 18 operasi seksio sesarea emergensi, semuanya telah mendapat respons ≤30 menit. hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergensi. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Hasil ini harus dipertahankan untuk meminimalisir risiko adanya komplikasi pada ibu dan bayi.

3.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

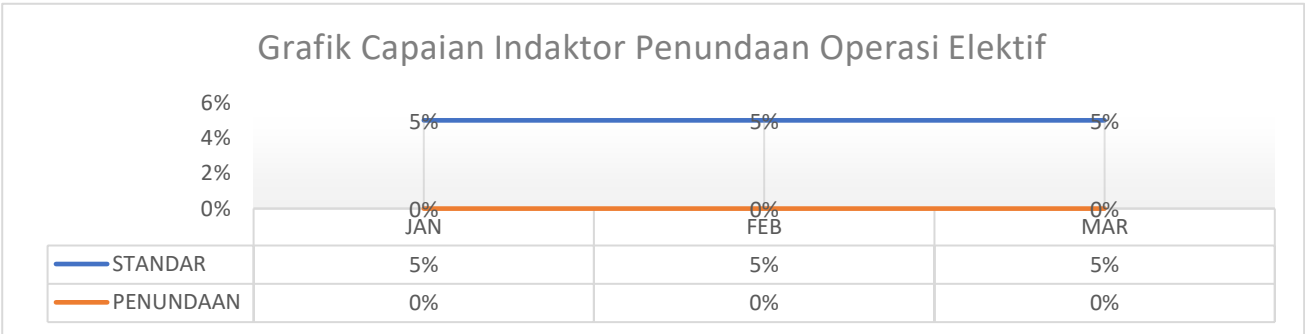


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Malang mencapai 89.20%. Hasil ini telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.90%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah optimalisasi sistem antrean dan pendaftaran online dan penyesuaian jam praktik dokter.

3.1.6 Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



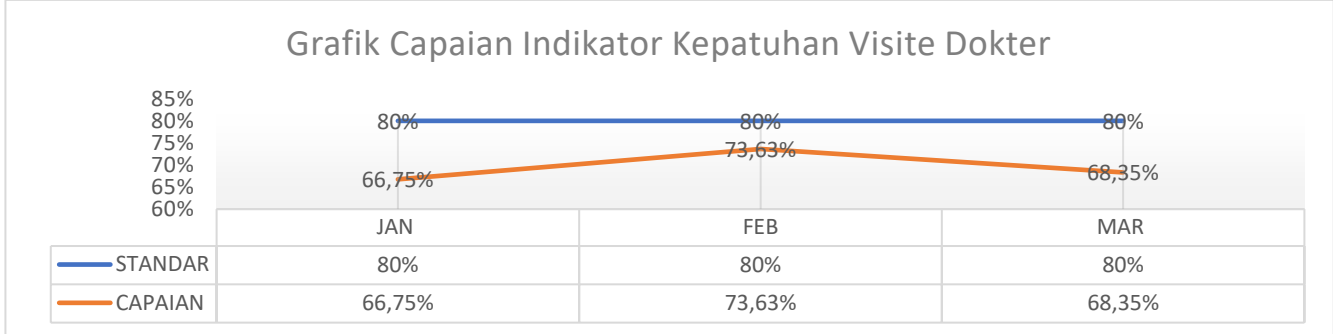
Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, indikator penundaan operasi elektif RS Prima Husada Malang mencapai 0%. Capaian ini telah memenuhi standar yang ditetapkan $\leq 5\%$. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada

Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif , perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, indikator kepatuhan waktu visite dokter RS Prima Husada Malang mencapai 68.35%. Hasil iini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 5.28%. Capaian ini juga tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). Untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan, diperlukan upaya perbaikan.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Problem	Capaian kepatuhan waktu visite dokter sebesar 68.35%, masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa dokter yang melakukan visite di atas jam 14.00. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan waktu visite dokter untuk memenuhi standar minimal ($\geq 80\%$) dengan penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.
Do	1. Penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati 2. Koordinasi perawat dengan DPJP terkait jadwal visite 3. Monitoring pelaksanaan visite oleh manajemen/unit terkait
Study	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Maret yaitu 68.35%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang.

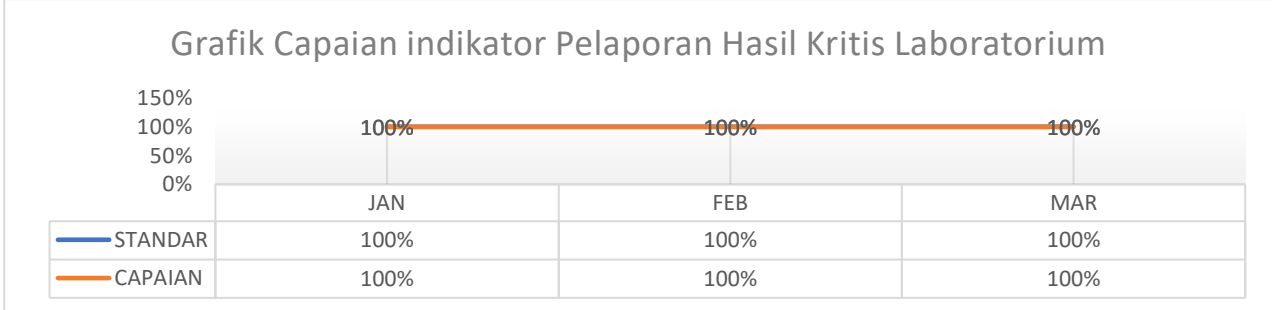
Action	Penguatan komunikasi dengan DPJP
--------	----------------------------------

Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penguatan komunikasi dengan DPJP	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	DPJP yang tidak patuh waktu visite	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan waktu visite dokter secara berkala. Koordinasi dengan Komite Medik akan terus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan waktu visite. Selain itu, kepala ruang rawat inap diminta untuk melakukan pengingat dan pelaporan apabila terdapat dokter yang belum melakukan visite sesuai waktu yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.	Manajemen RS	1 bulan

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

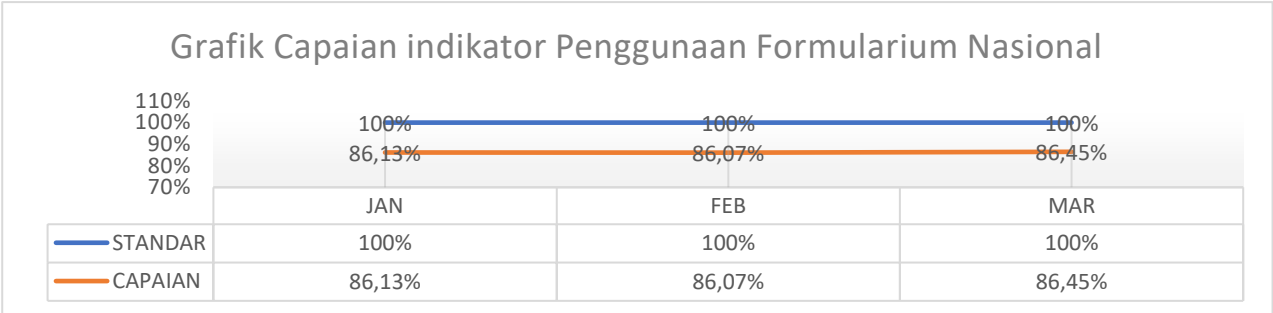


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di RS Prima Husada Malang sebesar 100%. Hasil ini telah memenuhi standar yang ditetapkan (100%). Capaian ini berhasil dipertahankan selama 3 bulan berturut-turut. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu sosialisai kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis dan menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai budaya keselamatan pasien.

3.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium sebesar 86.45%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.38%. Namun, meskipun mengalami peningkatan, capaian ini belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan (100%). Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Problem	Capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional sebesar 86.45%. Hasil ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yakni 100%. Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas), masih ditemukan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan daftar Formularium Nasional sehingga capaian indikator belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional agar memenuhi standar yang ditetapkan dengan upaya perbaikan melalui sosialisasi penggunaan Formularium Nasional kepada tenaga medis, penyediaan daftar Fornas terbaru di setiap unit pelayanan, peningkatan peran instalasi farmasi dalam melakukan skrining resep, serta pelaksanaan audit resep secara berkala untuk memantau kepatuhan penggunaan Fornas.
Do	Upaya perbaikan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional. Selain itu instalasi farmasi mendistribusikan atau menyediakan daftar Formularium Nasional terbaru yang dapat

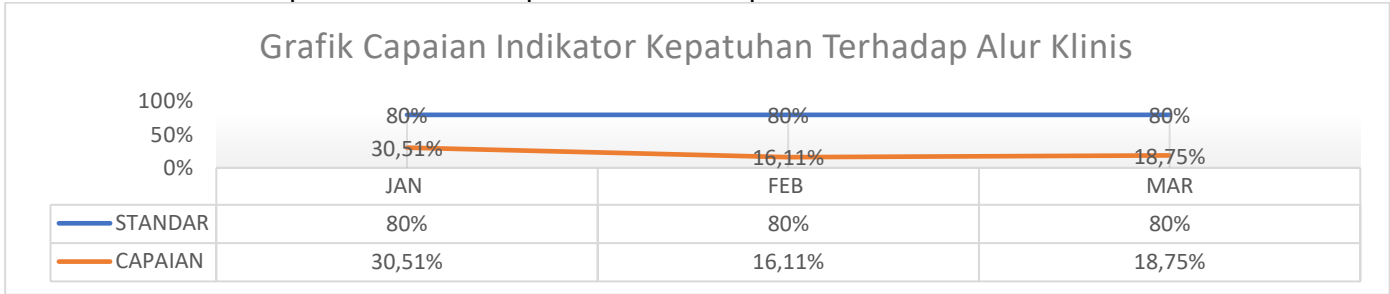
	diakses oleh tenaga medis di unit pelayanan. Petugas farmasi juga melakukan skrining terhadap resep yang masuk untuk memastikan kesesuaian obat dengan Formularium Nasional serta melakukan konfirmasi kepada dokter apabila ditemukan resep yang tidak sesuai. Tim PMKP bersama instalasi farmasi melakukan pengumpulan dan monitoring data penggunaan obat sesuai Fornas secara berkala.
Study	Berdasarkan grafik, diketahui bahwa capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Maret mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas.
Action	Sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pembaruan Fornas	Meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium nasional	Seluruh dokter dan tenaga kesehatan	Berdasarkan hasil evaluasi, apabila capaian indikator masih belum memenuhi standar maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sosialisasi ulang kepada tenaga medis, pembinaan kepada unit dengan tingkat kepatuhan rendah, serta penguatan proses skrining resep oleh instalasi farmasi. Selain itu rumah sakit juga dapat mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit dengan menambahkan fitur pengingat atau notifikasi apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Formularium Nasional. Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini akan terus dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Komite PMKP serta manajemen rumah sakit sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Manajemen RS	1 bulan

3.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:

Pada bulan Maret 2026, capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway*) RS Prima Husada Malang sebesar 18.75%. Hasil ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.64%. Namun, meski mengalami peningkatan, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 61.25%. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diupayakan perbaikannya agar semakin mengecilkan gap dengan standar setiap bulannya.

Tabel PDSA Kepatuhan terhadap Alur Klinis

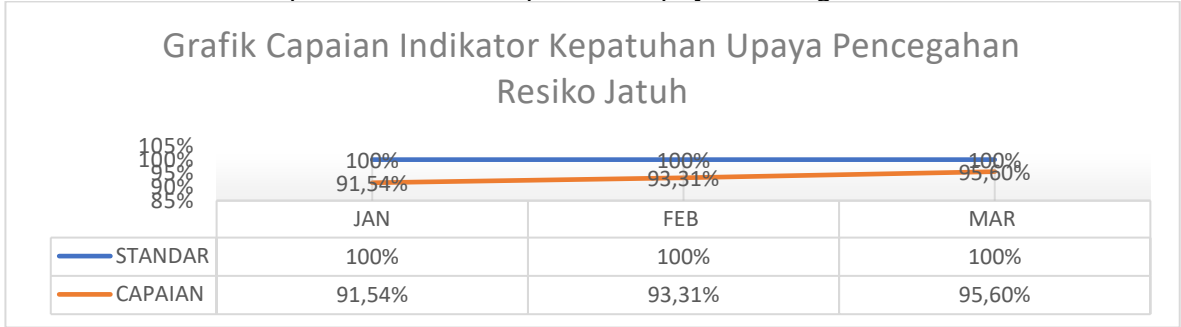
Problem	Capaian kepatuhan alur klinis pada bulan Maret sebesar 18.75%, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.64%. Namun, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan (80%). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga medis belum sepenuhnya patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan. Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, serta kurangnya monitoring dari unit terkait.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap alur klinis agar memenuhi standar yang ditetapkan (80%) dengan sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala ruangan atau PJ Mutu Unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.
Do	Tim PMKP bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.
Study	Capaian kepatuhan terhadap alur klinis pada bulan Maret sebesar 18.75%. Sementara pada bulan Februari mencapai 16.11% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2.64%. Hal tersebut karena tenaga medis belum sepenuhnya patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan.
Action	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)	Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis	Seluruh tenaga medis pelayanan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite PMKP akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan.	• Manajemen RS	1 bulan

3.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 95.60%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.29%. Meskipun capaian ini mengalami peningkatan namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 4.40%. Perlu upaya perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

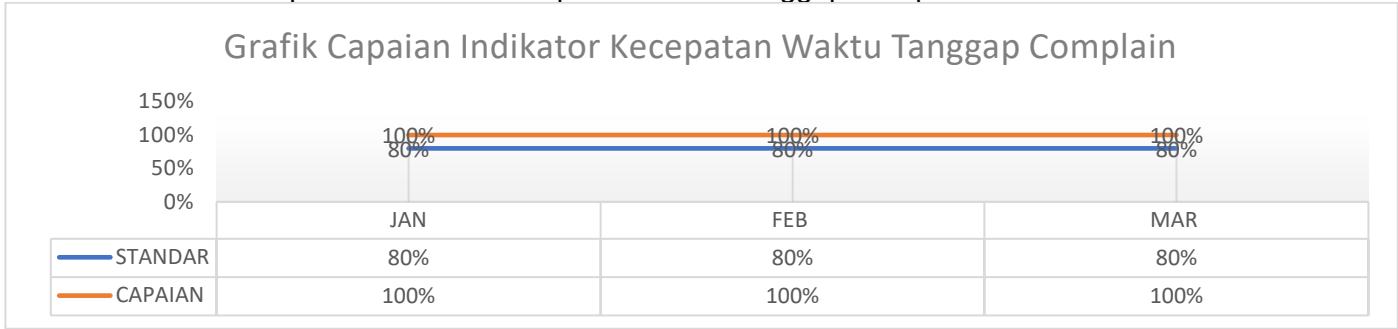
Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Maret sebesar 95.60%. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih di bawah standar 100%. Terdapat gap sebesar 4.40% yang berisiko pada keselamatan pasien. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh agar memenuhi standar 100% dengan sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Do	- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala - Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) - Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko - Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh
Study	Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Maret sebesar 95.60%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Action	Sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan angka kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh	Meningkatkan pemahaman staf tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Seluruh tenaga kesehatan	Sosialisasi ulang standar pencegahan risiko jatuh	• Komite Keperawatan	1 bulan
2	Audit kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan	1-2 bulan

3.1.12 Kecepatan waktu tanggap complain

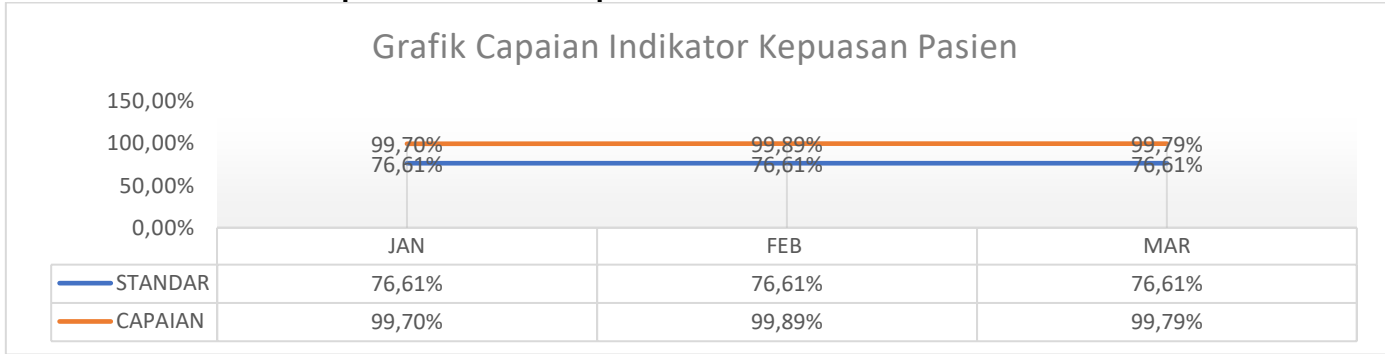
Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain



Analisis:
Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain sebesar 100%. Hasil ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan (100%) dan berhasil mempertahankan capaiannya selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui telfon, WhatsApp dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

3.1.13 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:
Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator kepuasan pasien sebesar 99.79%. Capaian ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0.10%. Namun, angka ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 76.61%.

3.2 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%										
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	100%	-	92.14%	92.90%										
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	100%	85.05%	85.70%	85.91%										
6.	Kepatuhan pemasangan handrell dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	100%	-	87.11%	92.08%										

3.3 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100%	-	7.08%	12.50%										
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100%	-	12.1%	21.48%										
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	100%	-	8.341%	12.05%										

3.4 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	0	5	1	3										

3.5 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%										
2.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	100%	10.38%	17.34%	16.84%										

3.6 Hasil Kegiatan Mutu Prioritas Unit

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	STANDA RT	KET	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26
1	Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI	0%	IGD	-	54.72%	1.53%									
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	0	IGD	-	0	0									
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	0	IGD	-	0	0									
4	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0	Rawat Inap	-	0	0									
5	Ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien	0%	Rawat Inap	-	55.64%	29.92%									
6	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Rawat Inap	-	60.71%	56.75%									
7	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	0%	ICU / HCU	-	70.45%	0%									
8	Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)	0	ICU / HCU	-	0	0									
9	Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien	0	ICU / HCU	-	0	0									
10	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek	100%	Rawat Jalan	-	87.6%	84.62%									
11	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di irja	0%	Rawat Jalan	-	2.55%	2.58%									
12	Target Pasien PRB dan iterasi	100%	Rawat Jalan	-	-	1.14%									

13	Pelayanan tidak sesuai program terapi	0%	Fisioterapi	-	-	0%									
14	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	0%	Maternitas	-	0%	15%									
15	Angka kematian ibu	0	Maternitas	1	0	0%									
16	Kejadian perdarahan post partum	0	Maternitas	3	4	2									
17	Kejadian partus macet	0	Maternitas	20	24	33.3%									
18	Kejadian eklamsi	0	Maternitas	0	0	0									
19	Kejadian pre eklamsi	0	Maternitas	3	0	1									
20	Kejadian infeksi nifas	0	Maternitas	0	0	0									
21	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	Maternitas	12.3%	7.73%	10.6%									
22	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	Maternitas	12.3%	7.73%	22.6%									
23	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	Maternitas	101	88	89									
24	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	Maternitas	0	0	1									
25	Angka Kematian Bayi	0	Neonatologi	0	0	0									
26	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	0	Neonatologi	0	0	0									

27	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	0	Neonatologi	0	0	0									
28	Kejadian re operasi	0	IKO	0	0	0									
29	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	0	IKO	0	0	0									
30	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	0%	Laboratorium	0	0	30									
31	Kejadian Ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	0	Radiologi	0	0	87.76%									
32	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	0	Radiologi	0	0	100%									
33	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	Instalasi Gizi	-	91.09%	100%									
34	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	Instalasi Gizi	-	100%	1									
35	Angka Kelengkapan Asuhan Gizi	100%	Instalasi Gizi	100%	100%	0									
36	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	Instalasi Gizi	2	1	0									
37	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	Instalasi Gizi	0	0	43.06%									
38	Kejadian makanan basi	0	Instalasi Gizi	1	1	0									
39	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	Farmasi	-	43.56%	28%									
40	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	Farmasi	0	0	0%									
41	Respon time sediaan farmasi datang	0%	Pengadaan Farmasi	-	20.6%	99.27%									

42	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	0%	Pengadaan Farmasi	-	0%	100%									
43	Kepatuhan kesesuaian Selisih stok opname	100%	Pengadaan Farmasi	-	99.12%	0%									
44	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	0%	Pengadaan Farmasi	-	0%	0%									
45	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	PPI	0%	0%	1.82%									
46	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	PPI	0%	0%	0.81%									
47	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	PPI	0 ‰	0 ‰	0.17%									
48	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	PPI	0 ‰	0 ‰	9.09%									
49	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	PPI	0.35%	0.3%	0									
50	Angka Decubitus	0%	PPI	0%	0%	0									
51	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	KOM	0	0	0.28%									
52	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	SDM	0%	4.72%	25									
53	Angka turn over staf	0%	SDM	1.4%	0%	1									
54	Kesalahan pendaftaran pasien	0	Pendaftaran	-	25	1									
55	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	0	Pendaftaran	-	4	0									
56	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	0	Pendaftaran	-	0	-									

57	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	0	Rawat Jalan	-	0	-									
58	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	0	K3RS	-	0	-									
59	Klaim pending IRJA <0,5%	<0,5%	Asuransi Center	0	-	-									
60	Klaim pending IRNA <0,1%	<0,1%	Asuransi Center	0	-	-									
61	Klaim tidak layak IRNA	0%	Asuransi Center	0	-	-									
62	Klaim tidak layak IRJA	0%	Asuransi Center	0	-	-									
63	Audit pasca klaim IRJA <1 juta	<1 juta	Asuransi Center	0	-	151.929.783									
64	Audit pasca klaim IRNA 1-2 juta	1-2 juta	Asuransi Center	0	-	-									
65	Selisih klaim (tarif RS > INACBgs) IRJA <50 juta	<50 juta	Asuransi Center	251.175.040	-	88.28%									
66	Selisih klaim RITL 50 - 100 juta	50-100 juta	Asuransi Center	- 1.216.032.654	-	145									
67	Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit	100%	IPSRS	96.83%	98.08%	1									
68	Kejadian kerusakan sarana prasarana	0	IPSRS	124	156	84.62%									
69	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	Gudang Umum	4	8	0%									
70	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	0%	Cleaning Service	90.91%	79.1%	38									

71	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)	0%	Sekretariat	-	-	4									
72	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	Laundry	0	16	0									
73	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	Laundry	1	0	2									
74	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	0	CSSD	2	0	-									
75	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	0	CSSD	0	0	-									
76	Kejadian CCTV tidak terecord	0	IT	0	0	-									
77	Kejadian Komputer dan internet lemot	0	IT	60	53	-									
78	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	Kama Jenazah	100%	100%	-									
79	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	0%	Driver	-	-	10									
80	Kejadian Oncall driver	0	Driver	-	-	1									
81	Penggunaan ambulance Luar RS	0	Driver	-	6	13									
82	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	0	Security	1	0	2									
83	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	0	Security	15	14	0									
84	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	0	Kasir	-	5	13									
85	Keterlambatan pelunasan pembayaran	0	Kasir	1	1	-									

86	kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	0	Kasir	-	4	87%									
87	Keterlambatan pengantaran obat	0	Primantara	-	-	93%									
88	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	PKRS	-	-	90%									
89	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal	100%	PKRS	-	-	-									
90	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA	100%	PKRS	-	-	-									
91	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	100%	PKRS	-	-	-									
92	Angka Kepatuhan Pasien Mengambil Obat di Rumah Sakit	100%	PROGNAS TB	-	-	-									
93	Angka Kepatuhan Petugas dalam Melakukan Edukasi Kelompok sebagai Upaya Pencegahan Penularan TB (4x/bln)	100%	PROGNAS TB	-	-	-									
94	Kepatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC	100%	PROGNAS TB	-	-	-									
95	Angka kepatuhan pengisian Kartu K4 KB	100%	PROGNAS KB	-	-	-									
96	Angka Ibu Pasca Melahirkan dan Pasca Tindakan Curettage yang Mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keluarga Berencana (KB)	100%	PROGNAS KB	-	-	-									
97	Angka Pelaksanaan Pelayanan Konseling KB bagi Calon Peserta dan Peserta Program KB	100%	PROGNAS KB	-	-	-									
98	Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	100%	PROGNAS STUNTING	-	-	1.53%									
99	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	100%	PROGNAS STUNTING	-	-	0									

3.7 LAPORAN KEJADIAN IKP

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1.	1 Maret	Alfira	Instalasi Gizi	KTC	Kejadian makanan basi karena ahli gizi kurang teliti saat menginput update diet di komputer	Peningkatan kedisiplinan staf untuk membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang sudah di update dan fokus saat bekerja.
2.	1 Maret	dr. Akhmad Syahrir, Laras	Farmasi	KTC	Kesalahan input e-resep	4. Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis 5. Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medis dan kepala ruang poli untuk mengecek template resep agar dirubah dan tidak terjadi kesalahan berulang.
3.	2 Maret		Farmasi	KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
4.	10 Maret		IRNA 3C Anak	KPC	Tidak tertulisnya pengkajian alergi obat dari IGD sehingga tidak teroper ke ruangan	Refreshing di IGD mengenai input di e-rm mengenai alergi obat
5.	5 Februari	Elok, Bd. Deya	Maternitas	KTD	Pelaksanaan tindakan kristeller untuk membantu persalinan	6. Audit maternitas 7. Pemahaman ada aturan dari dinkes tidak boleh kristeller 8. KIE tertulis dan ditandatangani kepada keluarga sebelum tindakan persalinan untuk semua pasien bersalin 9. Adfis DPJP tindakan kristeller untuk membantu persalinan 10. Inform consent jika dilakukan

3.7 Indikator Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi Kesehatan

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Waktu pengajuan klaim	< 5 Setiap Bulan	05/02/2026	03/03/2026	05/03/2026
2	% Klaim pending RJTL	< 0,5%	1.94%	5.98%	
3	% Klaim pending RITL	< 0,1%	9.94%	12.04%	
4	Klaim tidak layak RJTL	0 (No)	0	2	
5	Klaim tidak layak RITL	0 (No)	0	0	
6	Audit pasca klaim RJTL	< 1.000.000	0	0	
7	Audit pasca klaim RITL	< 5.000.000	0	0	
8	Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA	< 50.000.000	251.175.043	232.420.665	153.296.445
9	Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA	<100.000.000	- 856.296.127	- 934.791.853	- 772.668.709

3.8 Infdikator Mutu Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan

No.	Indikator Mutu	Standar	Januari	Februari	Maret
1	Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan	Jadwal praktik 100% sesuai = 100	75	75	75
		Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75			
		Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50			
		Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25			
		Jadwal praktik <20% sesuai = 0			
		Tidak ada kunjungan = 100			
2	Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100	50	50	50
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75			
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 50			
		Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0			
3	Umpan Balik Peserta (Customer Feedback)	Σ responden 100% target = 100	25	100	100
		Σ responden 75 - 99% target = 75			
		Σ responden 50 - 74% target = 50			
		Σ responden 25 - 49% target = 25			
		Σ responden <25% target = 0			
4	Update Data Ketersediaan Tempat Tidur	Σ update ≥ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100	100	100	100
		Σ update ≥ 25 hari = 75			
		Σ update 15 - 24 hari = 50			
		Σ update 10 - 14 hari = 25			
		Σ update < 10 hari = 0			
5	Update Jadwal Tindakan Medis Operatif	Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100	100	100	100
		Tidak menginput jadwal TMO = 0			
6	Pemanfaatan Antrean Online terintegrasi MJKN	Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100	100	100	100

	dan Waktu Tunggu Rawat Jalan				
		Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75			
		Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50			
		Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25			
		Pemanfaatan MJKN ≤ 70% target = 0			
7	Penerbitan Surat Kontrol	Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100	100	100	100
		Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75			
		Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50			
		Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25			
		Surat Kontrol terbit ≤50% sesuai = 0			
8	Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik	RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100	50	50	50
		RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75			
		RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50			
9	% Approval SEP	<1%	0,10%	0,20%	0
10	Angka Capaian Iterasi	1854	4,60%	10%	44%
11	Angka Capaian PRB	1370	3,20%	33,20%	85,30%

3.8 Aspek Analisis Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi

3.8.1 Klaim Pending Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. Kunjungan mata berulang tanpa indikasi, rujukan internal/fragmentasi 2. indikasi numpang rujukan dan self referral (top 5 poli perujuk) 3. kunjungan multipoli hingga 5 poli	Dilakukan sosialisasi kepada 5 SMF terbanyak (untuk penekanan rujuk antar Rumah Sakit) dan pemahaman terkait dengan aturan Rujuk Internal dan Konsul Internal	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD	-	-	-

		10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku		
--	--	---	--	--

3.8.2 Klaim Pending Rawat Inap

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	1. Belum Mendapatkan Status Respon Final Dari PT.Jasa Raharja 2. Cara Pulang Meninggal Tidak Sesuai, SEP: - TXT:Meninggal	1. Komunikasi dengan Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan 2. Penertiban terkait pemulangan pasien dengan cara pulang meninggal pada Vclaim	Setiap bulan
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	Tidak ada terlampirnya hasil PA	Koordinasi dengan Laboratorium dan Kabid penunjang terkait dengan waktu penyelesaian hasil PA	Setiap hari dilakukan Follow up untuk hasil PA yang belum jadi sampai sampai jadwal klaim
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. Indikasi Pasien Rawat inap 2. Pasien Dirujuk ditagihkan rawat inap => meminta tagihan menjadi Rawat Jalan	1. Melakukan konfirmasi pada DPJP dan dilakukan monitoring oleh dokter casemix 2. Dilakukan sosialisasi dengan DPJP terkait dengan rujukan antar Rumah Sakit, koordinasi dengan Kabid Pelayanan apabila pasien tidak mendapatkan RS rujukan secara cepat dan apabila pasien dengan advice rujuk dari IGD maka pasien ditagihkan Raeat Jalan	Setiap hari

4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	1. tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, px sequele, gunakan kode du l69.3	Konfirmasi kepada BPJS Kesehatan terkait dengan pengkodean pasien dengan sequele (ditunjang dengan hasil CT San yang seesai)	Setip bulan
---	--------	--	---	--	-------------

3.8.3 Klaim Tidak Layak Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Pasien kunjungan ke poli spesialis dan ke IGD pada hari yang sama	Melakukan koordinasi dengan pelayanan terkait kunjungan 2X dalam 1 hari	Setiap hari
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.8.4 Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	1. Tarif tindakan yang lebih besar dari pada Inacbg's 2. Pasien DM dengan penunjang dan persepan Insulin	2. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait	
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-

4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-
---	--------	--	---	---	---

3.8.5 Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Tarif tindakan yang lebih besar dari pada Inacbg's	Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan	Bulan Maret 2026
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.9 Evaluasi Mutu APM

Tanggal	Jml. Kunjungan	Jml. Mobile JKN	Jml. APM	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan MJKN
Januari	10.955	7.477	4.418	40%	59%
Februari	9.712	6.453	4.456	46%	69%
Maret	8.665	5.660	3.709	43%	66%

No.	Keterangan	Januari	Februari	Maret
1	APM	40%	46%	43%
2	Petugas	60%	54%	57%
Jumlah		100%	100%	100%

1.6.1 Komite PPI

1.6.1.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.1.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

SSI 2026	Bedah Orthopedi	Seksio Sesaria	Apendiktomi	Herniotomi	Katarak	CABG	Tumor Payudara
Januari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	88	73	6	15	46	-	13
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Februari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	66	67	16	8	51	-	15
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Maret							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	80	76	14	7	23	-	8
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0%, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus IDO.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.				
Tindakan yang dilakukan	• Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI. • Monitoring kepatuhan Hand hygiene. • Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan).	• Mempertahankan angka IDO ≤2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.	• Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.	• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan). • Menjalankan audit bundle SSI dengan baik. • Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis. • Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.	• Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.	• Monitoring bulanan
• Pertahankan bundle IDO berjalan dengan baik.	• Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	• Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Monitoring bulanan
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan	• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IPCN	• Monitoring bulanan

pasien pasca operasi			komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-pesan-media-feed back) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
----------------------	--	--	--	--	--

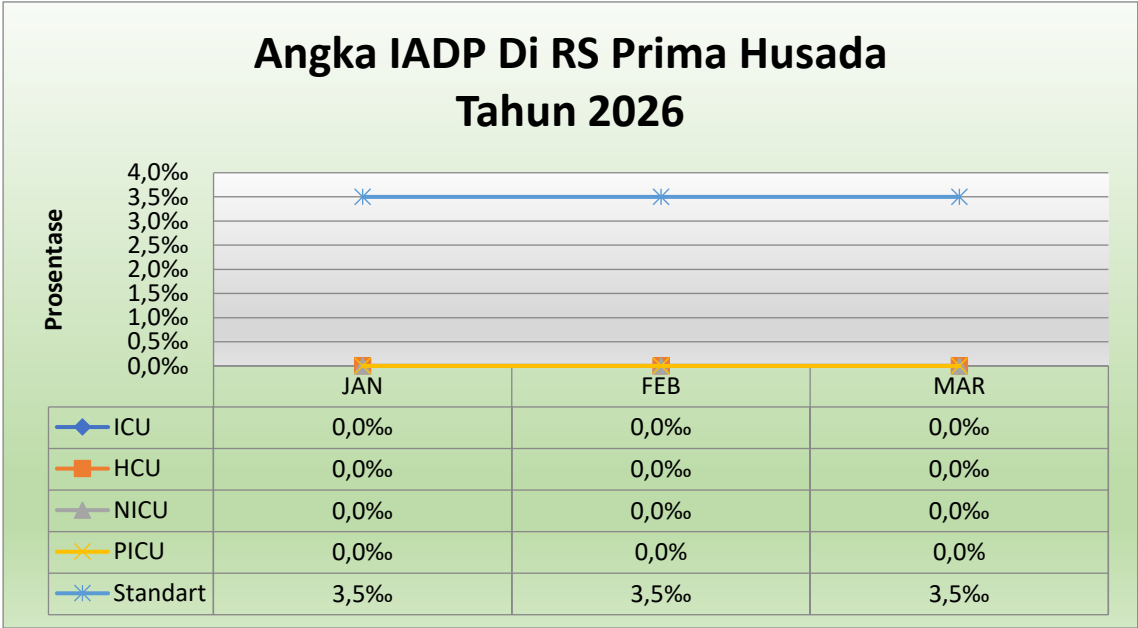
3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

IADP 2026	ICU	HCU	NICU	PICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

3.7.8

Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



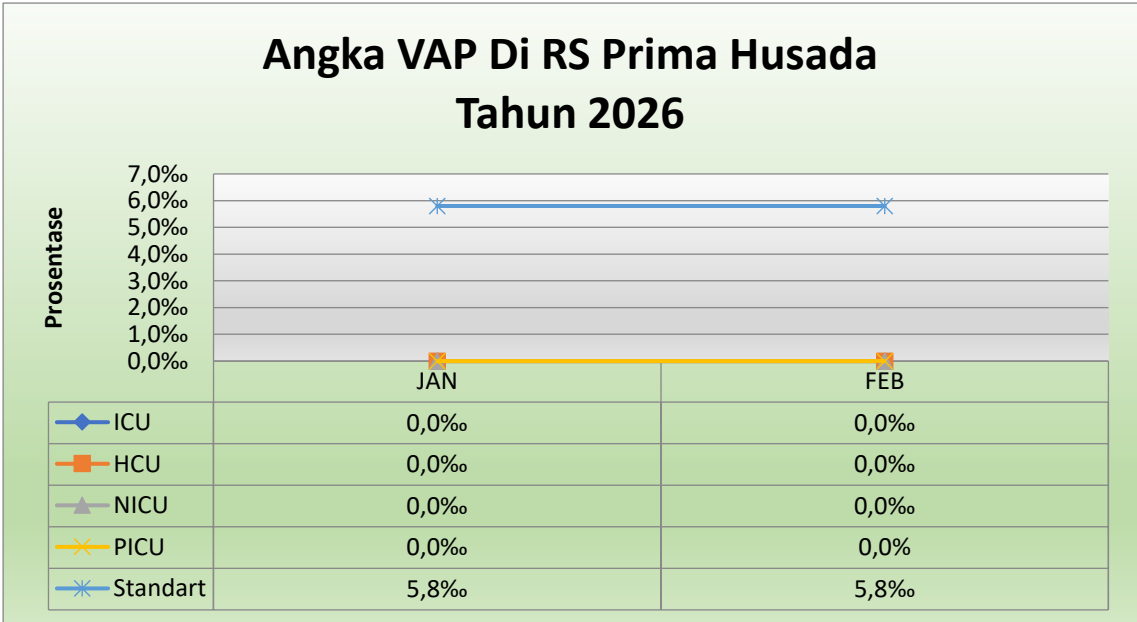
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

VAP 2026	CU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	86	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	78	0	12	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



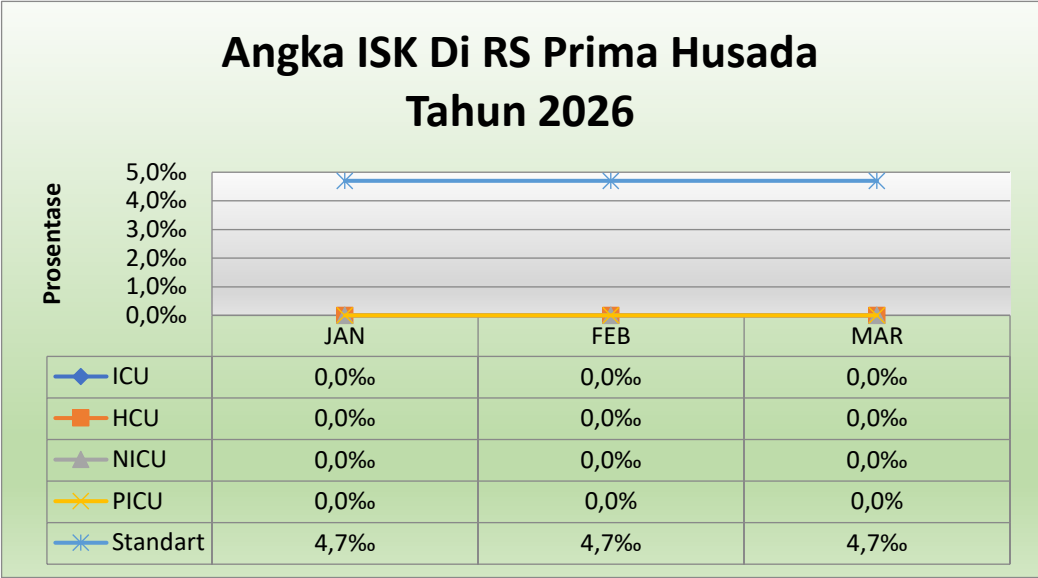
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 80 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini dimana 78 total lama hari pada 13 pasien di ICU dan 12 total lama hari perawatan di ruang PICU pada 2 orang pasien.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. • Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. • Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. • Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. • Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	• Pasien yang terpasang ventilator mekanik	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. • Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. • Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. • Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. • Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPC�	• Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
(Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

ISK 2026	ICU	HCU	PICU	ICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	188	40	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	168	78	6	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	180	45	3	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

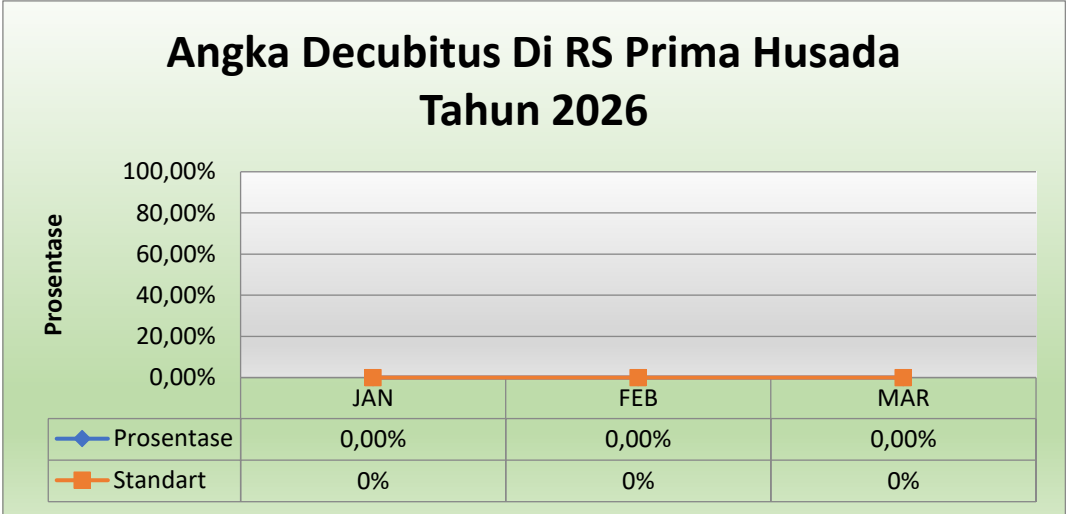
3.7.9 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1035 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. • Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	• Pasien yang terpasang kateter	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

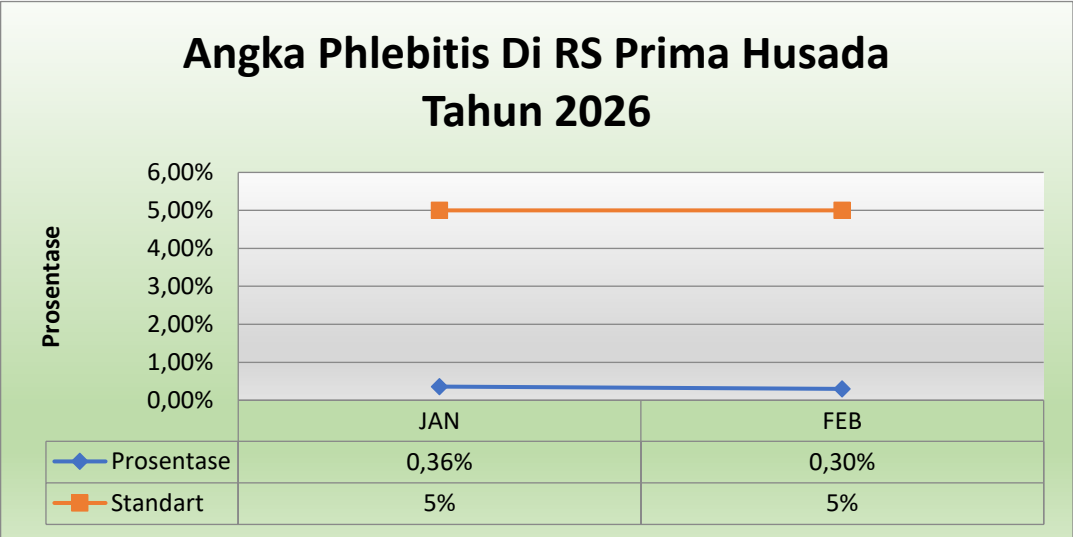
1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 30 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. • Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	• Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain • Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

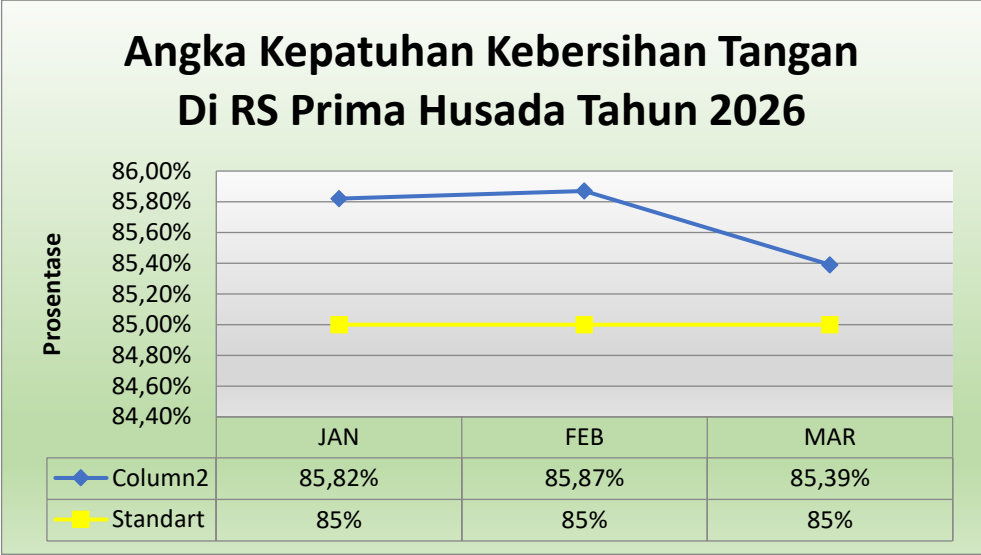
3.7.10 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



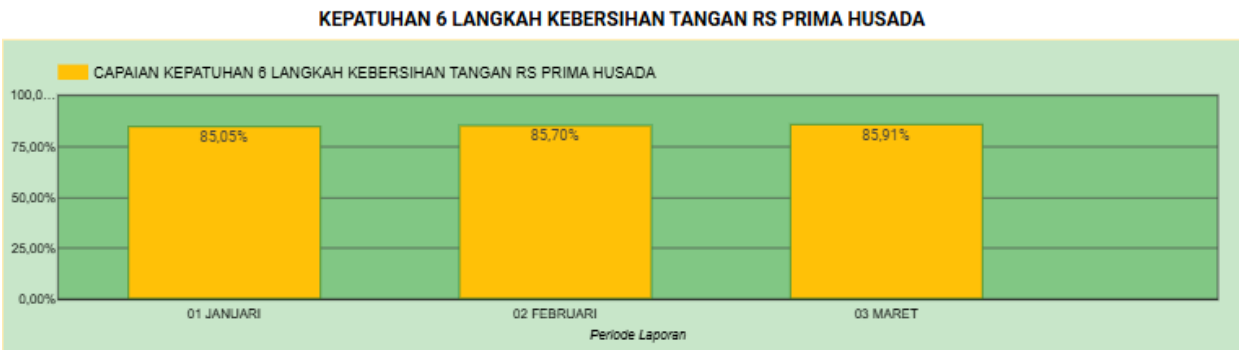
Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2471 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,32%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan Maret berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis peningkatan pada perawatan infus, serta pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Dari data yang diperoleh terdapat 8 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif/antibiotik, pemberian transfusi darah. Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah.				
Permasalahan sebelumnya	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. - Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. - Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. - Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. - Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. - Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	- Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. - Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. - Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. - Menedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCPN	Satu bulan
Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	- Perawat/bidan - Apoteker	- Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. - Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. - Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	- Perawat /Bidan - Apoteker - Karu - IPCLN/PCPN	Satu bulan
Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Perawat/bidan	- Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). - Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus. - Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. - Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCPN	Tiga bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

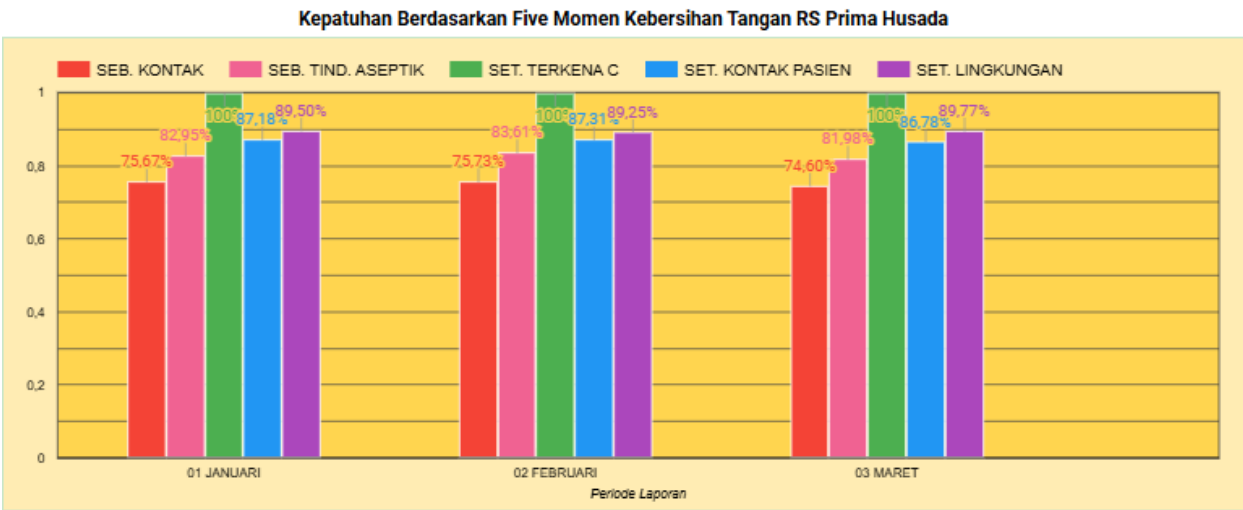
3.7.11 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

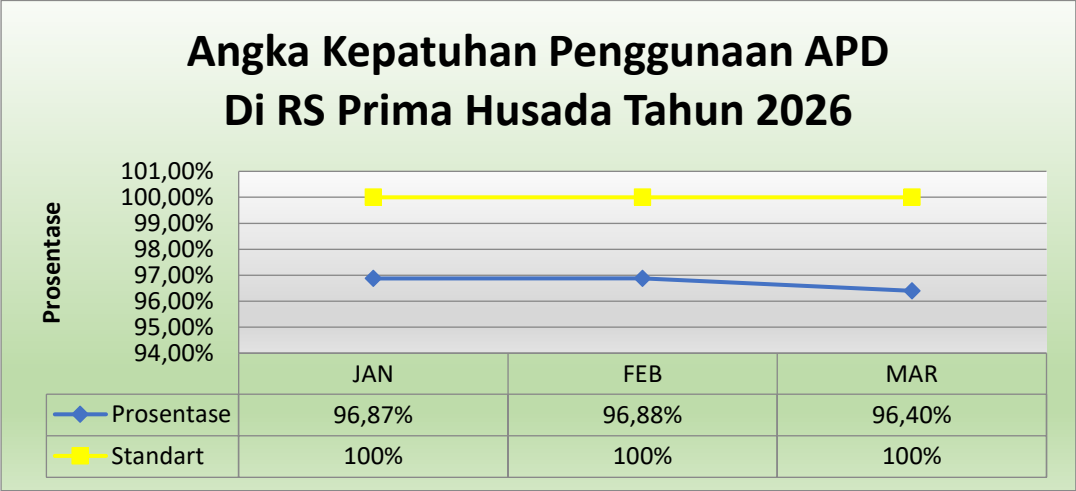


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Maret 2026 berada sedikit di bawah standar (selisih 0,39%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit penurunan kepatuhan, yang berarti ada sedikit penurunan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 85,91%. Nilai ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (Februari 2026: 85,70%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan peningkatan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, bukan hanya peningkatan frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.				
Masalah saat ini	• Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. • Meningkatkan penerapan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Meningkatkan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Seluruh perawat dan tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Sosialisasi ulang 5 momen cuci tangan • Edukasi teknik 6 langkah melalui refresh training • Pemasangan poster & reminder visual di area strategis	• Komite PPI • Karu	• 1 bulan

Peningkatan konsistensi praktik cuci tangan	Meningkatkan konsistensi praktik kebersihan tangan	Seluruh staf unit pelayanan	- Audit kepatuhan mingguan - Feedback langsung hasil observasi - Monitoring ketersediaan sarana (handrub, wastafel, sabun)	- Komite PPI - IPCN - Karu	Mingguan
Peningkatan kepatuhan 6 langkah cuci tangan	Meningkatkan ketepatan teknik 6 langkah cuci tangan	- Perawat - Tenaga Kesehatan lainnya	- Simulasi praktik langsung saat supervisi - Supervisi saat jam pelayanan - Evaluasi melalui checklist observasi	- IPCN - IPCLN - Karu	Mingguan
Peningkatan kepatuhan kebersihan tangan saat tidak diamati.	Mengurangi kepatuhan semu karena observer effect	Seluruh staf	- Observasi acak tanpa pemberitahuan - Penguatan budaya keselamatan pasien koordinasi dengan komite PMKP - Kampanye internal "Hand Hygiene is Safety" jika diperlukan	- Komite PPI - Komite PMKP	Berkala
Peningkatan program kebersihan tangan	Meningkatkan keberlanjutan program kebersihan tangan	Unit pelayanan	- Implementasi rutin program "PPI Quick Tips" - Reward bagi unit dengan kepatuhan terbaik - Rapat evaluasi bulanan	- Komite PPI - Manajemen RS	Setiap bulan

2.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

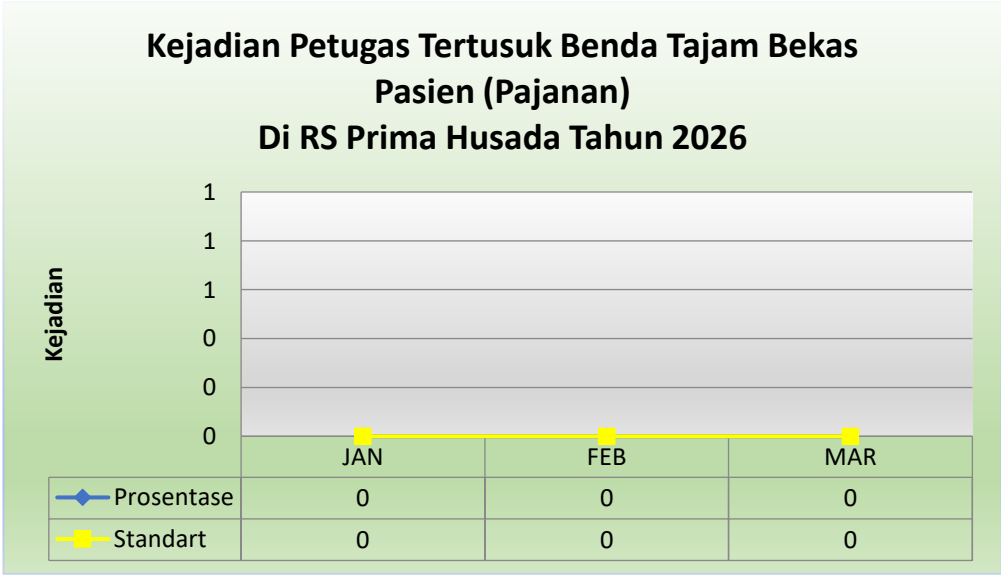


Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 96,40%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak lengkap atau tidak sesuai indikasi pemakaian APD. Terjadi penurunan pada bulan ini, menunjukkan adanya: penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan juga berlebihan menggunakan APD sehingga dianggap tidak patuh. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.				
Masalah saat ini	• Masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD, baik penggunaan APD yang tidak lengkap maupun penggunaan APD berlebihan yang tidak sesuai indikasi. • Pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata. • Kebiasaan kerja lama masih mempengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten. • Monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh unit.				
Permasalahan sebelumnya	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Seluruh tenaga kesehatan	• Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	• 1 bulan
• Peningkatan pemahaman staf terkait APD	• Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	• Perawat dan tenaga kesehatan	• Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	• 1–2 bulan

Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	Komite PPI	Setiap bulan
Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Tenaga kesehatan di unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	- Kepala Ruangan - IPCN - Komite PMKP	Berkelanjutan
Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	- Komite PPI - Farmasi	Setiap bulan

3.6.1.1.9 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.9.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas.				
Masalah saat ini	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. • Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. • Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. • Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. • Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	• Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. • Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. • Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. • Monitoring teknik recapping tutup jarum.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS
3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Jan	Feb	Mar	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C Mencapai Target
ICU\HCU	4x/Bulan	50%	100%	0%	Menurun	Lampiran B	ICU/HCU Tidak mencapai target
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	0%	100%	Menurun	Lampiran B	IRNA 3C Tidak Mencapai target
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	MATERNITAS Mencapai Target
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	75%	100%	Menurun	Lampiran B	PERINATOLOGI Tidak Mencapai Target
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	100%	0%	Menurun	Lampiran B	IRNA 5C Mencapai Target
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	75%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A Mencapai Target
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	50%	100%	Menurun	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Tidak Mencapai target
IGD	4x/Bulan	100%	25%	100%	Me Menurun ningkat	Lampiran B	IGD Tidak Mencapai Target
FARMASI	4x/Bulan	100%	100%	25%	Tercapai	Lampiran B	FARMASI Mencapai target
GIZI	4x/Bulan	75%	100%	0%	Perlu di Tingkatkan	Lampiran B	Gizi Mencapai Target
IRJA	4x/Bulan	100%	0%	100%	Menurun	Lampiran B	IRJATidak Mencapai Target

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Maret Tahun 2026, Tim PKRS telah melaksanakan edukasi dan mencapai target, beberapa Unit belum mencapai target, berikut : ICU, PERINATOLOGI, IRNA 5C, FARMASI, dan GIZI.

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.1 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

Unit	Target	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	%	MANDOK	KET
Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Bulan Ramadhan
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Bulan Ramadhan
		Hypnoterapi						
		KIE						
Yoga Lansia	4xBulan	Yoga	100%	100%	25%	Tidak Tercapai	Ada	Sabtu 1 dan 3 Hall Sakura di pakai diklat ACLS
		Hynoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Februari Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	50%	50%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						

Komunitas Shirothul Febnah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	50%	50%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.2 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

Unit	Target	Jan	Feb	Mar	%	Bukti di Form Edukasi Terintegrasi atau kolaborasi	Ket
PONEK	4X/Bulan	100%	100%	25%	Tidak Tercapai	√	terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	100%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	25%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan Maret PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

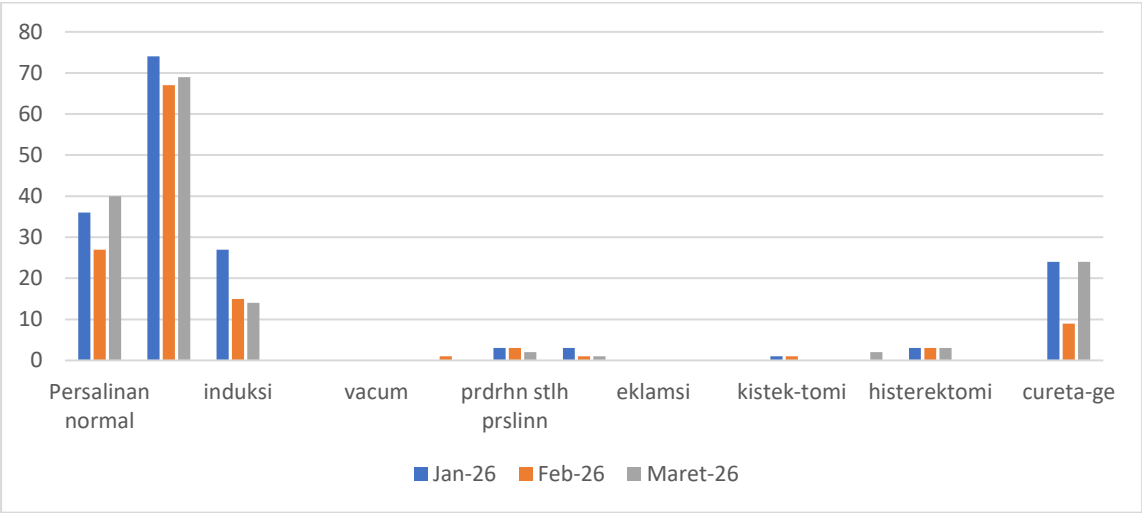
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	36	27	40
	b. <i>SectioCaesaria</i>	74	67	69
2				
	a. Induksi / Drip	27	15	14
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	1	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	3	2

	c. Pre Eklamsi	3	1	1
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	24	9	24
	b. Kistektomi	1	1	0
	c. Miomektomi	0	0	2
	d. Histerectomy	3	3	3
	e. KET	0	0	0

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

1. Pada jenis persalinan normal pada bulan Maret 2026 yaitu 40 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 27 pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 36 pasien.
2. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Maret 2026 yaitu 69 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 67 pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 74 pasien.
3. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya,CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.
4. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
5. Induksi/Drip pada bulan Maret 2026 yaitu 14 pasien, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 15 pasien, sedangkan bulan januari yaitu 27 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.

6. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Maret 2026 yaitu 1, menurun dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 1, sedangkan bulan Januari 2026 yaitu 3 pasien
7. Jenis pelayanan curetage di bulan Maret 2026 yaitu 24 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 9 pasien, sedangkan bulan Januari 2026 yaitu 24 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

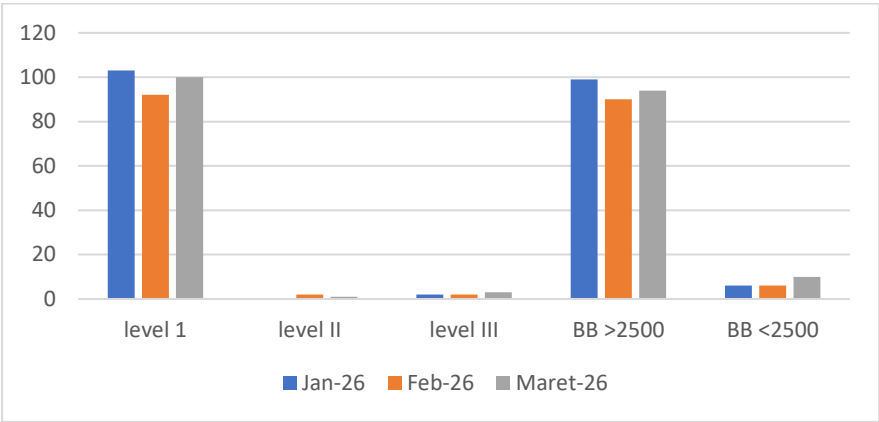
- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	103	92	100
	b. Level II/ rujukan dari luar	0	2	1
	c. Level III/NICU	2	2	3
2				
	a. BB ≥ 2500 gram	99	90	94
	b. BB ≤ 2500 gram	6	6	10

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Maret 2026



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Maret 2026 yaitu 100 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 92 pasien, sedangkan januari yaitu 103 pasien
- 2. Pada pelayanan level 2/ rujukan dari luar pada bulan Maret 2026 yaitu 1 pasien , menurun dibandingkan bulan Februari yaitu 2 pasien, sedangkan pada bulan januari yaitu 0 pasien.
- 3. Pada pelayanan level 3 pada bulan Maret yaitu 3 pasien, menurun dibandingkan dengan Februari dan Januari yaitu 2 pasien.
- 4. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Maret 2026 yaitu 94 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 90 pasien pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 99 pasien.
- 5. Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Maret 2026 yaitu 10 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari dan Januari 2026 yaitu 6 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

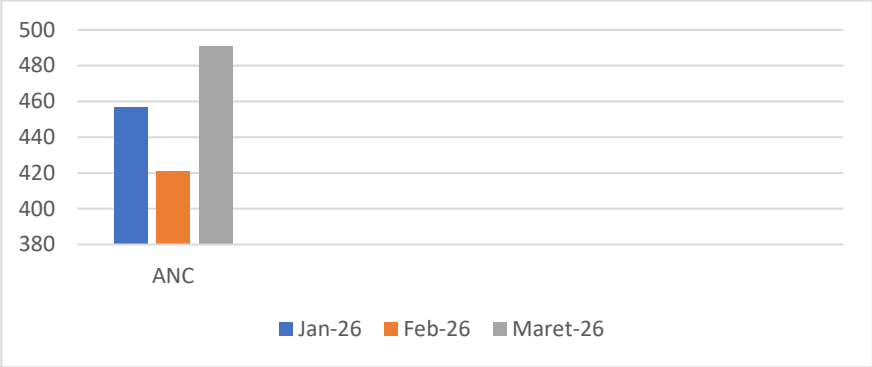
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.12 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	ANC	457	421	491

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Maret 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan ANC pada bulan Maret 2026 yaitu 491 pasien mengalami peningkatan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan 2 bulan sebelumnya, Sedangkan pada bulan Februari yaitu 421 pasien, dan bulan januari yaitu 457 pasien
- 2. Faktor Sistem dan Kebijakan terkait perubahan regulasi JKN

Rencana dan Tindak Lanjut :

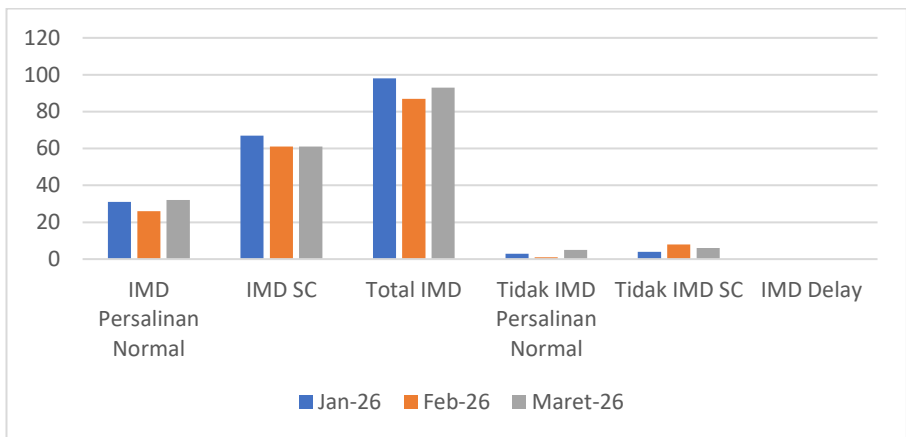
- 1. Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
- 2. Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3. Melakukan Program kelas ibu hamil

3.7.13 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Maret 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	IMD Persalinan Normal	31	26	32
2	IMD SC	67	61	61
3	Total IMD	98	87	93
4	Tidak IMD Persalinan Normal	3	1	5
5	Tidak IMD SC	4	8	6
6	IMD Delay	0	0	0
	Total Persalinan Normal	36	27	37
	Total Kelahiran SC	74	67	67
	Total kelahiran	110	94	104

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1. Pada bulan Maret 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 32 pasien,meningkat di dibandingkan bulan Februari yaitu 26 pasien sedangkan bulan Januari yaitu 31 pasien Bayi.
- 2. Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Maret yaitu 61 pasien, sama dengan bulan Februari, sedangkan bulan Januari yaitu 67 pasien Bayi.
- 3. Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Maret yaitu 5 pasien, meningkat dibandingkan bulan Februari yaitu 1 pasien sedangkan bulan januari yaitu 3 pasien.
- 4. Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Maret 2026 yaitu 6 pasien, menurun dibandingkan bulan Februari yaitu 8 pasien, sedangkan bulan januari yaitu 3 pasien,
- 5. Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 6. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Maret 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
	Ny Zulia	NCB + BBLR	ant warmer
	Ny Dayinta	BBLSR + Anenchepali	vis
	Ny Putri Riskia	NCB + BBLR	ant warmer
	Ny Alfiyah	NKB + BBLR	ant warmer
	Ny Nur Habibahtur	NKB + BBLR	ant warmer
SC			
	Ny Mella 1	NKB + BBLR + gemeli	vis
	Ny Mella 2	NKB + BBLR + gemeli	vis
	Ny Raquela	NKB + BBLR	vis
	Ny Maulidia	NKB + BBLR + RDS	tubator, CPEP
	Ny Bella	NCB + BBLR	ant warmer
	Ny Ila Nur Janah	NCB + ibu Hepatitis B	ant warmer

Rencana dan Tindak Lanjut :

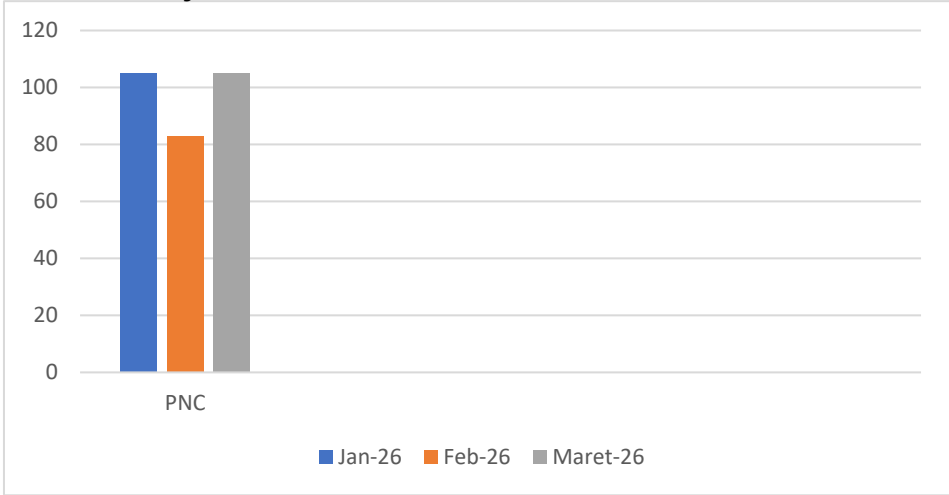
- 1) Skin-to-Skin Contact setelah stabil, dilakukan di ruang NICU/Perinatologi jika memungkinkan.
- 2) Early Initiation of Expressed Breast Milk (EBM), Ibu dipandu memerah ASI dalam 1–2 jam pertama dan ASI diberikan melalui metode sesuai kondisi bayi

3) Metode Kangaroo Mother Care (KMC) untuk bayi BBLR stabil.

3.7.14 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	PNC	105	83	105

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



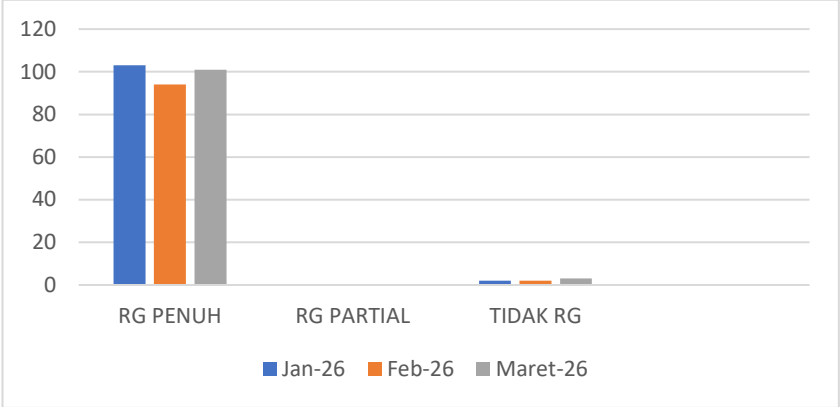
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Maret 2026 yaitu 105 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 83 pasien, sedangkan bulan Januari sama, yaitu 105 pasien.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1. Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas (KF1: 6–48 jam, KF2: 3–7 hari, KF3: 8–28 hari, KF4: 29–42 hari)
 - 2. Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
 - 3. Melakukan eduaksi pentingnya KB pasca salin

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Maret 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Rawat gabung penuh	103	94	101
2	Rawat gabung partial	0	0	0
3	Tidak Rawat gabung	2	2	3

Grafik Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2026 yaitu 101 bayi meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 94 pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 103 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2026 yaitu 3 bayi, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari dan Januari 2026 yaitu 2 bayi.
- 3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
Ny Dayinta	BBLSR + Anenchepali	cuvis
Ny Maulidia	NKB + BBLR + RDS	Inkubator, CPEP
Ny Vebby	RDS	Inkubator, CPEP

- 4. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

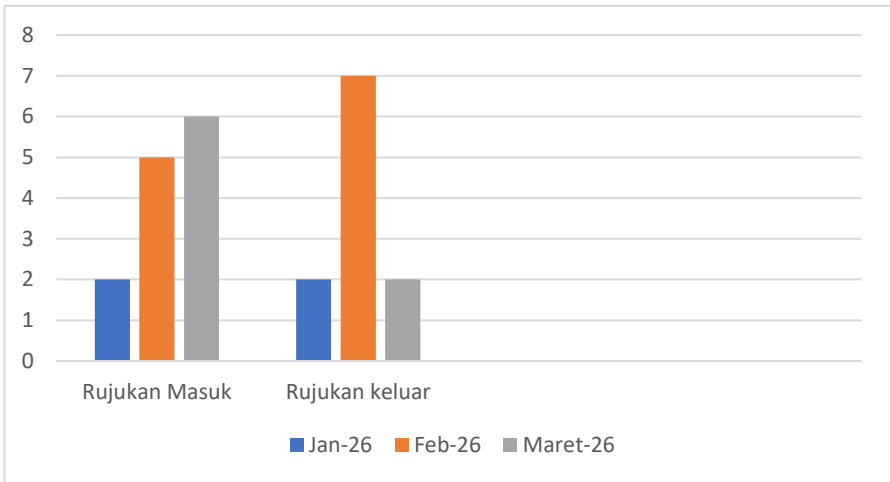
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2. Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3. Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4. Pelaksanaan **Kangaroo Mother Care (KMC)** pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Maret 2026

Rujukan	Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
Rujukan Masuk	2	5	6
Rujukan keluar	2	7	2

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Evaluasi :

- 1. Jumlah rujukan masuk pada bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, yaitu 6 rujukan, sedangkan pada bulan Februari 2026 sebanyak 5 rujukan, dan bulan Januari sebanyak 2 rujukan.
- 2. Jumlah rujukan keluar pada bulan Maret 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 rujukan, sedangkan pada bulan Februari 2025 sebanyak 7 rujukan, dan Januari sebanyak 2 rujukan keluar.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2. Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponek Maret 2026

Bulan Januari 2026			
1	Ny Maddinatul Nor	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Lilik
2	Ny Sinta	G2 P0000 Ab100 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
Bulan Januari 2026			
1	By Ny Febriyanti	RDS	RS Enggal Dangan
2	Ny Riya Uliyana	G4 P2002 Ab001 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Fitriyah Nur F	Ruptur perineum grade 3	PKM Singosari
4	Ny Angely Reza	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan kala 2	PKM Ardimulyo
5	Ny Bella Sari	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 minggu dengan kala 2 lama	PKM Ardimulyo
Bulan Februari 2026			
1	Ny Wiwik Puji A	G5 P2002 Ab200 UK 39-40 minggu dengan KPD + letak Obliq	PMB Munawaroh
2	Ny Heny S	Anemia + AUB	Dr.Rifatul
3	Ny Rika S	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat

4	Ny Irma S	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KPD + susp CPD	PMB Titik S
5	Ny Lelly Priga	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD	PMB Titik S
6	Ny Cello velinda	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD + HT gestasional+ letak Obliq	PMB Lilik A

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponек Maret 2026

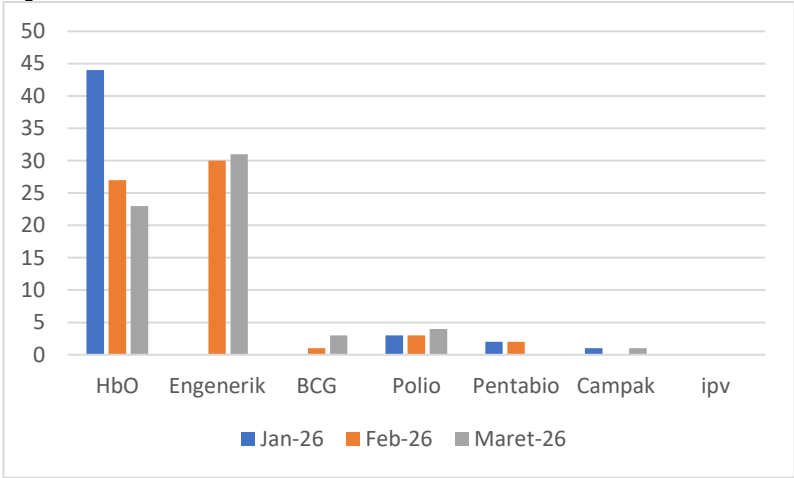
No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan Januari 2026						
1	BY Ny Hazizah	1 hari	NICU	RDS, BBLR, Pneumonia, NKB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
2	Ny Rizki Mega	33 tahun	Maternitas	P0201 Ab100 dengan post partum VBAC + post histerektomi atas indikasi HPP + susp policitimiavera	Penangan Lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan Februari 2026						
1	By Ny Mewah	1 hari	NICU	RDS+Neonatal bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	By Ny Nuriana	1 hari	NICU	NCB+ Multiple Congenital + susp PJB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Yeyen	1 hari	NICU	Atresia ani tanpa fistel + undensensus testis + susp DS	Pro bedah anak	RS Saiful Anwar
4	Ny Rizki Ika	32 tahun	Maternitas	G3 P2002 Ab000 UK 32-34 minggu dengan PPI	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
5	Ny Dyah Ayuning	26 tahun	Ponek	G1 P0000 Ab000 UK 26-28 minggu dengan Ppi + APB EC PLR	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
6	NY Ivatul Khoiria	40 tahun	Ponek	G4 P1001 AB200 UK 28-30 minggu dengan BSC + KPD preterm	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
7	Ny Vita Afifatul	27 tahun	Maternitas	G3 P2002 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Letak lintang + BSC 2x + B20	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan Maret 2026						
1	By Ny Savira	1 hari	NICU	RDS ok Neonatal pneumonia dd MAS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	NY Aisyah Kayla	30 th	Ponek	G1 P0000 Ab000 Uk 32-34 minggu dengan PEB	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponек Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Februari 2026
1	HbO	44	27	23
2	Engerix Junior	0	30	31

3	BCG	0	1	3
3	Polio	3	3	4
4	Pentabio	2	2	0
5	Campak	1	0	1
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

1. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Maret 2026 yaitu 23 pasien, menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu sebanyak 27 bayi, sedangkan pada bulan Januari sebanyak 44 bayi, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
2. Pada bulan Maret ada 31 bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, meningkat dibandingkan Februari yaitu 30 bayi, sedangkan bulan Januari belum ada vaksin Engerix Junior hal ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Ada 3 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Maret 2026 dan meningkat dibandingkan dengan Februari yaitu 1 bayi, sedangkan bulan Januari 0.
5. Ada 1 bayi yang Imunisasi Campak bulan Maret dan Januari 2026, di bulan Februari tidak ada.
6. Ada 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Maret 2026, sedangkan 2 bulan sebelumnya sebanyak 3 bayi.
7. Tidak Ada bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Maret 2026, sedangkan pada 2 bulan sebelumnya ada 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

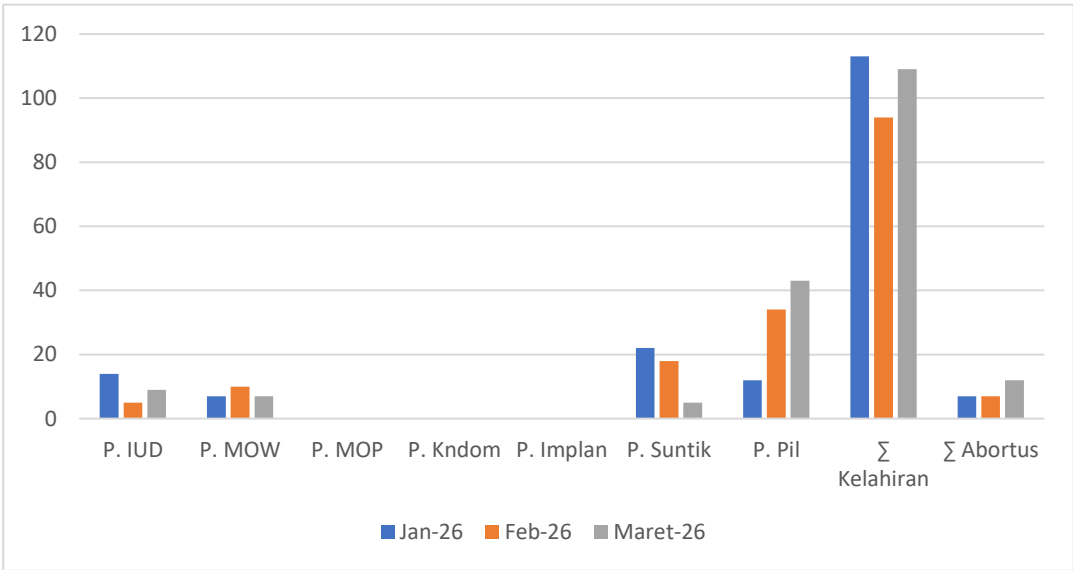
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Maret 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	IUD	14	5	9
2	MOW	7	10	7
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	7	7	15
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	22	18	5
7	Pil	12	34	43
8	Σ Kelahiran	113	94	109
9	Σ Abortus	7	7	15

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Aanalisis :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 akseptor, yang terdiri dari 4 akseptor IUD Nova T dan 5 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Maret 2026 sama dengan bulan Januari yaitu 7 pasien, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 10 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
3. Tidak ada pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 43 pengguna, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 34 pengguna, dan bulan Januari sebanyak 12 pengguna.
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Maret menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 pengguna, sedangkan bulan Februari 2026 sebanyak 18 pengguna, dan Januari 2026 sebanyak 22 pengguna,

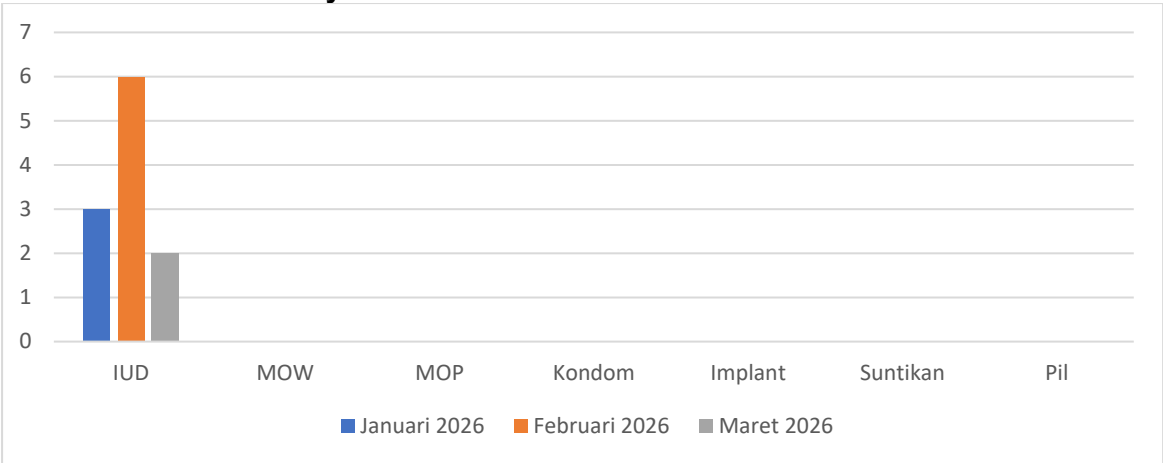
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026
1	IUD	3	6	2
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik Pelayanan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1. Pelepasan KB IUD pada bulan Maret 2026 menurun yaitu 2 Akseptor, sedangkan pada bulan Februari 2026 sebanyak 6 akseptor, dan bulan Januari 2026 sebanyak 3 akseptor,
- 2. Pelepasan KB Implan pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :

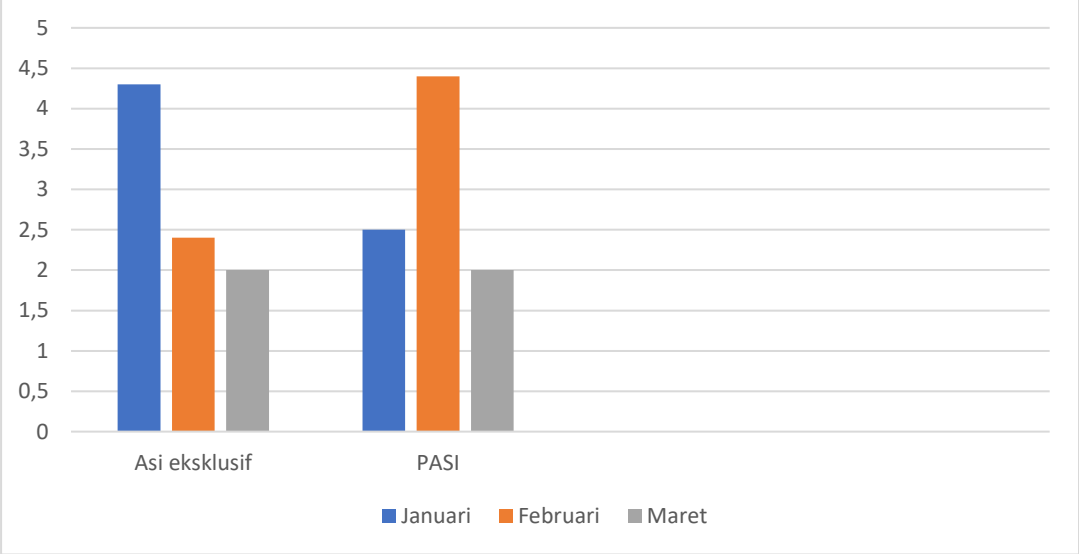
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Maret 2026

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Asi eksklusif	105	96	103
2	PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Maret 2026 meningkat yaitu 103 bayi, dibandingkan bulan Februari 2026 sebanyak 96 bayi, sedangkan Januari 2026 sebanyak 105 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

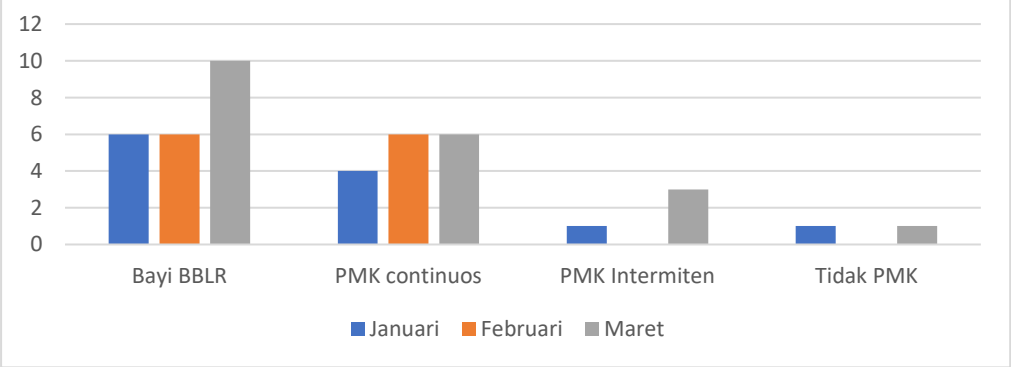
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Maret 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2025	Bulan Februari 2025	Bulan Maret 2025
1	Bayi BBLR	6	6	10
2	PMK continuos	4	6	6
3	PMK Intermiten	1	0	3
4	Tidak PMK	1	0	1

Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Maret 2026



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2. Ada 3 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Maret 2026, sedangkan pada bulan Februari tidak ada, dan Januari 2026 sebanyak 1. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Maret sama dengan Februari 2026 sebanyak 6 bayi, sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 4 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4. Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Maret dan Januari 2026, sedangkan pada bulan Februari tidak ada. Hal ini dikarenakan bayi dengan kelainan anenchepal dan bayi kemudian meninggal.

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		Januari	Februari	Maret	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	2	0	0	
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	0	1	0	
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	2	3	0	

Evaluasi :

- 1. Pada bulan Januari 2026 terdapat 4 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan Februari 2026 terdapat 4 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Bulan Januari 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	01/01/2026	38 th	-	Positif	Positif	-
2	02/01/2026	36 th	-	Negatif	Negatif	Positif
3	10/01/2026	13th	Positif	-	Positif	-
4	12/01/2026	57th	-	Positif	Positif	-
5	12/01/2026	34th	-	Negatif	Positif	-
6	15/01/2026	63th	-	Negatif	Positif	-
7	18/01/2026	75th	-	Negatif	Positif	-

8	18/01/2026	22th	-	Positif	Positif	-
9	20/01/2026	65th	-	Positif	Negatif	-
10	28/01/2026	54th	-	Positif	Positif	-
11						
12						
13						
	Total		1	5	8	1

3.1.2.2.1 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi
Bakteriologis Bulan Februari 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	03/02/2026	39 th	-	Negatif	Positif	-
2	03/02/2026	14th	-	Positif	Positif	-
3	11/02/2026	23th	-	Negatif	Positif	-
4	11/02/2026	57th	-	Positif	Positif	-
5	21/02/2026	10th	-	Positif	Positif	-
6	26/02/2026	43th	-	Negatif	Positif	-
7						
8						
9						
10						
	Total		0	3	6	0

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan
Maret 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	02/03/2026	49TH	-	Negatif	Positif	-
2	03/03/2026	46TH	-	Positif	Positif	-
3	04/03/2026	68TH	-	Positif	Positif	-
4	16/03/2026	24TH	-	Negatif	Negatif	Positif
5	16/03/2026	26TH	-	Negatif	Positif	-
6	07/03/2026	71TH	-	Positif	Negatif	-
7						
8						
9						
10						
	Total		0	3	4	1

Analisis :

1. Pada bulan Januari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 10 pasien dan pasien negatif sejumlah 26 pasien
2. Pada bulan Februari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 24 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 6 pasien dan pasien negative 18 pasien
3. Pada bulan Maret 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 30 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 6 pasien dan pasien negative 24 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.1 Penemuan Kasus TB

No	Unit	Jumlah Pasien		
		Januari	Februari	Maret
1.	Poli Paru	7	4	5
2	Poli Bedah			
3	Poli IPD			
4	Poli Anak	1	2	
5	Irna 2C			
6	ICU			
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			
13	Irna 5C	2	1	1
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total	10	7	6

Analisis :

1. Pada bulan Januari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 10 pasien dan pasien negatif sejumlah 26 pasien
2. Pada bulan Februari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 24 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 6 pasien dan pasien negative 18 pasien
3. Pada bulan Maret 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 30 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 6 pasien dan pasien negative 24 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.

3.1.2.2.2 Jumlah Kunjungan pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			Jumlah Total Pasien TB
		Januari	Februari	Maret	Total
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	63	54	60	
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	3	2	2	
3	Pasien RFT	10	6	6	

Analisis:

1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan Januari mencapai 63 pasien, di bulan Februari 0 pasien, dan di bulan Maret 0 pasien.
2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan Januari 3 pasien, di bulan Februari 2 pasien dan di bulan Maret 0 pasien.
3. Jumlah keseluruhan kunjungandi poli pasien RFT di bulan Januari 10 pasien, di bulan Februari 6 pasien dan di bulan Maret 6 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.3 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	10	6	6

Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

3.1.2.2.4 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	0	1	2

Evakuasi :

1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari
3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Maret

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.5Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Januari 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Tn. G	V		
		Ny.S	V		
		Tn. M.Z	V		
		Tn. J	V		
		Ny. N	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. S	V		
		Ny.E	V		
		Ny.R	V		
		Ny.T	V		
3.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A	An. M.N	V		
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed				

3.1.2.2.6 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Februari 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Tn. SMH	V		
		Ny. DZ	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn.S	V		
		Ny. DN	V		
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An.D	V		
4.	dr. Ratih.Sp.A.M.Biomed	An.A	V		

3.1.2.2.7 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Maret 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Tn. ABD	V		
		Tn. AR	V		
		Tn. AW	V		
		Ny. N	V		
		Tn. R	V		
		Tn. AG	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK				
3					

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.7 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%	100%	100%
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%	100%	100%

Analisis:

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.8 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		Januari	Februari	Maret
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%	100%	100%
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%	100%	100%
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%	100%	100%

Analisis:

Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.9 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Januari 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Januari	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny.E	V	-	1	PKM Ardimulyo	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Ny.T	V	-	1	PKM Pakis	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan

							Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C	Tn. R	V	-	1	PKM Singosari	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

3.1.2.2.10 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Februari 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Februari	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Tn.S	V	-	1	PKM Karangploso	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Ny.D	V	-	1	PKM Singosari	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						

16	Irna 8A						
	Total						

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Maret 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Maret	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Tn.AG	V	-	1	PKM Lawang	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

Analisis :

1. Pada bulan Januari 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan Februari 2026 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP karena. pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		Januari	Februari	Maret	
1.	OAT Anak	1	5	4	01/27
2.	OAT Harian Dewasa	5	15	7	11/26

3.	Ethambutol 250 mg	0	0	0	0
4.	Ethambutol 400 mg	112	196	153	05/26
5.	Pirazinamid 500 mg	556	732	732	05/27
6.	Isoniazid 300 mg	790	690	504	02/26
7.	Rimfapicin 450 mg	790	1282	1282	03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0	0	0	0

Analisis :
 Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Unit	Jenis TB	Jumlah Pasien					
			Januari		Februari		Maret	
			Anak	Dewasa	Anak	Anak	Dewasa	Anak
1.		Pasien paru	1		2	4		
2.		Pasien Ekstra paru	8	1	0	0		

- Evaluasi :**
1. Pada bulan Januari 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 9 pasien paru
 2. Pada bulan Februari 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 6 pasien paru
 3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru

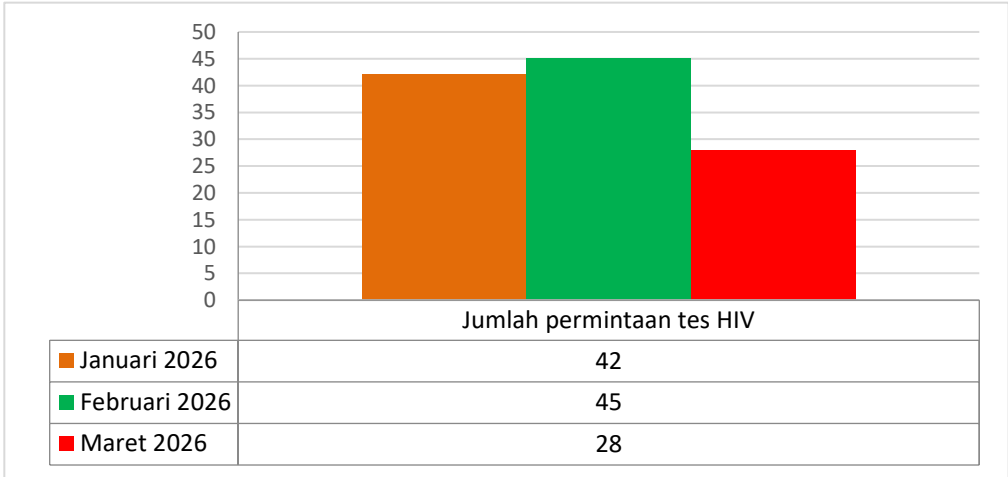
Rencana dan Tindak Lanjut :
 Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama pada pasien ekstra paru

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Permintaan Test HIV	42	45	28

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Januari 2026 sebanyak 42 pasien. pada bulan Februari 2026 sebanyak 45 pasien Sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 28 pasien
Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

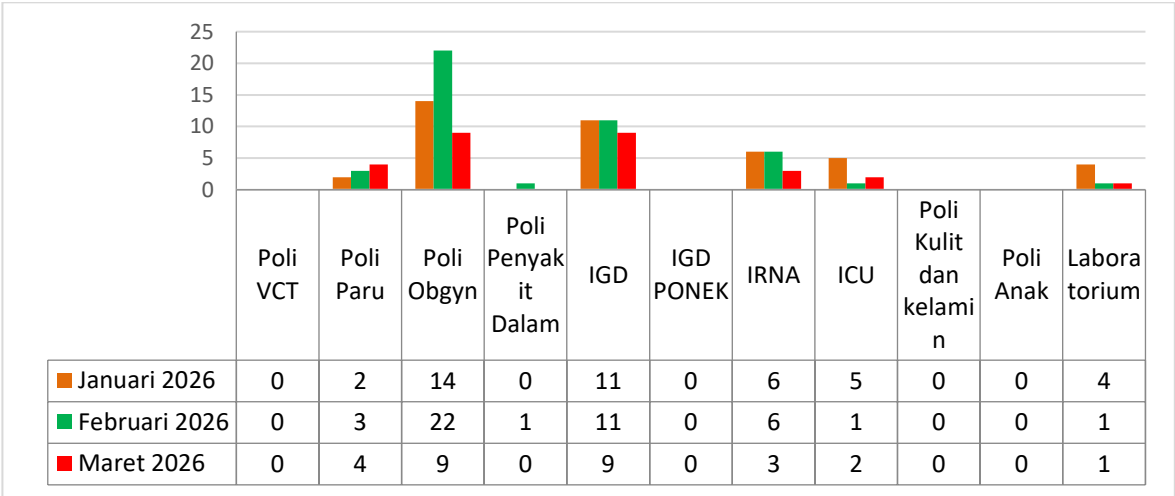
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.15 Asal Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	2	3	4
3	Poli Obgyn	14	22	9
4	Poli Penyakit Dalam	0	1	0
5	IGD	11	11	9
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	6	6	3
8	ICU	5	1	2
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	4	1	1

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien. pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien. Sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

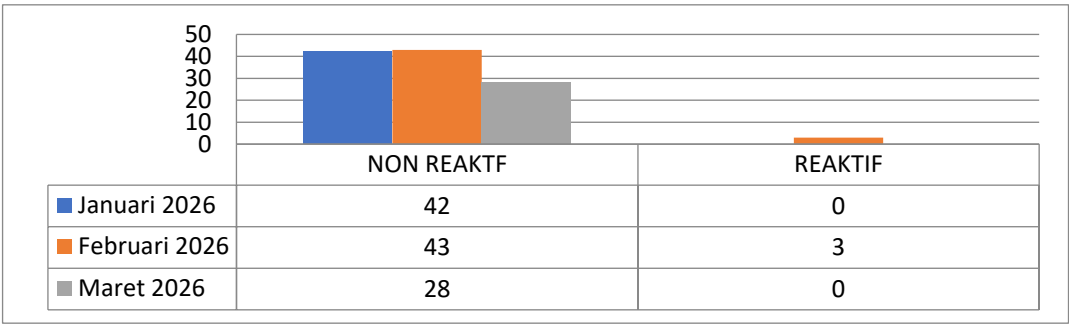
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2025	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026
1	Non Reaktif	38	42	43
2	Reaktif	2	0	3

Grafik Status HIV Maret 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Januari 2026 tidak ditemukan pasien yang reaktif HIV, pada bulan Februari 2026 terdapat 3 pasien dengan HIV reaktif dari rawat inap, Sedangkan pada bulan Maret 2026 tidak ditemukan pasien yang reaktif HIV

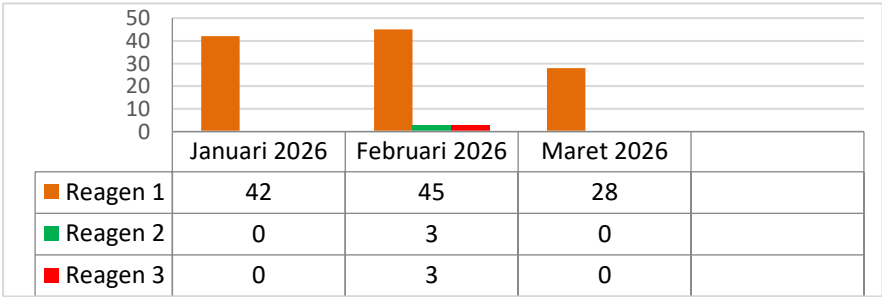
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.16 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Reagen 1	42	45	28
2	Reagen 2	0	3	0
3	Reagen 3	0	3	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Maret 2026



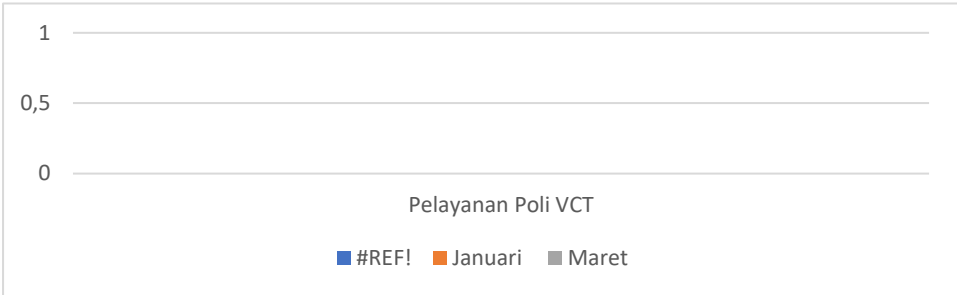
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Januari 2026 hanya memakai reagen 1 saja karena tidak ada hasil reaktif HIV, pada bulan Februari 2026 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 3 pasien Sedangkan pada ulan Maret 2026 hanya memakai reagen 1 saja sebanyak 28 reagen

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dianjurkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.17 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Maret 2026



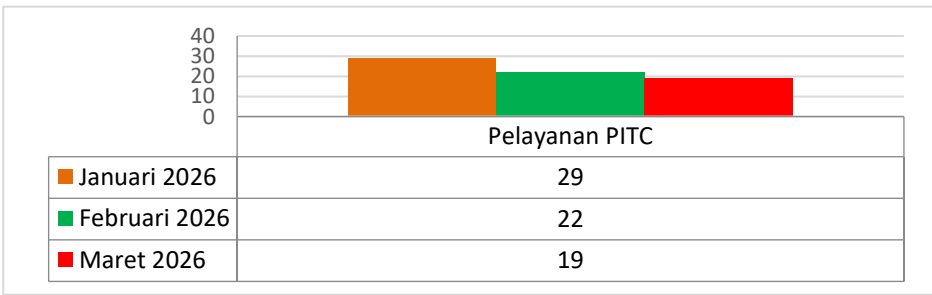
Analisis pelayanan Poli VCT
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenakan asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.18 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Pelayanan PITC	29	22	19

Grafik Pelayanan PITC Maret 2026



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan Januari 2026 sebanyak 29 pasien pada bulan februari 2026 sebanyak 22 pasien Sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 19 pasien.
Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

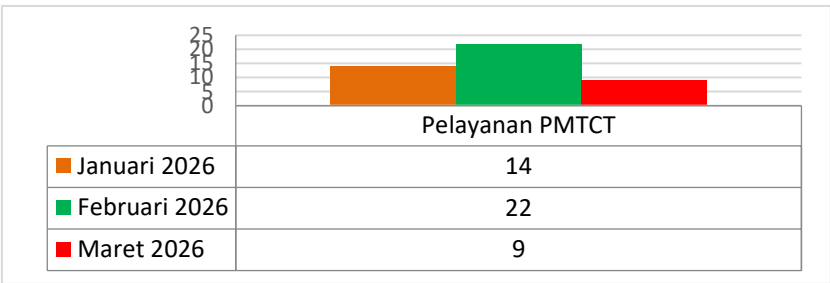
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.19 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Pelayanan PMTCT	14	22	9

Grafik Pelayanan PMTCT Maret 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien Sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

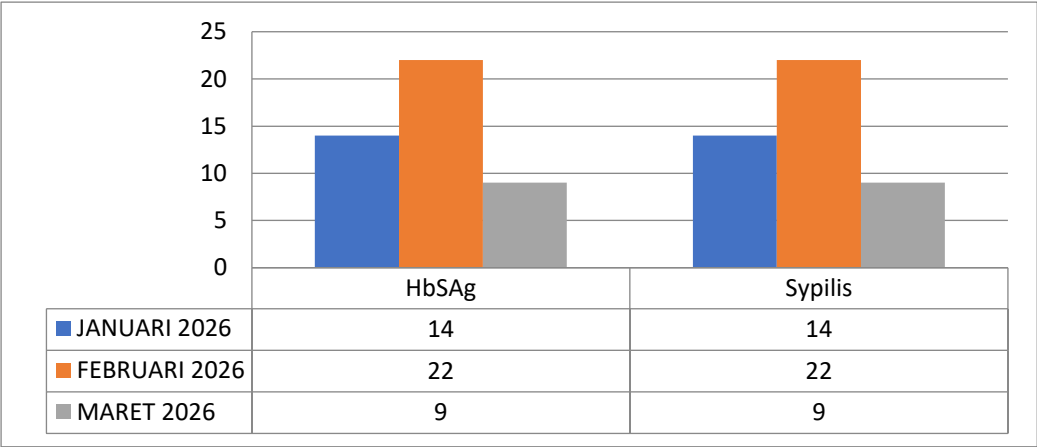
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.20 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	HbSAg	14	22	9
2	Sypilis	14	22	9

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Maret 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien. Sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien yang dilakukan pemeriksaan

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

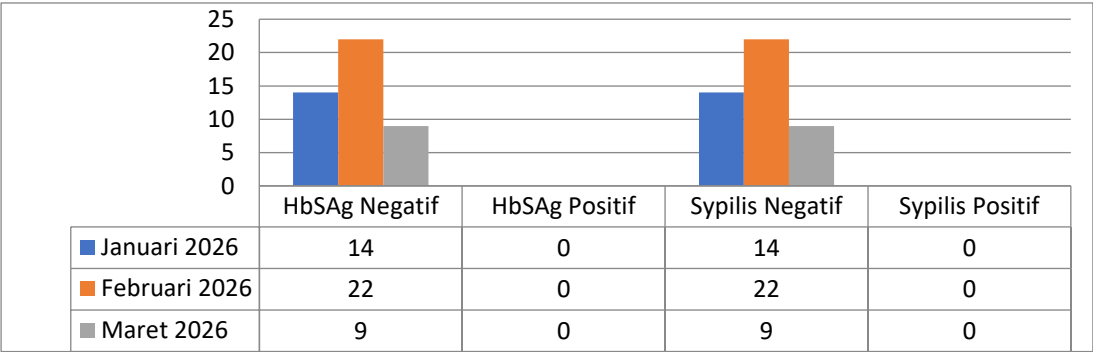
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.21 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	HbSAg			
	Negatif	14	22	9
	Positif	0	22	0
2	Sypilis			
	Negatif	14	14	9
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Maret 2026



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Januari, februari dan Maret 2026 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

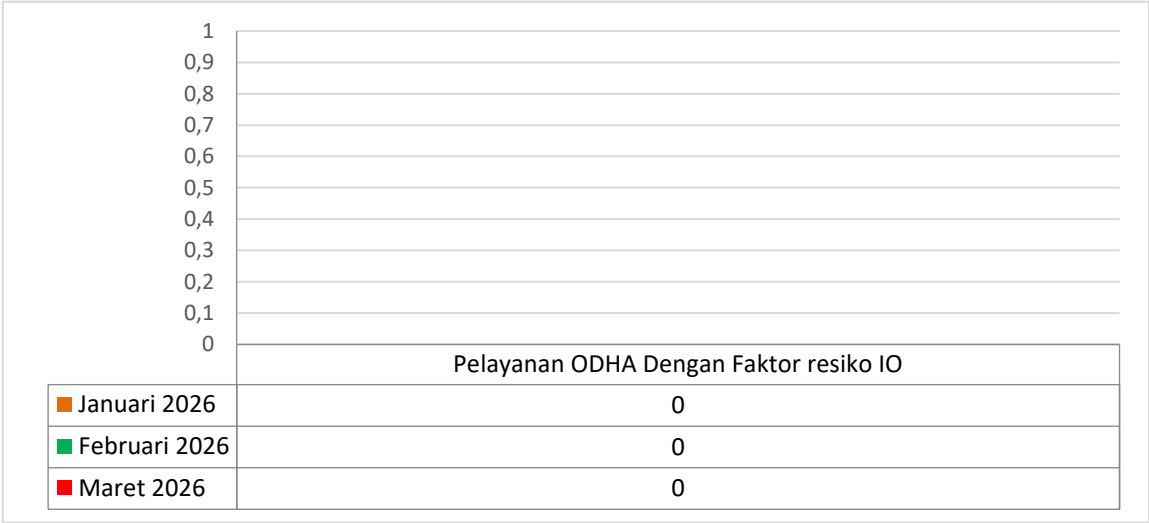
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.22 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	0	0	0

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Maret 2026



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Tidak ada pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV dengan hasil HIV reaktif di RS Prima Husada. Pada bulan januari, februari dan maret 2026.
Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB untuk dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang.

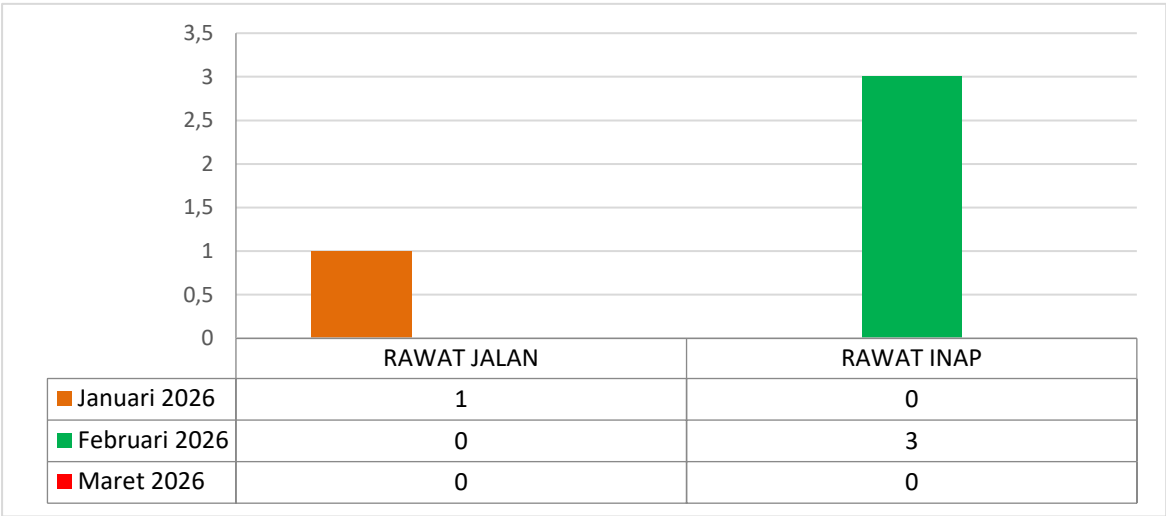
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.23 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
1	Rawat Jalan	1	0	0
2	Rawat Inap	0	3	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Maret 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Januari 2026 terdapat 1 pasien yang dirujuk dari poli rawat jalan, pada bulan Februari terdapat 3 pasien yang dirujuk dari rawat inap Sedangkan pada bulan Maret 2026 tidak terdapat pasien yang dilakukan eujuk, baik dari rawat jalan maupun rawat inap. Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Maret 2026

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang

5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai 1000 hari pertama kehidupan	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1x	1x	1x

Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1x	1x	1x
	2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Poli kandungan	457 pasien	421 pasien	491 pasien
Pemberian PMT Ibu Hamil	1.Pemberian PMT pemulihan dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Senam hamil	2x	2x	2x
	2.Pemberian PMT penyuluhan pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam hamil	1x	1x	1x
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	105 pasien	96 pasien	105 pasien
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita	Pasien poli anak dan IRNA Anak	IRJA	1x	2x	2x
	2. Pemberian makanan Bayi dan Anak	Pasien IRNA Anak	IRNA	175 pasien	157 pasien	164 pasien
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan pencatatan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak terdeteksi	Pasien IRNA Anak terdeteksi wasting/ stunting	IRJA anak	2	4	4

	stunting/ wasting					
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	6 pasien	6 pasien	8 pasien
Pemberian vitamin A	Penyuluhan mengenai pentingnya pemberian vitamin A pada anak-anak	Pasien anak	IRJA anak	3x	2x	1x
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	3 pasien	6 pasien	5 pasien
Pemberian Taburia pada Baduta	Penyuluhan mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	1x	1x	1x
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Penyuluhan mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	1x	1x	1x

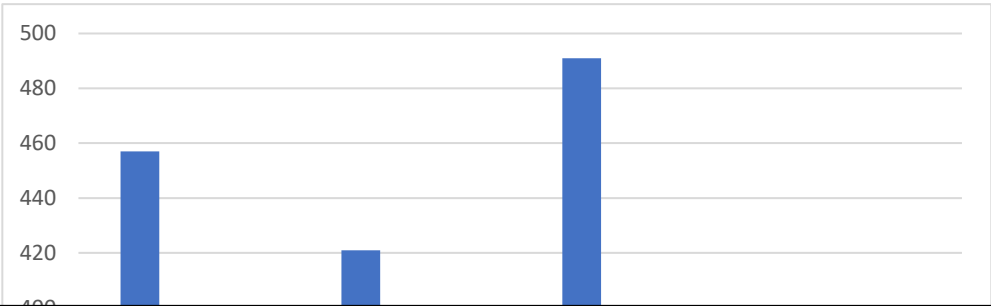
Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas, Rumah Sakit hanya memberikan dalam bentuk PMT penyuluhan.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	457	421	491

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Maret 2026



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat naik dari sebelumnya 421 di bulan Februari menjadi 491 pada bulan Maret yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

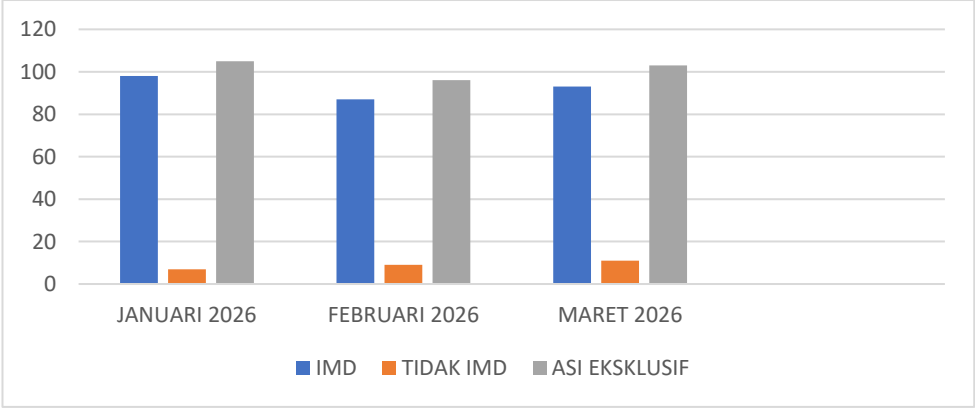
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	IMD	98	87	93
2	Tidak IMD	7	9	11
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	105	96	103

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif Maret 2026



- Analisis :**
1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Maret sebanyak 93 bayi.
 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 bayi.
 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Maret 2026 yaitu sebanyak 103 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

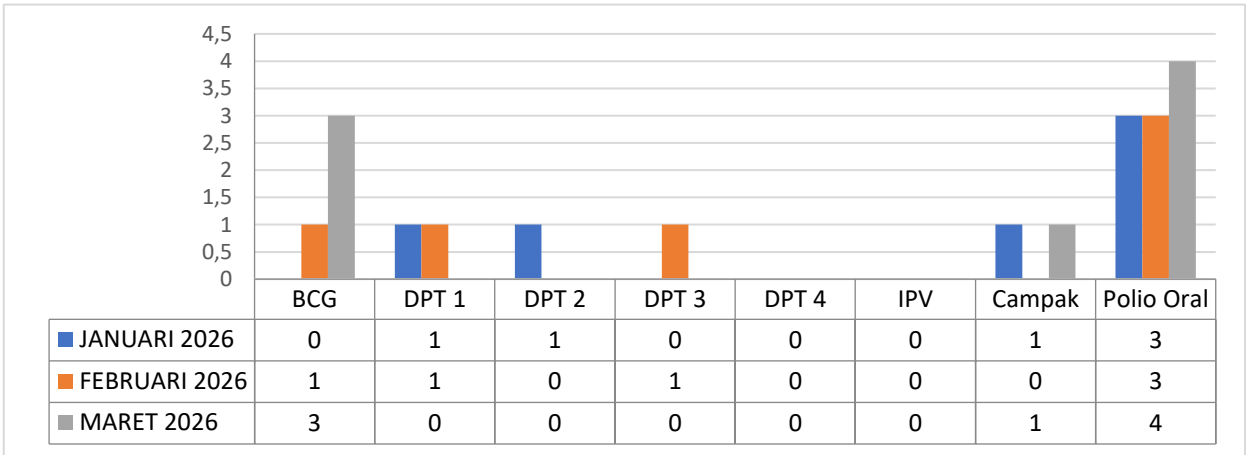
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	BCG	0	1	3
2	DPT 1	1	1	0
3	DPT 2	1	0	0
4	DPT 3	0	1	0
5	DPT 4	0	0	0
5	IPV	0	0	0
6	Campak	1	0	1
7	Polio Oral	3	3	4

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Maret 2026



Analisis:

- 1. Pada bulan Maret sebanyak 1 balita melakukan imunisasi campak.
- 2. Sebanyak 3 balita melakukan imunisasi BCG di Prima Husada Malang pada bulan Maret
- 3. Sebanyak 4 balita melakukan imunisasi Polio oral di Prima Husada Malang pada bulan Maret
- 4. Pada bulan Maret tidak ada yang melakukan imunisasi DPT 1, DPT2, DPT 3, DPT 4

Rencana Tindak Lanjut :

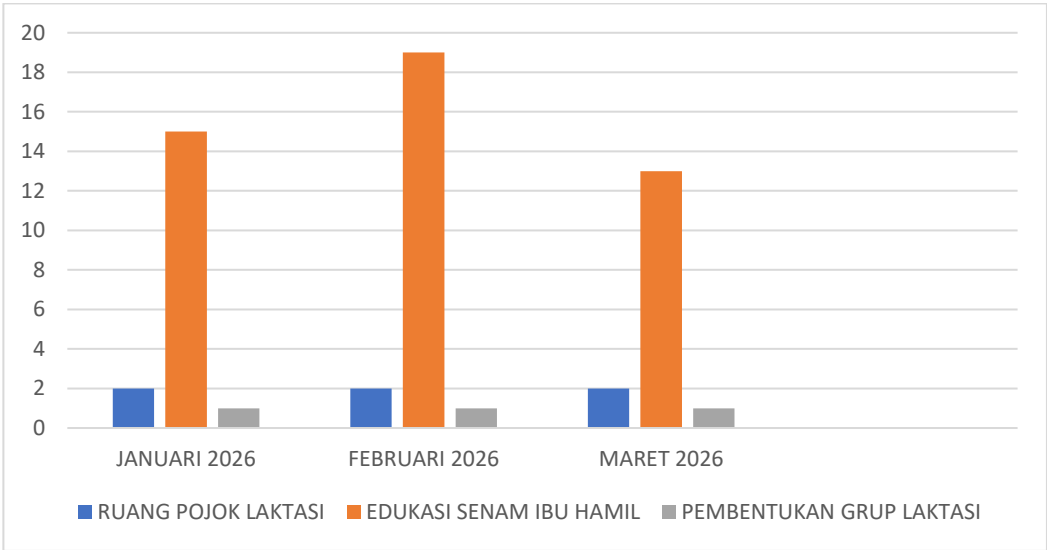
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	15	19	13
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Maret 2026



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Maret edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Gizi Seimbang dan diet TKTP sebanyak 15 peserta, penyuluhan dilakukan di poli obgyn.

Rencana Tindak Lanjut :

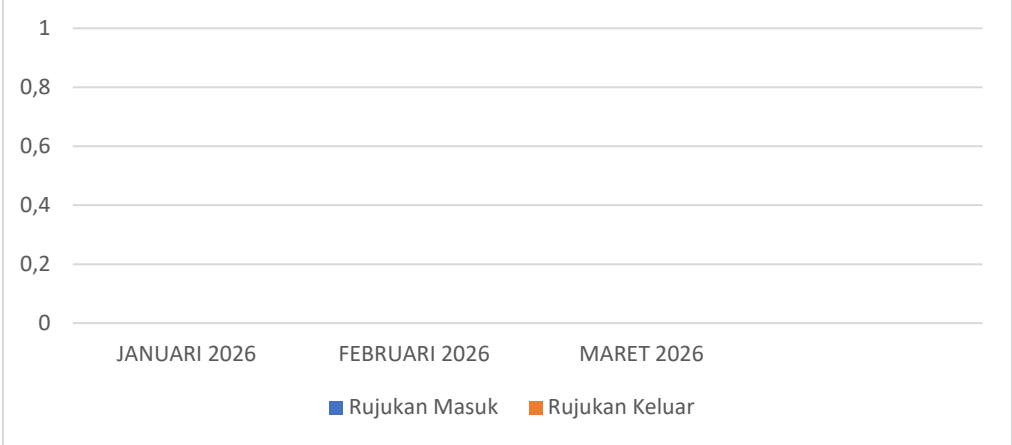
- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-

Maret	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Maret 2026



Analisis :
 Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan Januari

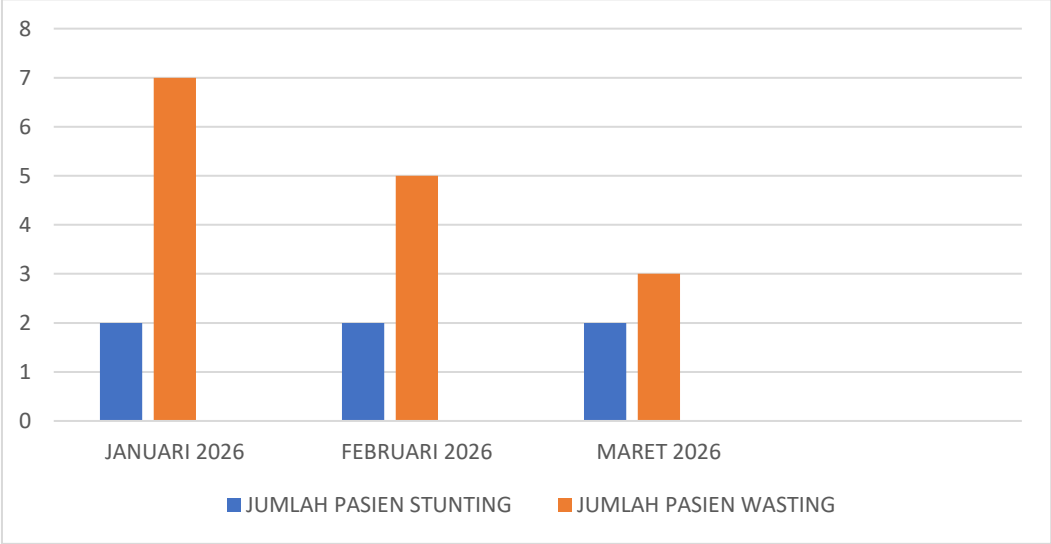
Rencana Tindak Lanjut:
 Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjejaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JANUARI 2026	FEBRUARI 2026	MARET 2026
Jumlah Pasien Stunting	1	4	2
Jumlah Pasien Wasting	2	2	3

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Pada bulan Maret 2026 ditemukan sebanyak 2 balita berat badan kurang, dan terdapat 2 balita termasuk dalam kategori stunting. Permasalahan yang ditemukan rata-rata balita kurang bervariasi dalam pola makannya, dan porsi makan tidak adekuat namun balita aktif. Selain itu, terdapat balita yang sakit dalam kurun waktu lama sehingga mengalami BB turun

Pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein di rumah sakit. Edukasi terhadap orang tua bagaimana dalam memberikan makanan gizi seimbang sesuai usia. Dan kolaborasi terhadap Ahli Gizi dan DPJP terus dilakukan.

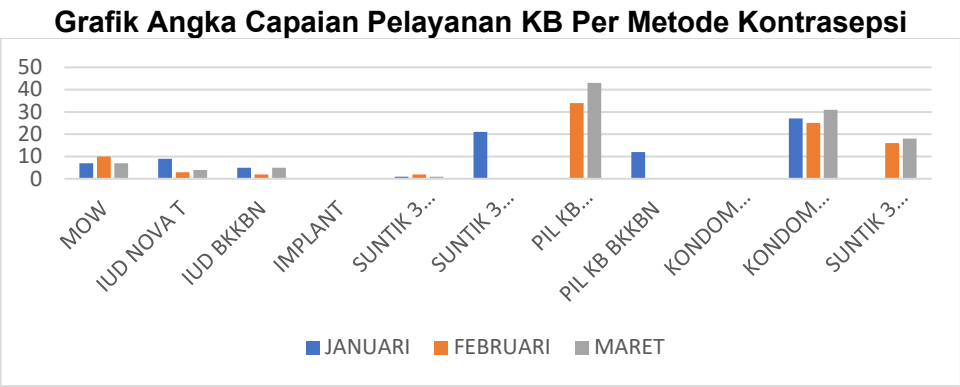
Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan. Penginputan pasien stunting dan wasting di aplikasi eppgbm. Pemberian diet Tinggi Kalori dan Tinggi Protein (TKTP). Kolaborasi antar ahli gizi, DPJP, serta Ahli gizi puskesmas balita.

3.1.2.5 KBRS

3.7.24 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien			Target sasaran per metode kontrasepsi dalam satu tahun
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	
1	MOW	7	10	7	26
2	IUD Nova T	9	3	4	49
3	IUD BKKBN	5	2	5	
4	IMPLANT	0	0	0	111
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	1	2	1	187
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN BKKBN	21	0	0	
7	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN SWASTA	0	16	18	
8	PIL KB BKKBN	12	0	0	135
9	PIL KB SWASTA	0	34	43	
10	KONDOM BKKBN	0	0	0	30
11	KONDOM SWASTA	27	25	31	



- Evaluasi :**
1. Peserta MOW pada bulan Januari turun (7) Februari naik (10) Maret turun (7)
 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Januari tetap (9) Februari turun (3) Maret naik (4)
 3. Peserta IUD BKKBN pada bulan Januari turun (5) Februari turun (2) Maret naik (5)
 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Januari turun (1) Februari naik (2) Maret turun(1)
 5. Peserta KB suntik progestin bkkbn pada bulan Januari naik (21) Februari turun (0) Maret tetap (0) karena barang kosong dari BKKBN
 6. Karena stok suntik 3 bulan progestin BKKBN kosong,maka Peserta KB menggunakan Suntik 3 bulan progestin swasta Februari sebanyak (16) Maret Naik (18)
 7. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Januari turun (12) karena stok habis dan Februari (0) Maret (0) karena barang masing kosong dari BKKBN
 8. Karena stok pil kombinasi BKKBN kosong,Maka peserta KB menggunakan pil kombinasi swasta Februari (34) dan Maret (43) peserta
 9. Peserta KB Kondom BKKBN pada bulan karena stok habis Januari (0) Februari tetap (0) Maret (0) karena kosong dari BKKBN
 10. Peserta KB Kondom swasta Januari (27) dan februari sebanyak (25) Maret naik (31) disediakan karena stok kondom dari BKKBN kosong

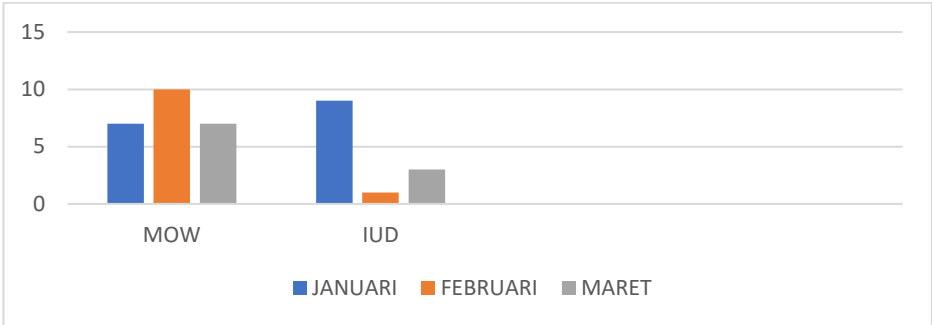
- Analisis :**
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn dan poli KB salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
 4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin tentang pentingnya KB

Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD,Implan serta pemasangan IUD pasca plasenta,dan diadakan Pelayanan KB oleh bidan setiap hari Senin-Jumat

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan							
No	Jenis Pelayanan pasca persalinan	Jumlah Pasien KB Bulan Januari 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Januari 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Februari 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Februari 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Maret 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Maret 2026
1	MOW	7	109	10	103	7	93
2	IUD	9	109	1	103	3	93

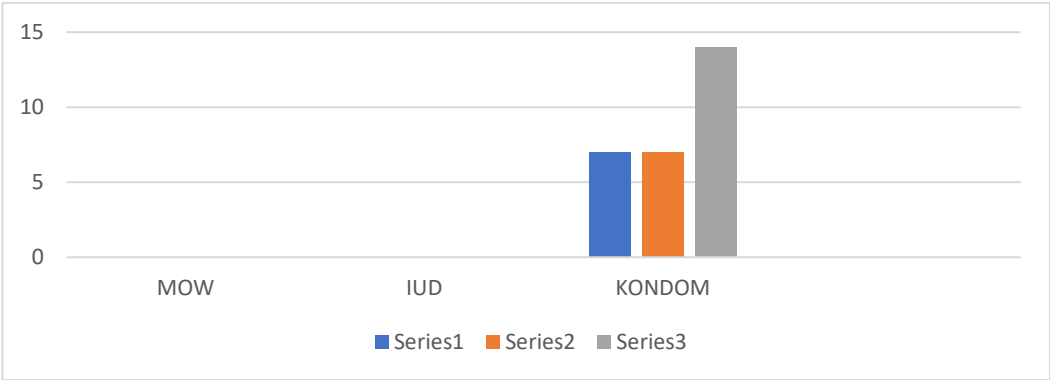
Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

No	Jenis Pelayanan pasca keguguran	Jumlah Pasien kb Bulan Januari 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Januari 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Februari 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Februari 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Maret 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Maret 2026
1	MOW	0	7	0	7	0	14
2	IUD	0		0		0	
3	KONDOM	7		7		14	

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Januari-Februari-Maret meningkat tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Januari-Februari-Maret menetap tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin diruang maternitas tentang pentingnya berKB

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan 2026

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Januari 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Rizkia Afif	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	217127	Post Partum + Post Kuret	04/01/2026	06/01/2026	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	2	1,5	1,33
2	Princia D	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	242729	Abortus Incomplete	05/01/2026	06/01/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
3	Della Ayu	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	201506	Gravida SC	05/01/2026	07/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
4	Mitasari	P/30	dr. Aida, Sp.OG	133682	Kista Ovarium	11/01/2026	13/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Nufaisah M	P/28	dr. Aida, Sp. OG	243470	IUVD	16/01/2025	17/01/2025	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
6	Maureen Danysha	P/26	dr. Aida, Sp.OG	034287	KPD	24/01/2026	26/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Makrifatul S	P/18	dr. Humaira, Sp.OG	235521	Post SC + PEB	24/01/2026	26/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Evi Tamala	P/31	dr. Humaira, Sp.OG	241606	Post SC + KPD	28/01/2026	30/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
9	Elvira A	P/26	dr. Humaira, Sp.OG	071070	Post SC + Oligohidramnion	28/01/2026	30/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Evi Tria	P/36	dr. Humaira, Sp.OG	041795	Post SC + BSC	28/01/2026	31/01/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Abdul Rohim	P/58	dr. Anton, Sp.B	242896	TU Rectum	09/01/2026	11/01/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25

									Picyn		3x1,5	6	6	1
12	Ahmad Ashfa	L/15	dr.Zaki, Sp.B	243427	Gangrene pedis D	15/01/2026	17/01/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
13	Kholidah	P/60	dr. Anton, Sp.B	149637	TU Mamae D Post Biopsi	16/01/2026	18/01/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	6	6	1
14	M. Baihaki	L/33	dr. Oka, Sp.OT	243522	OF Calcaneus	17/01/2026	19/01/2026	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Wiyadi	L/71	dr.Zaki, Sp.B	212204	Hernia Scrontalis	18/01/2026	20/01/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
16	Sutomo	L/72	dr. Edi, Sp. U	189734	BPH Post TURP	19/01/2026	21/01/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
17	Siti Haniah	P/61	dr. Anton, Sp.B	243929	Gangrene gluteal post excisional debridement	25/01/2026	27/01/2026	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	0,75	2	0,375
18	Retno Wulan	P/52	dr. Arianto, Sp.B	244164	Vulnus Laceratum Ankle	28/01/2026	31/01/2026	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Satria Destiyana	L/20	dr. Kuntadi, Sp. OT	001744	Fractur femur post orif	29/01/2026	31/01/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
20	Moch Soleh	L/69	dr. Pradana, Sp. U	243156	BPH Post TURP	29/01/2026	31/01/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
21	Lailatul Anisah	P/29	dr. Farid, Sp.N	242589	Obs konvulsi susp meningitis	02/01/2026	03/01/2026	2	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Clindamycin		4x0,6	1,8	1,2	1,5
22	Ula Trisnawati	P/43	dr. Andy, Sp.P	242695	Pneumoni	04/01/2026	08/01/2026	5	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Levofloxacin inj		1x0,75	2,25	0,3	7,5
23	Nawi	L/67	dr. Elvi, Sp.P	242851	COPD AE + PVC	07/01/2026	10/01/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
24	Elisya Diah	P/19	dr. Ardhi, Sp. Pd	242948	TF	08/01/2026	10/01/2026	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	1,5	1	1,5
25	Darti	P/60	dr. Ardhi, Sp. Pd	160066	ISK	09/01/2026	12/01/2026	4	Asam Pipemidat	1	2x0,4	2,4	0,8	3

26	Kasiyono	L/66	dr. Heri, Sp. Pd	102729	TF + CKD	09/01/2026	12/01/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	7	2	3,5
27	Abdul Mukti	L/48	dr. Elvi, Sp. P	239951	COPD AE	10/01/2026	13/01/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
28	Kukuh Budi	L/32	dr. Aji, Sp. Pd	243447	Cholelithiasis	16/01/2026	19/11/2026	4	Goforan	1	3x1	7	2	3,5
29	Suhaya	P/53	dr. Andy, Sp. P	240400	Pneumoni + acute respiratory failure + hipokalemi	16/01/2026	21/01/2026	6	Meropenem	1	3x1	12	3	4
30	Bayu P	L/62	dr. Mira, Sp. JP	244154	STEMI inferoposterior	28/01/2026	31/01/2026	4	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Februari 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Emilda	P/32	dr. Humaira, Sp.OG	059432	Post SC + BSC	01/02/2026	04/02/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
2	Siskamarini	P/49	dr. Humaira, Sp.OG	231628	Post Op Histerektomi	02/02/2026	05/02/2026	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Adinda Eka P	P/21	dr. Humaira, Sp. OG	242643	Post Partum	03/02/2026	04/02/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
4	Rusyana	P/29	dr. Aida, Sp.OG	243328	Post SC + KPD	07/02/2026	09/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
5	Nike Ayu K	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	087345	Post SC + BSC	11/02/2026	14/02/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
6	Dwi Aryani	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	245241	Post SC + Oligohidramnion	16/02/2026	18/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Rizky Amalia	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	238182	Gravida SC	20/02/2026	22/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5

8	Sri Indah	P/54	dr. Aida, Sp. OG	245507	Anemia Gravis + Hiperplasia Endometrium	20/02/2026	22/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
9	Dewi Mardiyah	P/28	dr. Humaira, Sp. OG	244121	Post SC + Gemeli + Oligohidramnion	25/02/2026	27/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Diniah C	P/26	dr. Aida, Sp. OG	206748	Post Partum	27/02/2026	28/02/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
11	Sujarwoto Winarno	L/37	dr. Oka, Sp. OT.	124077	Open wound of wrist and hand part, parts unspecified	31/01/2026	02/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Safi'i	L/34	dr. Oka, Sp. OT.	244284	Spontaneous rupture of extensor tendons hand	31/01/2026	02/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
13	Panca Widya	P/56	dr. Oka, Sp. OT.	232628	Removal of fracture plate and other internal fixation device	06/02/2026	08/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
14	Mochammad Hendra	L/24	dr. Arianto, Sp. OT.	242844	Fracture of other toe, pro remove implant	09/02/2026	11/02/2026	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		2x1	2	4	0,5
15	Dewi Kuswatun	P/50	dr. Anton, Sp. B.	176310	Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of limbs	10/02/2026	12/02/2026	3	Ceftizoxime	3	1x1	1	4	0,25
									Ceftizoxime		1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	0,4	1
16	Muhamad Setiyo	P/31	dr. Andi, Sp. B.	244833	Epidermal cyst	11/02/2026	13/02/2026	3	Ceftriaxone	1	1x1	1	2	0,5
17	Arya Abhiseka	L/17	dr. Anton, Sp. B.	080429	Necrotizing fascitis, ankle and foot	14/02/2026	16/02/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,25	2	0,63
18	Sakur	L/59	dr. Kuntadi, Sp. OT.	245210	Traumatic amputation of two or more fingers alone (complete)(partial)	15/02/2026	17/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
19	Wagini	P/53	dr. Anton, Sp. B.	088067	Necrotizing fascitis, lower leg	16/02/2026	18/02/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	7,5	6	1,25
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,5	2	0,75
20	Ria Rovita	P/23	dr. Oka, Sp. OT.	153823	Fracture of clavicle, closed	21/02/2026	23/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67

21	Wartoyo	L/59	dr. Ardhany, Sp. Pd	025367	TF	05/02/2026	08/02/2026	4	Ceftriaxoen	1	2x1	6	2	3
22	Meiyasa A	P/34	dr. Ardhi, Sp. Pd	240288	DF	08/02/2026	11/02/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	3	1	3
23	Rosmawarni	P/51	dr. Heri, Sp.Pd	037536	Nefrolitiasis	08/02/2026	11/02/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,8	0,8	3,5
24	Gloriyan R	L/33	dr. Aji, Sp. Pd	086157	Cholelitis	09/02/2026	13/02/2026	5	Cefotaxime	1	3x1	11	2	5,5
25	Hawa Miftakhul	P/30	dr. Elvi, Sp. P	240342	Asma	10/02/2026	12/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
26	Wijiono	L/54	Dr. Ardhi, Sp. Pd	245087	DM + CKD	14/02/2026	16/02/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	0,8	0,8	1
27	Sumpah Kasiani	P/68	Dr. Andy, Sp. P	132666	COPD AE	14/02/2026	17/02/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
28	Abd. Khojin	L/62	dr. Andy, Sp. P	245187	Pneumoni	15/02/2026	17/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
29	Lutfazad	L/46	dr. Zora, Sp.Pd	202085	Pneumonia	15/02/2026	19/02/2026	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
30	Eddy Kartono	L/71	dr. Farid, Sp. N	073755	Susp massa cerebellum + susp pneumonia	19/02/2026	26/02/2026	8	Cefoperazone	1	2x1	5	4	1,25

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Dian Kodrat	P/31	dr. Aida, Sp.OG	142487	Mio – adenomyoma	01/03/2026	04/03/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
2	Silva Yuli	P/31	dr. Aida, Sp.OG	177196	Post SC + BSC	02/03/2026	04/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,75
3	Ayu Fidya	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	224081	Gravida SC	14/03/2026	16/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
4	Puput Murniati	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	246431	Post Curetage + Misseda Abortion	16/03/2026	17/03/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1	1,5	0,67

5	Uswatun Chasanah	P/35	dr. Humaira, Sp. OG	176626	Post SC + Plasenta Previa	16/03/2026	18/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Aristianti A	P/30	dr. Aida, Sp. OG	240863	Post SC + KPD	16/03/2026	18/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Irma Setyowati	P/22	dr. Aida, Sp. OG	246537	Post SC + KPD	18/03/2026	20/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Laili Nisfi	P/30	dr. Humaira, Sp. OG	223910	Post SC + Oligohidramnion	25/03/2026	27/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Sunarti	P/40	dr. Humaira, Sp. OG	239363	Post Curetage Menometroragia	30/03/2026	31/03/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
10	Lia Setianingrum	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	113940	Post Partum	30/03/2026	31/03/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
11	Budi Winarto	L/60	dr. Arianto, Sp. OT.	075676	Cruss injury manus (S) digiti 1	05/03/2026	07/03/2026	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,2
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
12	Supingah	P/57	dr. Andi, Sp. B	246148	Peritonitis generalisata ec appendicitis perforasi	09/03/2026	11/03/2026	3	Ceftriaxone	1	1x2	2	2	2
13	Suriadi	L/51	dr. Pradana, Sp. U	229693	BPH	10/03/2026	12/03/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
14	Ahmad Taufiq	L/24	dr. Oka, Sp. OT.	246282	Partial ruptur tendon extensor	12/03/2026	14/03/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
15	Dani Abednego	L/21	dr. Oka, Sp. OT.	229394	Union radius fracture of lower end of radius	13/03/2026	15/03/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
16	Andry Muji A	L/44	Dr. Edi, Sp. U	110993	Batu Ureter	16/03/2026	18/03/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
17	Ediyanto	L/48	dr. Oka, Sp. OT.	192204	Ruptur quadiceps tendon	23/03/2026	25/03/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
18	Suparti	P/63	dr. Anton, Sp. B.	061659	Necrotizing fascitis S + DM Hiperglikemi	25/03/2026	27/03/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,25	2	0,63
19	Wiyung Krisbantoro	L/26	dr. Oka, Sp. OT.	230940	Traumatic amputation manus	27/03/2026	28/03/2026	2	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67

20	Sungkono	L/44	dr. Fachriy,Sp.BS.	246913	Multiple open wound parietal	28/03/2026	30/03/2026	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
21	Moeljadi	L/86	dr. Andy, Sp. P	146401	Pneumonia + Takikardi + Sepsis	02/03/2026	05/03/2026	4	Meropenem	1	2x1	6	3	2
22	Atim	P/89	dr. Miryanti, Sp. JP	245949	HF + ISK	03/03/2026	05/03/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
23	Jamiah	P/59	dr. Zora, Sp. Pd	229778	DM Hiperglikemi + UTI	04/03/2026	07/03/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	2,5	1	2,5
24	Djoko Utomo	L/53	dr. Ardhi, Sp.Pd	037689	Selulitis regio cruris dextra et sisnista	08/03/2026	11/03/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Levofloxacin PO		1x0,5	1,5	0,8	3,5
25	Kasan	L/77	dr. Farid, Sp.N	240824	CVA Infark + Parkinson'S Disease + Pneumonia	10/03/2026	12/03/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
26	Suyono	L/56	dr. Ard hany, Sp.Pd	218744	Fatty liver + Nephrolithiasis	10/03/2026	13/03/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2
27	Mujiono	L/58	dr. Heri, Sp. Pd	208041	DM Type 2 + Cystitis	12/03/2026	15/03/2026	4	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,6	0,8	2
28	Kastomo	L/70	dr. Andy, Sp. P	065312	COPD eksaserbasim akut + AF	17/03/2026	19/03/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
29	Farhan B	L/23	dr. Ardhi, Sp. Pd	105814	GEA + Diarrhea	23/03/2026	26/02/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	3	1	3
30	Buari	L/73	dr. Elvi, Sp. P	246785	COPD AE	25/03/2026	27/03/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

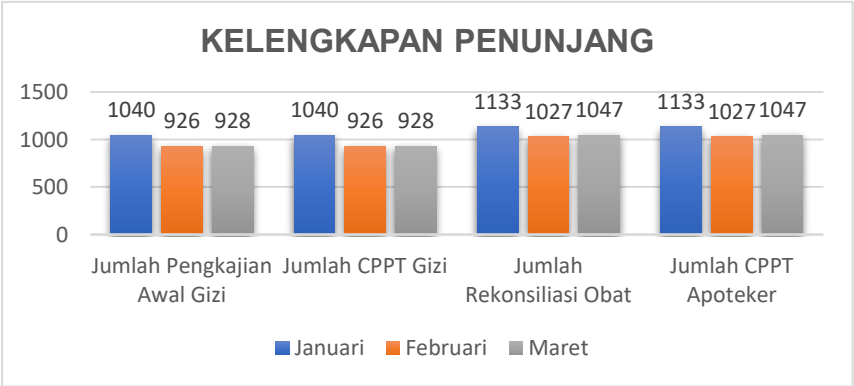
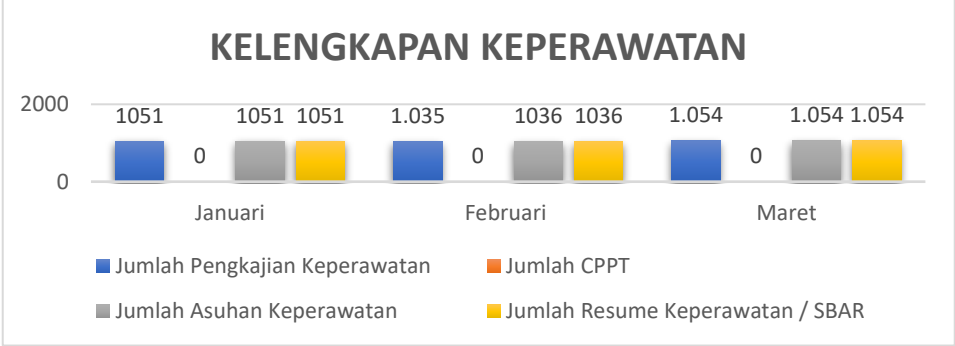
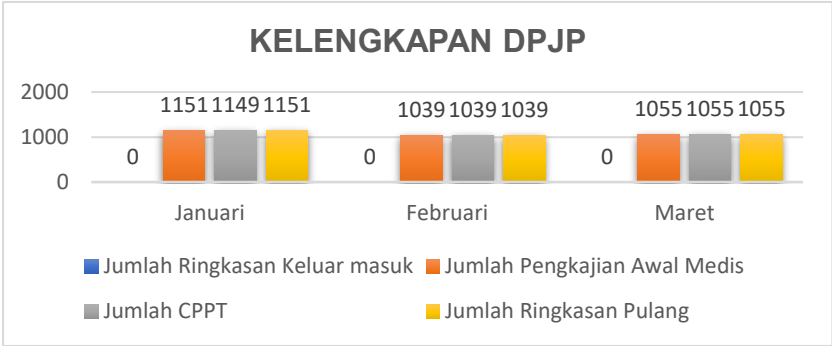
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	: 920	84	119	16%	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

3.1.1.3 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan tertinggi poli per poli : IGD dan IRJA
- 2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 98% pada Bulan Maret 2026.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Maret 2026.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.25 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Form ERM di IKO ada yang belum bisa diisi	P	- ERM perioperatif belum bisa digunakan - ERM pengkajian pra anestesi: perawat tidak punya hak akses untuk edit nama tim, saran disamakan otomatis dengan laporan operasi - Penandaan di ERM belum seragam ada yg menggunakan garis ada yg menggunakan blok kuning
		D	Laporkan ke programmer untuk masuk waiting list tindak lanjut
		S	Untuk penandaan di ERM, review SPO penandaan dan sosialisasi ulang
		A	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ERM di IKO
2	Screw operasi orthopedi beberapa ada yang kosong dan tidak ready saat akan digunakan untuk operasi	P	Screw operasi orthopedi beberapa ada yang kosong dan tidak ready saat akan digunakan untuk operasi
		D	dr. Kuntadi, SPOT komplain karena screw banyak yang tidak tersedia apalagi implant besar
		S	Koordinasi dengan Gudang farmasi agar ada backp up untuk screw
		A	Follow up dan monitoring stok screw sampai barang datang
3	DPJP komplain karena menginput ERM di laporan operasi sering hilang dan tidak bisa di edit utnuk laporan operasi bagian atas (rencana tanggal operasi, komplikasi dll)	P	DPJP komplain karena menginput ERM di laporan operasi sering hilang dan tidak bisa di edit utnuk laporan operasi bagian atas (rencana tanggal operasi, komplikasi dll)
		D	Koordinasi dengan programmer agar aksesnya bisa oleh dokter maupun perawat IKO
		S	Monitoring jika ada kendala penginputan, karena

			sudah ditindaklanjuti oleh programmer
		A	Koordinasi dengan tim IT untuk memastikan simrs di IKO update

3.7.26 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Pemasangan infus lebih dari 1x	P	Ditemukan beberapa resep pasien ada inputan iv cannul lebih dari 1.
		D	Untuk inputan iv cannul lebih dari 1x, bisa jadi karena skill kompetensi perawat atau dari segi klinis kondisi pasien yang memang sulit untuk dilakukan infus. Diantaranya pasien dehidrasi berat, syok, obesitas, pasien tidak kooperatif dll
		S	Koordinasi Kabid dengan karu untuk identifikasi pasien dengan pemasangan infus lebih dari 2x, agar terdata dan jelas alasannya
		A	Hasil akan direkap selama satu bulan, berapa kali kejadian infus lebih dari 1x.
2	Pengajuan dokter resign ada 2 orang	P	Berdasarkan hasil rapat dengan kains IGD : 1. dr. Rendra : rencana resign bulan juni-juli 2026. Pengajuan resign per 1 juni 2. dr. Ardi (San) : rencana resign bulan mei-juni 2026, rencana daftar sekolah neurologi di Univ Brawijaya
		D	Pengajuan ke SDM untuk oprec dokter
		S	Lapor ke PT untuk segera open rekrutment
		A	Koordinasi dan follow up sampai pelaksanaan dokter orientasi
3	Pasien rencana rujuk yang tidak diperkenankan menunggu di IGD	P	Pasien advice rujuk dari awal dan DPJP minta untuk tidak boleh pindah ruangan karena takut klaim menjadi rawat jalan
		D	Koordinasi antara dokter casemix dan DPJP agar pasien diidentifikasi permasalahan yang bisa diatasi oleh RS
		S	Koordinasi agar pasien distabilkan dan tidak terburu-buru rujuk karena pertimbangan tidak langsung diterima atau bisa dirujuk penuh per poli
		A	Koordinasi dengan Dokter casemix dan PIPP dilibatkan karena pasien termasuk dalam kriteria kompleks
5	Kunjungan pasien rawat inap dengan tren menurun dari bulan sebelumnya tetapi tidak signifikan	P	Kunjungan pasien rawat inap dengan tren menurun dari bulan sebelumnya 20%
		D	Kunjungan IGD secara keseluruhan meningkat 7,5% dengan jumlah pasien rawat jalan 690 pasien
		S	Monitoring pasien yang indikasi MRS terutama pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan
		A	Koordinasi dengan humas untuk follow up perujuk yang kunjungannya menurun dari bulan sebelumnya

3.7.27 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Absensi visite DPJP	P	Absensi visite kadang tidak muncul tarifnya
		D	Sebagian pasien tidak tervalidasi oleh perawat sehingga tidak muncul di tagihan
		S	Koordinasi dengan programmer untuk mengidentifikasi kendala selama proses absensi
		A	Follow up tindaklanjut dari programmer dan eksekusi saat ada case
2.	HP ruangan sering tidak terhubung dengan WIFI, sehingga tidak mendukung proses tanda tangan digital pada ERM.	P	HP ruangan sering tidak terhubung dengan WIFI, sehingga tidak mendukung proses tanda tangan digital pada ERM
		D	Komunikasi dan koordinasi dengan IT dan Kabid umum, agar internet di NS harus stabil
		S	Apabila internet dan HP tidak support, harus diberikan alternatif lain seperti penginstallan di HP pribadi (Karu . PJ shift) hanya untuk back up tanda tangan jika jaringan lemah
		A	Monitoring dan supervisi dari bagian IT untuk kestabilan internet di seluruh ruangan NS rawat inap
3.	Saat visite pagi, petugas gizi dan apoteker datang bersamaan, sehingga penggunaan komputer harus bergantian. Hal ini kadang menghambat pelaporan kondisi pasien atau hasil penunjang.	P	Komputer rawat inap untuk fasilitas ERM adalah 2 tiap ruangan
		D	Visite oleh apoteker dan gizi adalah elektif dan bisa dikondisikan agar tidak bersamaan dengan visite DPJP
		S	Koordinasi dengan karu gizi dan kains apoteker agar bisa akses ERM lewat komputer selain di NS.
		A	Alternatif lain untuk computer, bisa kerjasama dengan Karu poli, karena beberapa poli ada yang tidak digunakan sehingga bisa untuk mencicil mengerjakan ERM

3.7.28 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien alih rawat dari poli ke rehab medis tidak terlayani karena program protokol terapi sudah habis	P	Pasien alih rawat dari poli ke rehab medis tidak terlayani karena program protokol terapi sudah habis sehingga dikembalikan ke poli yang merujuk sebelumnya
		D	Untuk protokol fisioterapi sudah ada program tiap pasien berdasarkan pengkajian awal dan re asesmen dari dokter SpKFR
		S	Sosialisasi ulang pada rehab medik dan poli, jika ada pasien yang akan dirujuk ke rehab medis, wajib melihat Riwayat terapi dan boleh konfirmasi ke unit rehab medik agar pasien bisa terlayani
		A	Monitoring dan evaluasi agar tidak terulang
2	Kebijakan konsul internal	P	Pasien poli yang mempunyai rujukan lebih dari satu, untuk kunjungan selanjutnya harus dilakukan konsul internal

		D	Potensi fragmentasi jika diidentifikasi pasien menggunakan 2 rujukan untuk kontrol ke RSPHM
		S	Jika pasien kronis, maka salah satu harus di PRB, jika pasien membutuhkan 2 DPJP sekaligus diberlakukan konsul internal (kecuali rujukan poli gigi), dan monitoring target untuk PRB atau stabilnya kapan
		A	Pasien yang mempunyai 2 rujukan, di list di grup pelayanan yang isinya PDF, Poli , farmasi dan Asce. Diharapkan jika ada pasien dengan 2 rujukan, salah satu harus ditarget dan di warning ke DPJP untuk PRB. Jika tidak bisa di PRB, harus disertakan alasannya.
3	Pasien poli Sakura dengan pemeriksaan penunjang	P	Pasien poli Sakura ada pemeriksaan laboratorium sebelum konsultasi dan masuk poli IPD Sakura. Pasien datang sebelum jam yang ditentukan, kemudian miss komunikasi yang dibawah sehingga pasien menunggu lama di ruang tunggu poli sakura
		D	Identifikasi pasien yang ada pemeriksaan penunjang agar di pastikan dan di kawal untuk jam datang nya agar tidak menunggu lama
		S	Sosialisasi kembali SPO pelayanan poli Sakura, share dengan jelas data pasien di grup Sakura dan diberi noted ke security, pendaftaran dan perawat asisten yang bertugas jika pasien datang untuk pemeriksaan penunjang dulu.
		A	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan poli sakura

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	S1 Kesehatan Lingkungan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	38	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		21	14	7	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0

		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	16	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	14	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	16	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	8	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0

		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	8	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		7	6	1	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	14	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	40	13	7	6	0
		SMA		22	18	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	11	4	2	2	0
		SMA		7	6	1	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	Profesi Ners	10	5	0	5	0
		D3 TVF		2	0	2	0
		D3 Analis Kesehatan		1	0	1	0
		SMK		1	0	1	0
		SKM		1	0	1	
Total Karyawan			368	368	274	94	0
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0

46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			63	63	2	61	0
Total Keseluruhan			431	431	276	155	0

Keterangan :

Pada bulan Maret terdapat 1 staf resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan April 2026 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Maret 2026, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 07 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025